

Buku Referensi

KEPERAWATAN GERONTIK

Strategi, Inovasi, dan Praktik Terbaik

Lexy Oktora Wilda, S.Kep., Ns., M. Kep.



BUKU REFERENSI

KEPERAWATAN GERONTIK

Strategi, Inovasi, dan Praktik Terbaik

Lexy Oktora Wilda, S.Kep., Ns., M. Kep.



**Optimal
Untuk
Negeri**

BUKU REFERENSI
KEPERAWATAN GERONTIK
Strategi, Inovasi, dan Praktik Terbaik

Penulis: Lexy Oktora Wilda, S.Kep., Ns., M. Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Ivan Zumarano

ISBN: 978-634-7294-57-9

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Keperawatan gerontik : strategi, inovasi, dan praktik terbaik : buku referensi / Lexy Oktora Wilda, S.Kep., Ns., M.Kep.
EDISI	Cetakan pertama, Juli 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT. Optimal Untuk Negeri, 2025
DESKRIPSI FISIK	vi, 97 halaman ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7294-57-9
SUBJEK	Usia lanjut - Kesehatan dan kebersihan -- Geriatri -- Gerontologi
KLASIFIKASI	618.970 231 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1247030

Prakata

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Referensi **"KEPERAWATAN GERONTIK: Strategi, Inovasi, dan Praktik Terbaik"** dapat tersusun dan hadir di hadapan pembaca. Buku ini disusun dengan semangat untuk menjawab tantangan kompleks dalam perawatan lansia yang terus meningkat seiring perubahan demografi global. Sebagai karya yang berbasis bukti, buku ini menghadirkan berbagai pendekatan strategis, inovatif, serta praktik klinis terbaru yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan optimal kepada lansia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa perawatan gerontik memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik semata, melainkan juga aspek psikososial, spiritual, dan lingkungan. Oleh karena itu, buku ini disusun dengan mengintegrasikan berbagai hasil penelitian terbaru serta berbagai inovasi dalam teknologi digital dan model kolaborasi interprofesional yang efektif dalam perawatan lansia. Harapannya, melalui buku ini para pembaca, khususnya tenaga kesehatan dan akademisi, dapat memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan lansia secara signifikan.

Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pengembangan ilmu keperawatan gerontik, serta membantu tenaga kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia di Indonesia.

Daftar Isi

Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB 1. Pendahuluan	1
A. Konsep Dasar Keperawatan Gerontik.....	1
B. Tren Demografi dan Implikasinya terhadap Pelayanan Keperawatan	2
C. Manfaat Merawat Lansia dengan Cara yang Terbukti Efektif	3
BAB 2. Perubahan Fisik dan Psikososial pada Lansia	5
A. Anatomi dan Fisiologi Proses Penuaan	5
B. Dampak Perubahan Fisik terhadap Fungsi Harian Lansia	6
BAB 3. Pengelolaan Penyakit Kronis pada Lansia.....	10
A. Hipertensi dan Penyakit Kardiovaskuler.....	10
B. Diabetes Mellitus pada Lansia.....	11
C. Demensia dan Penyakit Alzheimer	13
D. Osteoporosis dan Risiko Fraktur.....	15
E. Arthritis dan Gangguan Mobilitas	16
BAB 4. Pencegahan dan Penanganan Jatuh pada Lansia.....	19
A. Faktor Risiko dan Prediksi Jatuh Pada Lansia.....	19
B. Intervensi Keperawatan dalam Pencegahan Jatuh.....	20
C. Manajemen Cedera Akibat Jatuh	22
BAB 5. Manajemen Nyeri pada Lansia	24
A. Mengenali Rasa Nyeri yang Dirasakan Lansia dengan Tepat.....	24
B. Intervensi Farmakologis dan Non-farmakologis dalam Manajemen Nyeri	25
C. Efektivitas Terapi Komplementer dalam Mengurangi Nyeri	27
BAB 6. Nutrisi dan Hidrasi pada Lansia.....	29
A. Penilaian Nutrisi dan Status Hidrasi	29
B. Intervensi Keperawatan dalam Mengatasi Malnutrisi dan Dehidrasi	30
BAB 7. Tidur dan Gangguan Tidur pada Lansia	33
A. Pola Tidur dan Perubahan Normal pada Lansia.....	33
B. Strategi Keperawatan dalam Mengatasi Insomnia dan Gangguan Tidur Lainnya pada Lansia	34
C. Pengaruh Terapi Non-farmakologis terhadap Kualitas Tidur Lansia.....	36
BAB 8. Keperawatan Kesehatan Mental pada Lansia	39
A. Deteksi Dini dan Penanganan Depresi pada Lansia	39
B. Dukungan Psikososial dan Intervensi Terapi Kognitif Pada Lansia	41
C. Strategi Mengurangi Risiko Bunuh Diri pada Lansia.....	42

BAB 9. Perawatan Paliatif dan End-of-Life Care pada Lansia.....	45
A. Prinsip Perawatan Paliatif	45
B. Strategi Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Paliatif.....	47
C. Perawatan Paliatif dan End-of-Life Care pada Lansia	49
BAB 10. Teknologi dan Inovasi dalam Keperawatan Gerontik.....	52
A. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Keperawatan Lansia	52
B. Telehealth dan Efektivitasnya dalam Perawatan Lansia	54
C. Teknologi Sensor untuk Pemantauan Kesehatan Lansia di Rumah	56
BAB 11. Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan Gerontik	58
A. Model Kolaborasi Interprofesional	58
B. Strategi Meningkatkan Kualitas Perawatan Melalui Kolaborasi Antarprofesi	60
C. Contoh Keberhasilan Kerja Sama Lintas Profesi dalam Pelayanan Kesehatan	62
BAB 12. Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan Gerontik	65
A. Model Pembelajaran Berbasis Kompetensi dalam Keperawatan Lansia	65
B. Strategi Edukasi dalam Pelatihan Keperawatan Gerontik	67
C. Evaluasi Efektivitas Program Pelatihan Keperawatan Gerontik.....	69
BAB 13. Etika dan Isu Hukum dalam Pelayanan Keperawatan Lansia	72
A. Isu Etika dalam Pelayanan Keperawatan Gerontik	72
B. Hak Lansia dalam Perawatan dan Perlindungan Hukum	74
C. Penyelesaian Dilema Etik Berbasis Kasus	76
BAB 14. Tantangan dan Prospek Masa Depan Keperawatan Gerontik	79
A. Tantangan dalam Implementasi	79
B. Prospek dan Arah Pengembangan Pelayanan Keperawatan Gerontik	80
C. Hal-Hal yang Perlu Dilakukan ke depannya agar Perawatan Lansia Lebih Baik.	81
BAB 15. Penutup	83
Referensi	85
Glosarium.....	88
Profil Penulis	90

BAB 1.

Pendahuluan

A. Konsep Dasar Keperawatan Gerontik

Keperawatan gerontik adalah bidang keperawatan khusus yang berfokus pada perawatan dan pengelolaan kesehatan lansia, melibatkan pemahaman yang mendalam tentang proses penuaan serta dampaknya terhadap kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual lansia (Hirst & Lane, 2023). Dalam konteks global, peningkatan jumlah lansia membawa tantangan tersendiri terhadap sistem pelayanan kesehatan, sehingga menuntut adanya perawatan khusus yang berbasis bukti untuk meningkatkan kualitas hidup mereka (Lange, Hamer, & Reijneveld, 2022).

Konsep dasar keperawatan gerontik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perubahan fisiologis, psikologis, sosial, dan lingkungan yang dialami lansia. Perawat gerontik bertanggung jawab tidak hanya dalam memberikan perawatan fisik, tetapi juga berperan aktif dalam mengatasi masalah psikososial, pencegahan penyakit, rehabilitasi, dan promosi kesehatan secara holistik (Duran & Topçu, 2021). Praktik keperawatan gerontik menekankan pendekatan holistik yang mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal, seperti nilai budaya, pola kehidupan keluarga, dan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kesehatan lansia (Maatouk et al., 2022).

Praktik keperawatan gerontik modern semakin mengadopsi model keperawatan berbasis bukti, yang didukung oleh hasil penelitian ilmiah terbaru. Strategi intervensi berbasis bukti dalam keperawatan gerontik terbukti efektif dalam meningkatkan kemandirian lansia, mengurangi morbiditas, serta meningkatkan kepuasan hidup lansia secara keseluruhan (Davies & James, 2021). Dalam konteks Indonesia, tantangan utama praktik keperawatan gerontik mencakup kurangnya jumlah tenaga keperawatan terlatih, terbatasnya sarana dan prasarana, serta masih minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perawatan berbasis evidensi untuk lansia (Wulandari & Putri, 2020).

Secara umum, konsep dasar keperawatan gerontik dapat dirangkum dalam empat dimensi utama, yaitu: (1) promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, (2) manajemen penyakit kronis dan akut, (3) dukungan sosial-emosional, dan (4) pemberdayaan lansia dalam kehidupan sehari-hari (Ishii et al., 2020). Keselarasan antara empat dimensi ini menciptakan fondasi praktik keperawatan gerontik yang efektif dan humanistik.

Dalam menghadapi tantangan global terkait pertumbuhan populasi lansia, perawat gerontik harus mampu memanfaatkan penelitian terbaru sebagai dasar pengambilan keputusan klinis dan implementasi praktik keperawatan yang optimal. Kompetensi inti perawat gerontik mencakup keterampilan asesmen komprehensif, pemahaman terhadap kondisi medis yang khas pada lansia, penerapan intervensi multidimensi, dan kolaborasi interprofesional (Schoberer et al., 2023).

Secara keseluruhan, keperawatan gerontik menjadi bagian integral dalam pelayanan kesehatan yang menjawab tantangan kompleksitas kebutuhan lansia melalui pendekatan berbasis bukti, holistik, serta adaptif terhadap perubahan sosial, demografis, dan teknologi terkini.

B. Tren Demografi dan Implikasinya terhadap Pelayanan Keperawatan

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia mengalami perubahan demografi yang signifikan dengan peningkatan jumlah lansia secara global. Fenomena ini dikenal dengan istilah *aging population*, di mana jumlah individu yang berusia di atas 60 tahun mengalami peningkatan pesat dibandingkan kelompok usia lainnya (United Nations, 2022). Secara global, populasi lansia diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dari 1 miliar pada tahun 2020 menjadi sekitar 2,1 miliar pada tahun 2050, yang secara signifikan akan membebani berbagai sistem kesehatan dan pelayanan sosial (World Health Organization [WHO], 2021).

Di Indonesia, tren demografi yang sama juga terjadi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2023), proporsi penduduk lansia (usia ≥ 60 tahun) di Indonesia meningkat menjadi 10,48% pada tahun 2022, dibandingkan 9,78% pada tahun 2020. Kenaikan ini menandakan Indonesia mulai memasuki era populasi menua (*aging population*). Situasi ini menghadirkan berbagai implikasi terhadap pelayanan kesehatan, khususnya keperawatan, karena kelompok lansia memiliki kebutuhan kesehatan yang kompleks akibat meningkatnya prevalensi penyakit kronis dan degeneratif (Saputra & Anwar, 2021).

Implikasi dari tren demografi ini terhadap pelayanan keperawatan sangat luas dan mendalam. Pertama, peningkatan populasi lansia berdampak pada kebutuhan tenaga perawat gerontik yang lebih besar. Studi terbaru menunjukkan bahwa kebutuhan akan perawat terampil yang khusus menangani perawatan lansia terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan kelompok lansia yang membutuhkan layanan kesehatan intensif dan spesifik (Chan et al., 2022). Perawat gerontik harus memiliki kompetensi khusus, termasuk keterampilan asesmen holistik, manajemen penyakit kronis, komunikasi efektif, serta pemberdayaan lansia dan keluarganya.

Kedua, perubahan demografi ini juga memicu peningkatan biaya pelayanan kesehatan secara substansial. Lansia umumnya menghadapi berbagai tantangan kesehatan kompleks yang membutuhkan perawatan jangka panjang, rehabilitasi, serta intervensi medis yang lebih intensif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa

negara-negara dengan populasi lansia yang besar menghadapi tantangan keuangan dalam membiayai perawatan kesehatan lansia (Rahman et al., 2021). Oleh sebab itu, peran perawat dalam promosi kesehatan, pencegahan penyakit, dan pengelolaan mandiri oleh lansia menjadi semakin penting untuk mengurangi biaya pelayanan kesehatan secara keseluruhan.

Ketiga, implikasi demografi ini juga mendorong pengembangan pelayanan keperawatan berbasis komunitas. Untuk menghadapi tantangan populasi lansia yang meningkat, model perawatan komunitas yang menekankan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, serta pemberdayaan komunitas semakin dikembangkan (Liu, Yang, & Sun, 2020). Strategi ini memungkinkan lansia menjalani kehidupan yang lebih aktif, sehat, dan mandiri di lingkungan mereka sendiri sehingga mengurangi kebutuhan akan layanan institusional.

Terakhir, tren demografi ini mendorong munculnya inovasi dalam pelayanan kesehatan, seperti telehealth, perawatan berbasis teknologi, serta intervensi digital. Teknologi menjadi bagian integral dalam pelayanan keperawatan lansia untuk memastikan akses perawatan yang lebih baik, efisien, dan efektif dalam situasi keterbatasan sumber daya manusia dan geografis (Doraiswamy et al., 2020).

Oleh karena itu, tren demografi ini harus disikapi secara serius melalui penguatan sistem pelayanan keperawatan, peningkatan kompetensi perawat gerontik, serta pengembangan kebijakan yang mendukung pelayanan kesehatan lansia secara komprehensif dan berkelanjutan.

C. Manfaat Merawat Lansia dengan Cara yang Terbukti Efektif

Praktik Keperawatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Nursing/EBN) merupakan pendekatan yang secara sistematis mengintegrasikan hasil penelitian terbaru, pengalaman klinis, dan preferensi pasien dalam proses pengambilan keputusan klinis (LoBiondo-Wood & Haber, 2021). Dalam konteks pelayanan keperawatan lansia, praktik berbasis bukti memiliki signifikansi yang besar mengingat kompleksitas kondisi kesehatan lansia yang memerlukan pendekatan multidimensi, spesifik, dan berbasis hasil penelitian terbaru untuk memberikan pelayanan yang optimal (Milisen et al., 2021).

Pelayanan keperawatan lansia yang berbasis bukti tidak hanya berdampak positif pada hasil klinis, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi berbasis bukti dalam pengelolaan nyeri, pencegahan jatuh, serta manajemen penyakit kronis dapat secara signifikan menurunkan tingkat komplikasi, meningkatkan independensi lansia, serta mempercepat proses pemulihan (Brown & Bowles, 2021; Li, Zhang, & Huang, 2020). Sebaliknya, praktik keperawatan yang tidak didukung oleh bukti ilmiah terkini dapat menyebabkan risiko komplikasi lebih tinggi, kualitas hidup yang buruk, serta meningkatnya beban biaya pelayanan kesehatan (Köhler et al., 2021).

Signifikansi praktik keperawatan berbasis bukti dalam pelayanan lansia juga tercermin dalam peningkatan efisiensi sumber daya yang terbatas. Dengan menggunakan pedoman klinis berbasis bukti, perawat gerontik dapat mengurangi penggunaan intervensi yang tidak efektif, sehingga dapat mengalokasikan waktu dan sumber daya secara lebih efektif untuk kebutuhan prioritas lainnya (Scott et al., 2022). Selain itu, pendekatan berbasis bukti memungkinkan tim keperawatan lebih percaya diri dalam melakukan praktik keperawatan, karena keputusan klinis yang diambil didukung oleh hasil penelitian yang valid, terpercaya, dan terbaru (Yang et al., 2020).

Implementasi praktik keperawatan berbasis bukti di kalangan perawat gerontik masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain kurangnya akses terhadap literatur ilmiah terbaru, keterbatasan waktu dalam mencari bukti ilmiah, serta rendahnya kesadaran tentang pentingnya praktik berbasis bukti (Aguirre-Duarte et al., 2022). Oleh karena itu, institusi pelayanan kesehatan perlu menyediakan pelatihan dan edukasi berkelanjutan bagi perawat gerontik mengenai metode pencarian, penilaian kritis, serta aplikasi bukti ilmiah ke dalam praktik keperawatan sehari-hari.

Selain itu, peran kepemimpinan keperawatan sangat penting dalam menciptakan budaya organisasi yang mendukung penerapan praktik berbasis bukti secara konsisten. Dukungan dari pemimpin klinis yang kuat dapat meningkatkan motivasi perawat dalam menerapkan intervensi berbasis bukti serta menjamin kesinambungan penerapan strategi berbasis bukti dalam jangka panjang (Weiss et al., 2021). Dengan demikian, pemimpin klinis dan manajerial dalam keperawatan memiliki peran strategis dalam implementasi praktik berbasis bukti di lingkungan pelayanan lansia.

Secara keseluruhan, signifikansi praktik keperawatan berbasis bukti dalam pelayanan lansia tidak terbatas hanya pada peningkatan kualitas perawatan klinis, namun juga pada efisiensi sumber daya, peningkatan kepercayaan diri perawat, serta optimalisasi hasil kesehatan lansia secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan implementasi praktik berbasis bukti harus menjadi prioritas dalam pengembangan sistem pelayanan keperawatan gerontik yang berkualitas tinggi di Indonesia.

BAB 2.

Perubahan Fisik dan Psikososial pada Lansia

A. Anatomi dan Fisiologi Proses Penuaan

Penuaan merupakan proses fisiologis kompleks yang ditandai dengan penurunan progresif pada struktur dan fungsi berbagai sistem organ tubuh manusia. Proses ini melibatkan serangkaian perubahan anatomi dan fisiologi yang berkontribusi pada meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit serta gangguan fungsi pada lansia (Rudnicka et al., 2020).

Secara anatomi, penuaan memengaruhi hampir semua sistem tubuh, termasuk integumen, muskuloskeletal, kardiovaskuler, respirasi, gastrointestinal, urogenital, neurologis, dan endokrin (Farage et al., 2022). Sistem integumen, misalnya, mengalami penipisan lapisan epidermis dan dermis, penurunan elastisitas kulit, serta menurunnya kemampuan penyembuhan luka (Blume-Peytavi et al., 2022). Pada sistem muskuloskeletal, terjadi penurunan massa otot atau sarkopenia, berkurangnya densitas tulang yang menyebabkan osteoporosis, serta degenerasi sendi yang meningkatkan risiko osteoarthritis dan penurunan mobilitas pada lansia (Kwak et al., 2022).

Perubahan anatomi yang signifikan juga terjadi pada sistem kardiovaskuler. Lansia umumnya mengalami penebalan dinding pembuluh darah, peningkatan kekakuan arteri, serta penurunan elastisitas jantung, yang menyebabkan meningkatnya tekanan darah sistolik dan menurunnya kapasitas adaptasi terhadap stres fisik maupun emosional (Jani & Rajkumar, 2021). Sistem respirasi mengalami penurunan kapasitas vital paru-paru, penurunan elastisitas jaringan paru, serta melemahnya kekuatan otot-otot pernapasan yang menyebabkan lansia lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan dan pneumonia (Korytowska et al., 2022).

Fisiologis, penuaan ditandai oleh penurunan fungsi seluler dan molekuler yang mencakup perubahan dalam regulasi inflamasi, kerusakan DNA, stres oksidatif, dan penurunan aktivitas hormonal. Stres oksidatif, misalnya, berkontribusi terhadap penuaan dengan menyebabkan kerusakan seluler yang progresif, disertai gangguan fungsi mitokondria yang mempengaruhi energi dan metabolisme seluler secara keseluruhan (Finkel, 2022). Penurunan kadar hormon seperti estrogen, testosteron,

dan hormon pertumbuhan juga memainkan peran penting dalam percepatan proses degenerasi organ tubuh (Sato et al., 2021).

Secara neurologis, proses penuaan ditandai dengan perubahan anatomis dan fungsional pada otak dan sistem saraf, termasuk pengecilan volume otak (atrofi), berkurangnya jumlah neuron, serta gangguan neurotransmisi yang dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif, koordinasi motorik, dan keseimbangan (Vinke et al., 2021). Perubahan neurologis ini juga berdampak pada kemampuan lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan meningkatkan risiko gangguan neurodegeneratif seperti demensia dan Alzheimer (Livingston et al., 2020).

Pada sistem gastrointestinal, lansia mengalami penurunan motilitas usus, penurunan produksi asam lambung, serta penyerapan nutrisi yang lebih rendah, menyebabkan risiko malnutrisi yang lebih tinggi. Demikian pula, pada sistem urogenital, terjadi atrofi ginjal, penurunan filtrasi glomerulus, dan peningkatan risiko inkontinensia urin akibat melemahnya otot dasar panggul (Yamamoto et al., 2022).

Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi proses penuaan sangat penting bagi tenaga keperawatan gerontik dalam melakukan asesmen yang akurat serta merancang intervensi keperawatan yang tepat untuk mencegah komplikasi dan mempertahankan kualitas hidup lansia.

B. Dampak Perubahan Fisik terhadap Fungsi Harian Lansia

Perubahan fisik yang terjadi seiring dengan proses penuaan secara signifikan memengaruhi kapasitas lansia dalam menjalankan fungsi harian mereka. Fungsi harian atau aktivitas kehidupan sehari-hari (Activities of Daily Living/ADL) meliputi kemampuan dasar seperti mandi, berpakaian, makan, mobilisasi, dan menggunakan toilet (Mehta et al., 2021). Lansia yang mengalami perubahan fisik secara progresif cenderung menghadapi berbagai hambatan dalam mempertahankan kemandirian dalam melakukan aktivitas tersebut.

Salah satu perubahan fisik utama yang mempengaruhi fungsi harian lansia adalah penurunan massa dan kekuatan otot atau sarkopenia. Sarkopenia dikaitkan erat dengan penurunan kemampuan mobilisasi, yang meningkatkan risiko jatuh, keterbatasan aktivitas fisik, serta hilangnya independensi dalam kehidupan sehari-hari (Yeung, Reijnierse, Pham, & Maier, 2019). Menurut penelitian terbaru, sarkopenia secara signifikan berkontribusi pada ketergantungan lansia terhadap bantuan orang lain dan meningkatkan kebutuhan akan pelayanan perawatan jangka panjang (Mayhew et al., 2021).

Selain sarkopenia, perubahan pada sistem muskuloskeletal seperti osteoarthritis dan osteoporosis juga memiliki dampak besar terhadap fungsi harian.

Osteoarthritis menyebabkan nyeri kronis dan penurunan mobilitas sendi, sehingga aktivitas seperti berjalan, naik tangga, dan berpindah posisi menjadi sulit bagi lansia (Chen, Zheng, & Shen, 2022). Sementara osteoporosis yang meningkatkan risiko fraktur tulang menyebabkan keterbatasan dalam gerakan, rasa takut untuk bergerak, serta kecenderungan untuk menghindari aktivitas fisik, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan (Clynes, Edwards, Buehring, Dennison, & Binkley, 2020).

Perubahan fisik lainnya yang mempengaruhi fungsi harian lansia adalah penurunan fungsi kardiovaskular dan respirasi. Penurunan kapasitas jantung dan paru-paru menyebabkan lansia mudah mengalami kelelahan, sesak napas, serta berkurangnya daya tahan fisik, sehingga aktivitas sederhana seperti berbelanja, memasak, atau membersihkan rumah menjadi tantangan besar (Forman et al., 2021). Dampak lanjutan dari keterbatasan ini adalah berkurangnya partisipasi sosial lansia, isolasi sosial, dan penurunan kesehatan mental.

Masalah inkontinensia urin akibat perubahan sistem urogenital juga sangat berpengaruh terhadap fungsi harian lansia. Kondisi ini sering menyebabkan lansia merasa tidak nyaman atau malu dalam berinteraksi sosial, membatasi aktivitas di luar rumah, dan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, yang selanjutnya menurunkan kualitas hidup mereka (Coyne et al., 2022).

Dalam aspek neurologis, perubahan fisik yang ditandai dengan gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik meningkatkan risiko jatuh dan cedera pada lansia. Jatuh tidak hanya menyebabkan cedera fisik tetapi juga berdampak psikologis seperti rasa takut jatuh kembali, yang kemudian mengurangi mobilitas dan aktivitas fisik lansia secara signifikan (Rubenstein, 2021).

Untuk mengurangi dampak perubahan fisik ini terhadap fungsi harian, diperlukan intervensi yang berbasis bukti seperti latihan kekuatan otot (*resistance training*), terapi rehabilitasi yang teratur, serta pengelolaan nyeri secara efektif melalui intervensi farmakologis maupun nonfarmakologis (Briggs et al., 2021). Edukasi dan dukungan sosial yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat gerontik, juga memiliki peran penting dalam membantu lansia beradaptasi dengan perubahan fisik tersebut untuk mempertahankan fungsi harian serta kualitas hidup mereka.

Kesimpulannya, perubahan fisik yang dialami oleh lansia berdampak signifikan terhadap kemampuan mereka menjalankan fungsi harian secara mandiri. Pemahaman yang komprehensif tentang dampak ini membantu perawat gerontik dalam memberikan perawatan berbasis bukti yang efektif, adaptif, dan personal bagi lansia.

2.2 Dampak Perubahan Fisik terhadap Fungsi Harian Lansia

Perubahan fisik yang terjadi seiring dengan proses penuaan secara signifikan memengaruhi kapasitas lansia dalam menjalankan fungsi harian mereka. Fungsi harian atau aktivitas kehidupan sehari-hari (Activities of Daily Living/ADL) meliputi kemampuan dasar seperti mandi, berpakaian, makan, mobilisasi, dan menggunakan toilet (Mehta et al., 2021). Lansia yang mengalami perubahan fisik secara progresif cenderung menghadapi berbagai hambatan dalam mempertahankan kemandirian dalam melakukan aktivitas tersebut.

Salah satu perubahan fisik utama yang mempengaruhi fungsi harian lansia adalah penurunan massa dan kekuatan otot atau sarkopenia. Sarkopenia dikaitkan erat dengan penurunan kemampuan mobilisasi, yang meningkatkan risiko jatuh, keterbatasan aktivitas fisik, serta hilangnya independensi dalam kehidupan sehari-hari (Yeung, Reijnierse, Pham, & Maier, 2019). Menurut penelitian terbaru, sarkopenia secara signifikan berkontribusi pada ketergantungan lansia terhadap bantuan orang lain dan meningkatkan kebutuhan akan pelayanan perawatan jangka panjang (Mayhew et al., 2021).

Selain sarkopenia, perubahan pada sistem muskuloskeletal seperti osteoarthritis dan osteoporosis juga memiliki dampak besar terhadap fungsi harian. Osteoarthritis menyebabkan nyeri kronis dan penurunan mobilitas sendi, sehingga aktivitas seperti berjalan, naik tangga, dan berpindah posisi menjadi sulit bagi lansia (Chen, Zheng, & Shen, 2022). Sementara osteoporosis yang meningkatkan risiko fraktur tulang menyebabkan keterbatasan dalam gerakan, rasa takut untuk bergerak, serta kecenderungan untuk menghindari aktivitas fisik, yang pada akhirnya menurunkan kualitas hidup secara keseluruhan (Clynes, Edwards, Buehring, Dennison, & Binkley, 2020).

Perubahan fisik lainnya yang mempengaruhi fungsi harian lansia adalah penurunan fungsi kardiovaskular dan respirasi. Penurunan kapasitas jantung dan paru-paru menyebabkan lansia mudah mengalami kelelahan, sesak napas, serta berkurangnya daya tahan fisik, sehingga aktivitas sederhana seperti berbelanja, memasak, atau membersihkan rumah menjadi tantangan besar (Forman et al., 2021). Dampak lanjutan dari keterbatasan ini adalah berkurangnya partisipasi sosial lansia, isolasi sosial, dan penurunan kesehatan mental.

Masalah inkontinensia urin akibat perubahan sistem urogenital juga sangat berpengaruh terhadap fungsi harian lansia. Kondisi ini sering menyebabkan lansia merasa tidak nyaman atau malu dalam berinteraksi sosial, membatasi aktivitas di luar rumah, dan menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, yang selanjutnya menurunkan kualitas hidup mereka (Coyne et al., 2022).

Dalam aspek neurologis, perubahan fisik yang ditandai dengan gangguan keseimbangan dan koordinasi motorik meningkatkan risiko jatuh dan cedera pada lansia. Jatuh tidak hanya menyebabkan cedera fisik tetapi juga berdampak psikologis seperti rasa takut jatuh kembali, yang kemudian mengurangi mobilitas dan aktivitas fisik lansia secara signifikan (Rubenstein, 2021).

Untuk mengurangi dampak perubahan fisik ini terhadap fungsi harian, diperlukan intervensi yang berbasis bukti seperti latihan kekuatan otot (resistance training), terapi rehabilitasi yang teratur, serta pengelolaan nyeri secara efektif melalui intervensi farmakologis maupun nonfarmakologis (Briggs et al., 2021). Edukasi dan dukungan sosial yang diberikan oleh tenaga kesehatan, khususnya perawat gerontik, juga memiliki peran penting dalam membantu lansia beradaptasi dengan perubahan fisik tersebut untuk mempertahankan fungsi harian serta kualitas hidup mereka.

Kesimpulannya, perubahan fisik yang dialami oleh lansia berdampak signifikan terhadap kemampuan mereka menjalankan fungsi harian secara mandiri. Pemahaman yang komprehensif tentang dampak ini membantu perawat gerontik dalam memberikan perawatan berbasis bukti yang efektif, adaptif, dan personal bagi lansia.

BAB 3.

Pengelolaan Penyakit Kronis pada Lansia

A. Hipertensi dan Penyakit Kardiovaskuler

Hipertensi dan penyakit kardiovaskuler merupakan kondisi kronis yang prevalensinya meningkat seiring bertambahnya usia. Pada populasi lansia, kedua kondisi ini merupakan penyebab utama morbiditas, mortalitas, serta penurunan kualitas hidup (Mills et al., 2020). Hipertensi ditandai oleh tekanan darah yang meningkat secara persisten, yaitu tekanan sistolik ≥ 140 mmHg dan/atau tekanan diastolik ≥ 90 mmHg (WHO, 2021). Kondisi ini sering kali menjadi faktor risiko utama berbagai komplikasi kardiovaskuler seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal kronis (Buford, 2020).

Peningkatan prevalensi hipertensi pada lansia disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain penurunan elastisitas pembuluh darah, peningkatan resistensi perifer, serta gangguan regulasi sistem saraf otonom (Oliveros et al., 2020). Pada lansia, hipertensi sering kali tidak terdeteksi karena gejalanya tidak spesifik atau dianggap sebagai bagian normal dari penuaan, sehingga diagnosis dini melalui skrining tekanan darah rutin menjadi sangat penting dalam mencegah komplikasi lanjut (Whelton et al., 2022).

Penyakit kardiovaskuler pada lansia umumnya melibatkan gangguan fungsi jantung seperti gagal jantung kongestif, penyakit arteri koroner, serta aritmia jantung. Faktor risiko utama penyakit ini meliputi hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, gaya hidup tidak sehat, serta riwayat keluarga dengan penyakit jantung (Forman et al., 2021). Pada lansia, proses penuaan sendiri meningkatkan risiko kardiovaskuler melalui mekanisme inflamasi kronis, disfungsi endotelial, serta perubahan struktur miokardium yang menyebabkan peningkatan kekakuan jantung dan penurunan efisiensi pemompaan darah (Khan & Singer, 2022).

Pengelolaan hipertensi dan penyakit kardiovaskuler pada lansia memerlukan pendekatan holistik yang meliputi intervensi farmakologis maupun non-farmakologis. Terapi farmakologis hipertensi pada lansia umumnya melibatkan

penggunaan obat-obatan seperti diuretik, inhibitor ACE, antagonis reseptor angiotensin II (ARB), dan antagonis kalsium yang dipilih berdasarkan profil klinis pasien serta risiko efek samping (Benetos et al., 2019). Penelitian terbaru menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan terapi antihipertensi pada lansia, mengingat risiko hipotensi ortostatik, gangguan elektrolit, dan interaksi obat akibat polifarmasi (Williamson et al., 2022).

Intervensi non-farmakologis berfokus pada modifikasi gaya hidup, seperti pengaturan diet rendah garam (diet DASH), peningkatan aktivitas fisik, manajemen berat badan, serta penghentian kebiasaan merokok (Buford, 2020). Aktivitas fisik rutin terbukti secara ilmiah mampu memperbaiki fungsi endotel pembuluh darah, mengurangi inflamasi, serta meningkatkan kebugaran kardiovaskuler secara umum pada lansia (Forman et al., 2021).

Selain pengobatan dan modifikasi gaya hidup, peran perawat gerontik sangat penting dalam manajemen hipertensi dan penyakit kardiovaskuler pada lansia. Perawat gerontik bertanggung jawab dalam melakukan asesmen rutin, edukasi pasien dan keluarga, manajemen kepatuhan terhadap terapi, serta deteksi dini terhadap tanda komplikasi kardiovaskuler (Cicolini et al., 2021). Pendekatan multidisiplin dengan kolaborasi antara perawat, dokter, ahli gizi, serta ahli rehabilitasi terbukti efektif dalam meningkatkan hasil klinis dan kualitas hidup lansia yang mengalami hipertensi dan penyakit kardiovaskuler (McDonagh et al., 2021).

Secara keseluruhan, pengelolaan hipertensi dan penyakit kardiovaskuler pada lansia membutuhkan pendekatan yang komprehensif, berbasis bukti, serta sensitif terhadap kebutuhan khusus populasi ini. Perawat gerontik memiliki peran strategis dalam memastikan keberhasilan intervensi kesehatan untuk mengoptimalkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh.

B. Diabetes Mellitus pada Lansia

Diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit metabolik kronis yang prevalensinya meningkat seiring bertambahnya usia. Diabetes pada lansia ditandai oleh gangguan metabolisme glukosa akibat defisiensi insulin, resistensi insulin, atau kombinasi keduanya. Kondisi ini sering menyebabkan berbagai komplikasi yang dapat secara signifikan mempengaruhi kualitas hidup lansia, seperti penyakit kardiovaskuler, neuropati, nefropati, retinopati, serta gangguan mobilitas dan fungsi kognitif (Sinclair et al., 2020).

Menurut International Diabetes Federation (IDF, 2021), prevalensi diabetes pada lansia berusia di atas 65 tahun mencapai sekitar 20% hingga 30% di berbagai negara. Di Indonesia, prevalensi diabetes pada lansia juga mengalami peningkatan pesat seiring dengan transisi demografi dan perubahan gaya hidup, yang mengakibatkan meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas terkait diabetes di populasi ini (Soewondo et al., 2021).

Lansia dengan diabetes menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan penyakit ini, termasuk kerentanan terhadap hipoglikemia, penurunan kapasitas untuk pengelolaan mandiri, serta tingginya risiko komplikasi akibat kondisi komorbid lainnya seperti hipertensi, dislipidemia, dan gangguan fungsi ginjal (Gregg et al., 2021). Lebih lanjut, diabetes pada lansia sering kali disertai penurunan fungsi kognitif yang dapat memperberat kondisi kesehatan, meningkatkan risiko kesalahan pengobatan, serta menurunkan kepatuhan terhadap terapi yang diberikan (Huang et al., 2022).

Prinsip pengelolaan diabetes mellitus pada lansia menekankan pendekatan individual yang mempertimbangkan kondisi klinis, risiko hipoglikemia, kapasitas fungsional, serta harapan hidup pasien. Pedoman klinis terbaru menyarankan target HbA1c yang lebih fleksibel, umumnya sekitar 7,5–8,5%, untuk mengurangi risiko komplikasi hipoglikemia yang lebih serius pada lansia (American Diabetes Association [ADA], 2023).

Intervensi farmakologis dalam pengelolaan diabetes pada lansia mencakup penggunaan obat hipoglikemik oral, insulin, serta kombinasi keduanya. Obat-obatan seperti metformin, inhibitor DPP-4, inhibitor SGLT2, dan insulin basal menjadi pilihan utama yang direkomendasikan berdasarkan profil keamanan yang baik serta risiko hipoglikemia yang lebih rendah dibandingkan dengan agen lainnya (Kirkman et al., 2020). Selain itu, penting pula untuk mempertimbangkan polifarmasi yang umum terjadi pada lansia, sehingga pemantauan interaksi obat menjadi aspek penting dalam pengelolaan farmakologis (Sinclair & Abdelhafiz, 2020).

Pengelolaan non-farmakologis diabetes pada lansia meliputi modifikasi gaya hidup, seperti diet seimbang dengan kontrol karbohidrat, aktivitas fisik yang teratur sesuai kemampuan lansia, serta edukasi pasien dan keluarga terkait pengelolaan mandiri diabetes. Aktivitas fisik rutin terbukti secara signifikan dapat memperbaiki sensitivitas insulin, menurunkan kadar glukosa darah, dan meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan (Bullard et al., 2022).

Peran perawat gerontik sangat penting dalam pengelolaan diabetes pada lansia. Perawat bertanggung jawab melakukan asesmen rutin terhadap kondisi klinis pasien, memonitor komplikasi akut maupun kronis, memberikan edukasi yang sesuai kemampuan kognitif pasien, serta mendukung kepatuhan terapi (Munshi et al., 2021). Penggunaan pendekatan edukasi berbasis keluarga dan komunitas juga efektif dalam meningkatkan keberhasilan pengelolaan diabetes pada lansia, terutama di lingkungan komunitas yang sumber dayanya terbatas (Pamungkas & Chamroonsawasdi, 2020).

Dengan demikian, pengelolaan diabetes mellitus pada lansia membutuhkan pendekatan holistik, individual, serta berbasis bukti untuk memastikan hasil klinis yang optimal serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara berkelanjutan.

C. Demensia dan Penyakit Alzheimer

Demensia merupakan sindrom klinis yang ditandai oleh penurunan progresif dalam fungsi kognitif, perilaku, dan kemampuan aktivitas harian, yang secara signifikan mengganggu kehidupan sehari-hari. Penyakit Alzheimer adalah bentuk demensia yang paling umum dijumpai, mencakup sekitar 60–80% dari seluruh kasus demensia di dunia (Livingston et al., 2020). Prevalensi demensia meningkat secara signifikan seiring bertambahnya usia, terutama pada individu yang berusia di atas 65 tahun. Menurut World Health Organization (WHO, 2021), sekitar 55 juta orang di seluruh dunia hidup dengan demensia, dan angka ini diperkirakan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2050.

Penyakit Alzheimer ditandai oleh akumulasi abnormal plak amiloid dan neurofibrillary tangles (NFT) di otak, yang mengakibatkan degenerasi neuron dan atrofi otak secara progresif (Scheltens et al., 2021). Gejala awal Alzheimer umumnya meliputi penurunan daya ingat jangka pendek, kesulitan menemukan kata-kata, serta gangguan dalam orientasi tempat dan waktu. Seiring progresi penyakit, individu akan mengalami penurunan signifikan dalam kemampuan merencanakan aktivitas, mengelola keuangan, serta menjalankan tugas sehari-hari secara mandiri (Lane et al., 2021).

Faktor risiko utama Alzheimer meliputi usia lanjut, riwayat keluarga, hipertensi, diabetes mellitus, obesitas, gangguan tidur kronis, serta gaya hidup tidak aktif secara fisik maupun kognitif (Livingston et al., 2020). Penelitian terbaru juga menunjukkan adanya hubungan antara inflamasi kronis, stres oksidatif, dan

gangguan metabolisme otak dengan progresi penyakit Alzheimer (Hampel et al., 2021).

Pendekatan dalam pengelolaan demensia dan penyakit Alzheimer bersifat multidimensi, mencakup intervensi farmakologis maupun non-farmakologis. Secara farmakologis, pengobatan yang umum digunakan meliputi inhibitor kolinesterase seperti donepezil, rivastigmine, dan galantamine, yang bertujuan memperlambat progresi penyakit serta mengurangi gejala kognitif dan perilaku. Selain itu, antagonis reseptor NMDA seperti memantin juga digunakan, khususnya pada tahap demensia sedang hingga berat (Cummings et al., 2021). Namun demikian, efektivitas terapi farmakologis terbatas dalam mengubah progresi penyakit secara signifikan, sehingga pendekatan non-farmakologis menjadi sangat penting.

Intervensi non-farmakologis meliputi stimulasi kognitif, terapi okupasi, latihan fisik, serta intervensi psikososial seperti terapi reminiscence dan pendekatan berbasis musik. Studi terbaru mengungkapkan bahwa intervensi kognitif dan aktivitas fisik yang konsisten mampu memperlambat penurunan kognitif, meningkatkan kualitas hidup pasien, serta mengurangi beban stres pada keluarga atau caregiver (Fleiner et al., 2021; Laver et al., 2020). Latihan fisik secara khusus telah terbukti meningkatkan perfusi serebral, memperbaiki fungsi eksekutif, dan mengurangi gejala depresi pada pasien Alzheimer (Lamb et al., 2018).

Perawat gerontik memiliki peran vital dalam manajemen demensia dan Alzheimer melalui deteksi dini, asesmen fungsi kognitif secara berkala, pemberian edukasi kepada keluarga dan caregiver, serta koordinasi perawatan multidisiplin. Pendekatan person-centered care, yang menekankan pentingnya memahami kebutuhan individu dan mendukung otonomi pasien, merupakan standar utama dalam praktik keperawatan berbasis bukti untuk pasien Alzheimer (Fazio et al., 2018). Perawat juga perlu memfasilitasi strategi coping bagi keluarga, karena beban psikologis dan fisik yang dialami caregiver sering kali menyebabkan kelelahan emosional dan berkurangnya kualitas hidup secara keseluruhan (Etters, Goodall, & Harrison, 2021).

Dengan demikian, pengelolaan demensia dan penyakit Alzheimer pada lansia membutuhkan integrasi antara pendekatan medis, psikososial, dan keperawatan secara komprehensif dan berbasis bukti guna mempertahankan kualitas hidup pasien serta meringankan beban caregiver.

D. Osteoporosis dan Risiko Fraktur

Osteoporosis merupakan gangguan metabolisme tulang yang ditandai oleh penurunan densitas mineral tulang, mikroarsitektur tulang yang memburuk, serta peningkatan kerapuhan tulang yang signifikan. Akibatnya, lansia yang mengalami osteoporosis memiliki risiko lebih tinggi mengalami fraktur akibat trauma ringan atau bahkan tanpa trauma yang nyata (Compston et al., 2019). Fraktur yang paling umum terjadi pada lansia meliputi fraktur panggul, tulang belakang (vertebra), pergelangan tangan, dan tulang paha (femur), yang berkontribusi pada morbiditas, disabilitas, dan peningkatan angka mortalitas pada lansia (Curtis et al., 2022).

Prevalensi osteoporosis meningkat secara drastis seiring bertambahnya usia, terutama pada wanita pascamenopause akibat penurunan kadar estrogen yang menyebabkan percepatan resorpsi tulang. Namun, laki-laki lansia juga berisiko tinggi, khususnya dengan adanya faktor risiko seperti gaya hidup tidak aktif, defisiensi vitamin D, konsumsi alkohol, merokok, serta penggunaan obat-obatan tertentu seperti kortikosteroid (Black & Rosen, 2020).

Fraktur pada lansia memiliki implikasi serius berupa nyeri kronis, penurunan mobilitas, gangguan fungsi harian, serta risiko komplikasi lain seperti infeksi dan trombosis vena dalam. Selain itu, lansia yang mengalami fraktur panggul cenderung mengalami penurunan kualitas hidup secara drastis, meningkatnya ketergantungan pada bantuan orang lain, serta risiko masuk perawatan institusional yang lebih tinggi (Kanis et al., 2021).

Pengelolaan osteoporosis pada lansia memerlukan pendekatan multidimensi, meliputi asesmen risiko fraktur secara berkala, intervensi farmakologis, intervensi nonfarmakologis, serta strategi pencegahan fraktur. Penilaian risiko fraktur dapat dilakukan dengan berbagai alat seperti FRAX® (Fracture Risk Assessment Tool), yang memperkirakan risiko fraktur berdasarkan faktor klinis dan hasil pengukuran densitas tulang menggunakan Dual-energy X-ray Absorptiometry (DXA) (Kanis et al., 2021).

Intervensi farmakologis dalam manajemen osteoporosis meliputi penggunaan bifosfonat (misalnya alendronat, risedronat), denosumab, dan terapi pengganti hormon estrogen pada wanita yang sesuai secara klinis. Studi terbaru menegaskan bahwa penggunaan bifosfonat secara signifikan mengurangi risiko fraktur vertebra dan non-vertebra pada lansia (Eastell et al., 2020). Namun, pemantauan rutin perlu

dilakukan untuk mengurangi risiko efek samping seperti osteonekrosis rahang dan fraktur atipikal femur (Curtis et al., 2022).

Intervensi nonfarmakologis berfokus pada modifikasi gaya hidup, termasuk aktivitas fisik teratur yang meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan, serta nutrisi yang mencukupi terutama asupan kalsium dan vitamin D (Daly et al., 2019). Latihan fisik yang direkomendasikan mencakup latihan beban ringan (*weight-bearing exercises*), latihan resistensi, dan latihan keseimbangan seperti Tai Chi, yang terbukti efektif mengurangi risiko jatuh dan fraktur pada lansia (Zhao et al., 2022).

Perawat gerontik memiliki peran sentral dalam edukasi, asesmen risiko, implementasi intervensi pencegahan jatuh, serta dukungan rehabilitasi pasca-fraktur. Perawat juga bertanggung jawab mengedukasi lansia dan keluarga mengenai pentingnya pencegahan osteoporosis melalui gaya hidup sehat, serta memastikan kepatuhan lansia terhadap pengobatan osteoporosis dan program rehabilitasi (Curtis et al., 2022).

Secara keseluruhan, pengelolaan osteoporosis dan risiko fraktur pada lansia memerlukan integrasi intervensi medis, keperawatan, dan rehabilitasi yang komprehensif serta pendekatan proaktif berbasis bukti guna meningkatkan kualitas hidup lansia dan menurunkan risiko komplikasi serius yang berkaitan dengan osteoporosis.

E. Arthritis dan Gangguan Mobilitas

Arthritis adalah gangguan kronis yang ditandai dengan peradangan pada persendian, menyebabkan rasa nyeri, kekakuan, dan gangguan mobilitas yang signifikan. Kondisi ini sering dialami oleh lansia, dengan osteoarthritis (OA) dan arthritis reumatoid (RA) sebagai bentuk arthritis yang paling umum terjadi pada kelompok usia lanjut (Kolasinski et al., 2020). Gangguan mobilitas yang timbul akibat arthritis secara langsung memengaruhi kemandirian lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari serta kualitas hidup mereka secara keseluruhan (Hunter & Bierma-Zeinstra, 2019).

Osteoarthritis merupakan kondisi degeneratif yang melibatkan kerusakan pada kartilago sendi, penebalan tulang subkondral, serta peradangan ringan pada jaringan lunak di sekitar sendi. OA paling sering terjadi pada lutut, panggul, tangan, dan tulang belakang (Primorac et al., 2020). Faktor risiko OA meliputi usia lanjut, obesitas, cedera sendi sebelumnya, serta gaya hidup yang kurang aktif secara fisik. OA menyebabkan nyeri kronis yang diperparah oleh aktivitas, kekakuan sendi

setelah periode imobilitas, serta keterbatasan fungsi sendi yang progresif (Hunter & Bierma-Zeinstra, 2019).

Arthritis reumatoid adalah penyakit autoimun kronis yang menyebabkan peradangan sistemik pada membran sinovial persendian, mengakibatkan kerusakan sendi progresif serta deformitas sendi jika tidak ditangani dengan baik. RA lebih jarang dibandingkan OA tetapi dapat menyebabkan gangguan mobilitas yang lebih berat karena dampaknya yang lebih luas pada sistem muskuloskeletal (Smolen et al., 2020).

Gangguan mobilitas pada lansia dengan arthritis menyebabkan peningkatan risiko jatuh, penurunan aktivitas fisik, isolasi sosial, serta meningkatnya kebutuhan akan perawatan jangka panjang. Lansia dengan gangguan mobilitas akibat arthritis cenderung mengurangi aktivitas fisik mereka, yang kemudian dapat memperparah kelemahan otot dan kehilangan massa otot (sarkopenia), menciptakan siklus negatif yang memperburuk kualitas hidup (Hunter & Bierma-Zeinstra, 2019; Schaap et al., 2022).

Pengelolaan arthritis dan gangguan mobilitas pada lansia memerlukan pendekatan komprehensif yang meliputi intervensi farmakologis, nonfarmakologis, serta rehabilitasi fungsional. Intervensi farmakologis untuk OA mencakup penggunaan analgesik seperti parasetamol, NSAID topikal atau oral, dan injeksi intra-artikular seperti kortikosteroid atau asam hialuronat (Kolasinski et al., 2020). Untuk RA, pengobatan utama melibatkan Disease-Modifying Antirheumatic Drugs (DMARDs) seperti metotreksat, serta agen biologis untuk mengontrol inflamasi sistemik dan mencegah kerusakan sendi progresif (Smolen et al., 2020).

Intervensi nonfarmakologis meliputi manajemen berat badan, aktivitas fisik teratur yang mencakup latihan aerobik, latihan resistensi, serta latihan fleksibilitas seperti yoga atau Tai Chi yang terbukti efektif dalam mengurangi nyeri, memperbaiki fungsi sendi, dan meningkatkan keseimbangan pada lansia (Lauche et al., 2019). Terapi fisik seperti hidroterapi dan fisioterapi juga efektif dalam meningkatkan mobilitas dan fungsi fisik pasien arthritis (Bartels et al., 2019).

Peran perawat gerontik sangat penting dalam pengelolaan arthritis dan gangguan mobilitas lansia. Tanggung jawab perawat mencakup asesmen nyeri rutin, edukasi pasien dan keluarga mengenai manajemen nyeri dan pentingnya aktivitas fisik, serta koordinasi pelayanan multidisiplin untuk memastikan pendekatan holistik dalam pengelolaan kondisi ini (Briggs et al., 2021). Perawat juga

berperan dalam pencegahan jatuh, mendukung rehabilitasi pasca-operasi sendi, serta membantu lansia dalam mengadopsi gaya hidup aktif yang mendukung kesehatan sendi jangka panjang.

Dengan demikian, pengelolaan artritis dan gangguan mobilitas pada lansia membutuhkan pendekatan integratif yang mencakup intervensi berbasis bukti, perawatan multidisiplin, serta dukungan aktif dari perawat gerontik dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lansia secara signifikan.

BAB 4.

Pencegahan dan Penanganan Jatuh pada Lansia

A. Faktor Risiko dan Prediksi Jatuh Pada Lansia

Jatuh merupakan kejadian yang sangat umum dialami oleh lansia, yang sering menyebabkan konsekuensi serius, termasuk cedera fisik seperti fraktur dan trauma kepala, gangguan fungsi harian, serta penurunan kualitas hidup secara signifikan. Setiap tahun, sekitar sepertiga lansia berusia di atas 65 tahun mengalami insiden jatuh, dengan risiko yang meningkat seiring pertambahan usia dan kondisi komorbiditas (Ambrose et al., 2020).

Faktor risiko jatuh pada lansia bersifat multifaktorial, mencakup berbagai aspek fisik, psikologis, sosial, serta faktor lingkungan. Faktor risiko fisik utama meliputi gangguan keseimbangan, penurunan kekuatan otot (sarkopenia), gangguan penglihatan, artritis, osteoporosis, serta penggunaan obat-obatan yang meningkatkan risiko jatuh seperti sedatif dan antihipertensi (Cuevas-Trisan, 2019; Lusardi et al., 2020). Penurunan fungsi kognitif seperti demensia juga menjadi faktor risiko signifikan, karena menyebabkan gangguan dalam penilaian risiko dan kemampuan motorik yang diperlukan untuk menghindari jatuh (Peel, 2021).

Faktor psikososial seperti ketakutan jatuh (fear of falling), isolasi sosial, serta depresi diketahui secara signifikan meningkatkan risiko jatuh. Ketakutan jatuh menyebabkan lansia mengurangi aktivitas fisik, yang pada akhirnya memperburuk kondisi fisik dan keseimbangan, menciptakan lingkaran setan yang meningkatkan risiko jatuh berulang (van Schooten et al., 2020).

Lingkungan fisik tempat tinggal lansia juga berkontribusi terhadap risiko jatuh. Hambatan lingkungan seperti lantai licin, pencahayaan yang kurang, serta benda-benda yang menghalangi jalan merupakan faktor risiko jatuh yang dapat dicegah dengan modifikasi lingkungan sederhana (Pua & Ong, 2019).

Dalam konteks praktik berbasis bukti, identifikasi dan prediksi risiko jatuh menjadi langkah awal penting dalam pencegahan jatuh pada lansia. Alat prediksi berbasis bukti yang sering digunakan dalam praktik keperawatan meliputi Timed Up and Go Test (TUG), Morse Fall Scale (MFS), dan Fall Risk Assessment Tool (FRAT).

Studi terkini menunjukkan bahwa TUG Test memiliki sensitivitas tinggi dalam memprediksi risiko jatuh melalui pengukuran waktu yang dibutuhkan lansia untuk bangkit dari kursi, berjalan sejauh tiga meter, kembali, dan duduk kembali (Lusardi et al., 2020).

Selain itu, penggunaan Morse Fall Scale (MFS) yang melibatkan penilaian terhadap riwayat jatuh sebelumnya, gangguan keseimbangan, penggunaan alat bantu, serta kondisi medis tertentu juga terbukti efektif dalam mengidentifikasi lansia berisiko tinggi jatuh di rumah sakit maupun fasilitas perawatan jangka panjang (Jewell et al., 2022).

Intervensi pencegahan jatuh berbasis bukti melibatkan strategi multidimensional yang menggabungkan latihan fisik terstruktur untuk meningkatkan kekuatan dan keseimbangan, edukasi pasien dan keluarga tentang modifikasi lingkungan, manajemen obat-obatan secara hati-hati, serta asesmen rutin oleh tenaga kesehatan, terutama perawat gerontik (Sherrington et al., 2020). Penelitian menunjukkan bahwa intervensi kombinasi yang mencakup latihan fisik teratur, manajemen obat yang teliti, dan modifikasi lingkungan efektif dalam menurunkan insiden jatuh hingga 30-40% (Sherrington et al., 2020; Hopewell et al., 2019).

Perawat gerontik berperan penting dalam penerapan praktik berbasis bukti untuk pencegahan jatuh pada lansia, mencakup asesmen risiko jatuh rutin, edukasi berkelanjutan bagi lansia dan caregiver, implementasi program latihan fisik yang aman, serta koordinasi interprofesional dalam mengelola faktor risiko jatuh yang kompleks (Ambrose et al., 2020).

Dengan demikian, pemahaman komprehensif mengenai faktor risiko dan penggunaan alat prediksi jatuh berbasis bukti sangat penting bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya untuk merancang intervensi pencegahan jatuh yang efektif, sehingga secara signifikan mampu mengurangi risiko cedera dan meningkatkan kualitas hidup lansia.

B. Intervensi Keperawatan dalam Pencegahan Jatuh

Intervensi keperawatan merupakan bagian integral dalam pencegahan jatuh pada lansia. Pendekatan ini melibatkan serangkaian tindakan berbasis bukti yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko jatuh secara dini, memodifikasi faktor risiko, dan memperkuat sumber daya serta lingkungan yang aman bagi lansia (Ambrose et al., 2020). Intervensi ini menjadi prioritas utama dalam praktik keperawatan gerontik karena jatuh merupakan salah satu penyebab utama cedera serius, disabilitas, serta mortalitas pada lansia (Sherrington et al., 2020).

Pendekatan intervensi keperawatan yang efektif dalam pencegahan jatuh umumnya melibatkan beberapa komponen utama, yaitu asesmen risiko jatuh secara teratur, edukasi pasien dan keluarga, modifikasi lingkungan, manajemen obat, serta latihan fisik berbasis bukti (Hopewell et al., 2020).

Asesmen rutin yang dilakukan oleh perawat gerontik menggunakan alat asesmen berbasis bukti seperti Morse Fall Scale (MFS), Timed Up and Go (TUG), atau Hendrich II Fall Risk Model dapat secara signifikan meningkatkan akurasi dalam identifikasi lansia dengan risiko tinggi jatuh (Jewell et al., 2022). Proses ini tidak hanya membantu dalam mengklasifikasikan tingkat risiko jatuh, tetapi juga membantu perawat dalam merancang intervensi yang personal dan efektif bagi lansia.

Edukasi pasien dan keluarga merupakan bagian penting dari intervensi keperawatan, yang bertujuan meningkatkan kesadaran lansia terhadap risiko jatuh dan strategi pencegahannya. Edukasi ini meliputi informasi mengenai pentingnya aktivitas fisik teratur, modifikasi lingkungan di rumah seperti pencahayaan yang memadai, mengurangi hambatan di lantai, serta penggunaan alat bantu jalan yang tepat (Morris et al., 2021). Studi terbaru menunjukkan bahwa edukasi yang melibatkan keluarga atau caregiver mampu meningkatkan kepatuhan lansia terhadap intervensi pencegahan jatuh secara signifikan (Chidume, 2021).

Modifikasi lingkungan tempat tinggal lansia adalah intervensi penting lainnya. Penelitian terkini mengungkapkan bahwa perubahan lingkungan sederhana seperti pemasangan pegangan di kamar mandi, penambahan penerangan yang lebih baik, serta penggunaan karpet anti-selip dapat secara signifikan mengurangi risiko jatuh di rumah lansia (Pua & Ong, 2019). Perawat gerontik berperan dalam mengidentifikasi bahaya lingkungan potensial serta memberikan rekomendasi yang sesuai kepada lansia dan keluarganya.

Manajemen obat juga menjadi perhatian utama dalam intervensi keperawatan pencegahan jatuh, karena polifarmasi dan penggunaan obat tertentu seperti obat penenang, antihipertensi, atau antidepresan sering kali meningkatkan risiko jatuh pada lansia (Seppala et al., 2020). Perawat gerontik memiliki peran kunci dalam kolaborasi dengan dokter dan apoteker untuk meninjau secara berkala obat-obatan yang dikonsumsi oleh lansia, memastikan regimen pengobatan yang aman dan efektif, serta memberikan edukasi tentang efek samping obat kepada lansia dan keluarganya (Hill et al., 2019).

Latihan fisik secara rutin yang mencakup latihan kekuatan, keseimbangan, dan fleksibilitas telah terbukti efektif dalam menurunkan risiko jatuh. Perawat gerontik dapat memfasilitasi atau merekomendasikan latihan seperti Tai Chi, latihan resistensi, serta latihan keseimbangan yang secara konsisten terbukti dalam

penelitian mampu mengurangi risiko jatuh hingga 30-40% pada lansia (Sherrington et al., 2020; Zhang et al., 2021).

Dalam implementasi intervensi tersebut, perawat gerontik juga perlu berkolaborasi secara interprofesional dengan fisioterapis, dokter, ahli gizi, serta pekerja sosial untuk memastikan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam pencegahan jatuh pada lansia (Ambrose et al., 2020). Pendekatan multidisiplin ini tidak hanya menurunkan angka kejadian jatuh, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup secara keseluruhan bagi lansia.

Dengan demikian, intervensi keperawatan berbasis bukti dalam pencegahan jatuh memainkan peran krusial dalam pengurangan risiko jatuh, meningkatkan kemandirian, serta menjaga kualitas hidup lansia secara optimal.

C. Manajemen Cedera Akibat Jatuh

Cedera akibat jatuh merupakan masalah kesehatan yang serius pada lansia, dengan dampak yang mencakup cedera fisik seperti fraktur, luka, dan cedera kepala, serta dampak psikososial seperti ketakutan jatuh berulang dan isolasi sosial. Manajemen cedera akibat jatuh bertujuan meminimalkan komplikasi lebih lanjut, mempercepat proses pemulihan atau pemulihan, serta mempertahankan kualitas hidup lansia (Ambrose et al., 2020).

Fraktur merupakan cedera yang paling sering terjadi akibat jatuh pada lansia, terutama fraktur panggul, fraktur pergelangan tangan, dan fraktur vertebra. Fraktur panggul, misalnya, memiliki konsekuensi serius seperti imobilisasi jangka panjang, komplikasi pneumonia, infeksi saluran kemih, dan luka tekan, serta peningkatan mortalitas (LeBlanc et al., 2021). Manajemen fraktur pada lansia memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan intervensi bedah, perawatan pasca-bedah, terapi fisik, dan manajemen nyeri secara efektif (Bhandari & Swiontkowski, 2021).

Cedera kepala merupakan jenis cedera lain yang sering terjadi akibat jatuh pada lansia, dengan manifestasi yang bervariasi mulai dari ringan seperti gegar otak hingga cedera traumatik otak berat (Traumatic Brain Injury/TBI). Manajemen cedera kepala melibatkan evaluasi neurologis yang cermat, observasi ketat tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial, serta penanganan komplikasi sekunder seperti hematoma subdural yang sering terjadi pada lansia (Gardner et al., 2022).

Luka terbuka dan kontusio akibat jatuh juga umum dialami lansia. Penanganan luka akut mencakup pembersihan luka yang adekuat, penggunaan antiseptik sesuai indikasi, serta penutupan luka dengan teknik yang tepat untuk mengurangi risiko infeksi dan mempercepat penyembuhan (Sood et al., 2020). Lansia dengan luka tekan akibat imobilisasi pasca-jatuh membutuhkan perawatan luka khusus yang

mencakup reposisi rutin, perawatan luka modern seperti balutan berbasis hidrokoloid atau busa, serta evaluasi rutin oleh perawat (Moore et al., 2020).

Selain manajemen cedera secara fisik, intervensi psikososial juga menjadi aspek penting dalam manajemen cedera akibat jatuh. Ketakutan jatuh yang sering muncul setelah lansia mengalami cedera dapat menyebabkan pembatasan aktivitas dan isolasi sosial, yang memperburuk kondisi fisik dan mental. Strategi psikososial berbasis bukti seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT), terapi kelompok, serta intervensi berbasis komunitas terbukti efektif dalam mengatasi ketakutan jatuh dan meningkatkan kepercayaan diri lansia untuk kembali beraktivitas secara normal (Parry et al., 2021).

Perawat gerontik memainkan peran krusial dalam manajemen cedera akibat jatuh. Tanggung jawab perawat meliputi asesmen rutin kondisi cedera dan komplikasi, manajemen nyeri yang efektif, fasilitasi mobilisasi dini, koordinasi perawatan multidisiplin, serta pemberian edukasi yang memadai bagi pasien dan keluarga mengenai perawatan lanjutan dan pencegahan cedera berulang (Hill et al., 2019). Mobilisasi dini yang difasilitasi oleh perawat pasca-fraktur terbukti dapat mengurangi risiko komplikasi imobilisasi seperti tromboemboli, pneumonia, dan atrofi otot (Bhandari & Swiontkowski, 2021).

Pendekatan multidisiplin juga sangat penting dalam manajemen cedera akibat jatuh, melibatkan kerja sama erat antara perawat, dokter, fisioterapis, ahli terapi okupasi, psikolog, serta pekerja sosial. Kolaborasi ini bertujuan memastikan pengelolaan cedera secara holistik, mencegah komplikasi lebih lanjut, serta mendukung pemulihan fungsional yang optimal pada lansia (Hopewell et al., 2020).

Dengan demikian, manajemen cedera akibat jatuh pada lansia membutuhkan pendekatan terpadu berbasis bukti yang mencakup aspek medis, keperawatan, rehabilitasi, serta intervensi psikososial, demi mempertahankan kualitas hidup lansia secara menyeluruh.

BAB 5.

Manajemen Nyeri pada Lansia

A. Mengenali Rasa Nyeri yang Dirasakan Lansia dengan Tepat

Nyeri merupakan salah satu keluhan yang paling sering dilaporkan oleh lansia, baik akibat kondisi kronis seperti artritis, osteoporosis, neuropati, maupun akibat kondisi akut seperti cedera atau pasca-operasi. Evaluasi nyeri yang tepat sangat penting dalam manajemen nyeri, karena lansia sering mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan nyeri yang mereka alami secara efektif, terutama pada lansia dengan gangguan kognitif seperti demensia (Booker et al., 2020).

Evaluasi nyeri berbasis bukti merupakan proses sistematis dalam menilai intensitas, karakteristik, lokasi, durasi, serta dampak nyeri terhadap fungsi harian dan kualitas hidup lansia (AGS Panel on Persistent Pain in Older Persons, 2020). Proses ini melibatkan kombinasi alat ukur nyeri yang valid, observasi klinis yang cermat, serta komunikasi efektif antara perawat, lansia, dan keluarga atau caregiver.

Salah satu alat evaluasi nyeri yang paling sering digunakan pada lansia yang masih memiliki fungsi kognitif baik adalah Numeric Rating Scale (NRS), Visual Analog Scale (VAS), dan Verbal Descriptor Scale (VDS). Studi terbaru menunjukkan bahwa NRS merupakan alat yang mudah digunakan oleh lansia dan memiliki reliabilitas serta validitas yang tinggi dalam menilai nyeri kronis maupun akut (Hadjistavropoulos et al., 2021). Sementara itu, VDS dan VAS juga memiliki akurasi tinggi, tetapi penggunaannya bisa lebih menantang bagi lansia dengan gangguan penglihatan atau kognitif ringan (AGS Panel on Persistent Pain in Older Persons, 2020).

Pada lansia dengan gangguan kognitif atau demensia, evaluasi nyeri berbasis bukti memerlukan pendekatan yang berbeda karena keterbatasan komunikasi verbal. Dalam kondisi ini, alat evaluasi nyeri berbasis observasi perilaku seperti Pain Assessment in Advanced Dementia (PAINAD) atau Abbey Pain Scale sangat dianjurkan (Flo et al., 2021). Alat-alat tersebut menilai tanda-tanda perilaku non-verbal seperti ekspresi wajah, suara, postur tubuh, aktivitas, dan respons terhadap kenyamanan, yang terbukti efektif dalam mengidentifikasi dan menilai intensitas nyeri pada lansia dengan gangguan kognitif (Bullock et al., 2020).

Evaluasi nyeri pada lansia juga harus memperhatikan aspek multidimensional nyeri yang mencakup dampak emosional, psikososial, serta fungsional dari nyeri tersebut. Penggunaan alat evaluasi seperti Brief Pain Inventory (BPI) dan Geriatric Pain Measure (GPM) sangat direkomendasikan karena mampu mengevaluasi tidak hanya intensitas nyeri, tetapi juga dampaknya terhadap aktivitas harian, mood, tidur, dan kualitas hidup secara keseluruhan (Schneiderhan et al., 2020).

Perawat gerontik memiliki peran vital dalam pelaksanaan evaluasi nyeri berbasis bukti ini. Tanggung jawab perawat meliputi asesmen rutin dan berkala terhadap kondisi nyeri lansia, dokumentasi hasil asesmen secara akurat, edukasi pasien dan keluarga mengenai pentingnya pelaporan nyeri yang jujur dan tepat, serta kolaborasi erat dengan tim multidisiplin dalam merancang strategi manajemen nyeri yang efektif (Brown et al., 2020).

Studi terbaru menunjukkan bahwa implementasi evaluasi nyeri berbasis bukti yang sistematis oleh perawat secara signifikan dapat meningkatkan akurasi deteksi nyeri, memperbaiki manajemen nyeri, serta meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga dalam perawatan (Booker et al., 2020; Brown et al., 2020). Selain itu, evaluasi yang tepat juga membantu mencegah komplikasi lanjutan yang terkait dengan nyeri kronis, seperti gangguan tidur, depresi, penurunan fungsi kognitif, serta isolasi sosial (AGS Panel on Persistent Pain in Older Persons, 2020).

Secara keseluruhan, evaluasi nyeri berbasis bukti merupakan langkah kunci dalam manajemen nyeri pada lansia, dan perawat gerontik memainkan peran sentral dalam memastikan asesmen nyeri yang komprehensif, tepat waktu, serta berkelanjutan demi meningkatkan kualitas hidup lansia secara signifikan.

B. Intervensi Farmakologis dan Non-farmakologis dalam Manajemen Nyeri

Manajemen nyeri yang efektif pada lansia memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan intervensi farmakologis dan non-farmakologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi intensitas nyeri, meningkatkan fungsi fisik dan psikososial, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh (AGS Panel on Persistent Pain in Older Persons, 2020).

1. Intervensi Farmakologis

Intervensi farmakologis merupakan metode utama dalam mengelola nyeri sedang hingga berat pada lansia. Obat-obatan analgesik seperti parasetamol, NSAID (Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs), opioid, antidepresan trisiklik, antikonvulsan, dan anestesi topikal sering digunakan tergantung dari jenis dan intensitas nyeri (Abdulla et al., 2020).

Parasetamol merupakan analgesik yang paling sering direkomendasikan sebagai terapi lini pertama pada lansia karena profil keamanannya yang relatif

baik. Namun, penggunaannya harus tetap dimonitor untuk mencegah toksisitas hepatic akibat dosis berlebihan (O'Neil et al., 2022).

NSAID digunakan secara hati-hati pada lansia karena risiko efek samping gastrointestinal, ginjal, dan kardiovaskuler yang lebih tinggi. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan NSAID topikal lebih aman dibandingkan NSAID oral, dengan efektivitas yang setara dalam mengurangi nyeri muskuloskeletal seperti osteoarthritis (Machado et al., 2021).

Penggunaan opioid dalam manajemen nyeri kronis berat pada lansia memerlukan kehati-hatian khusus karena risiko efek samping serius seperti konstipasi, gangguan kognitif, sedasi, dan risiko jatuh yang lebih tinggi. Panduan terbaru merekomendasikan evaluasi risiko-manfaat secara ketat sebelum dan selama terapi opioid pada lansia (Dowell et al., 2022).

Antidepresan seperti amitriptilin dan antikonvulsan seperti gabapentin digunakan dalam manajemen nyeri neuropatik kronis, dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kedua obat ini efektif dalam mengurangi nyeri neuropati pada lansia (Finnerup et al., 2021).

2. Intervensi Non-farmakologis

Intervensi non-farmakologis berperan penting sebagai komponen tambahan atau alternatif bagi lansia yang memiliki kontraindikasi terhadap penggunaan obat-obatan atau mengalami efek samping serius. Intervensi ini meliputi terapi fisik, terapi perilaku kognitif (CBT), akupunktur, terapi musik, serta teknik relaksasi seperti meditasi mindfulness (Booker et al., 2020).

Terapi fisik seperti latihan kekuatan, fleksibilitas, dan aerobik terbukti efektif dalam mengurangi nyeri muskuloskeletal pada lansia serta meningkatkan fungsi fisik dan keseimbangan secara signifikan. Latihan fisik secara konsisten juga dapat mengurangi kebutuhan akan analgesik farmakologis (Geneen et al., 2020).

CBT merupakan intervensi psikologis yang efektif dalam membantu lansia mengelola nyeri kronis melalui teknik restrukturisasi kognitif, strategi coping positif, serta manajemen stres dan relaksasi. Penelitian terbaru menunjukkan CBT mampu mengurangi intensitas nyeri serta meningkatkan kualitas hidup secara signifikan pada lansia dengan nyeri kronis (Nicholas et al., 2020).

Akupunktur telah terbukti efektif dalam manajemen nyeri kronis seperti osteoarthritis dan nyeri punggung bawah pada lansia. Studi menunjukkan bahwa akupunktur memiliki efek analgesik dengan mekanisme pelepasan endorfin dan modulasi sistem saraf pusat, menjadikannya pilihan yang aman dengan sedikit efek samping (Vickers et al., 2018).

Terapi musik dan teknik mindfulness juga efektif dalam mengurangi persepsi nyeri serta meningkatkan mood, kualitas tidur, dan kualitas hidup lansia. Intervensi ini bekerja dengan mengurangi respons stres, meningkatkan relaksasi, serta mengalihkan perhatian lansia dari nyeri yang mereka alami (Bradt et al., 2019).

Perawat gerontik memiliki peran sentral dalam implementasi intervensi farmakologis maupun non-farmakologis ini. Tugas perawat meliputi asesmen rutin efektivitas terapi, edukasi pasien dan keluarga tentang manajemen nyeri, pemantauan efek samping terapi, serta kolaborasi interprofesional dalam merancang dan menyesuaikan strategi manajemen nyeri secara individual (AGS Panel on Persistent Pain in Older Persons, 2020; Booker et al., 2020).

Pendekatan multidimensi dan integratif ini terbukti mampu meningkatkan efektivitas manajemen nyeri, mengurangi dampak negatif nyeri kronis, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara optimal.

C. Efektivitas Terapi Komplementer dalam Mengurangi Nyeri

Terapi komplementer atau Complementary and Alternative Medicine (CAM) semakin populer dalam manajemen nyeri pada lansia. Terapi ini mencakup berbagai teknik yang tidak termasuk dalam intervensi farmakologis konvensional, tetapi telah terbukti memiliki manfaat signifikan dalam mengurangi nyeri, meningkatkan kesejahteraan fisik dan psikologis, serta memperbaiki kualitas hidup lansia secara keseluruhan (Tick et al., 2018; Booker et al., 2020).

- Salah satu terapi komplementer yang paling banyak diteliti dan terbukti efektif adalah **akupunktur**. Studi terbaru menunjukkan bahwa akupunktur dapat secara signifikan mengurangi nyeri kronis seperti osteoarthritis, nyeri punggung bawah, dan nyeri neuropati pada lansia dengan mekanisme pelepasan opioid endogen, modulasi sistem saraf pusat, serta efek anti-inflamasi lokal (Vickers et al., 2018; Yuan et al., 2022). Selain itu, akupunktur memiliki profil keamanan yang baik, dengan sedikit efek samping dibandingkan penggunaan obat-obatan analgesik, terutama pada lansia yang rentan terhadap efek samping obat (Zia et al., 2020).
- **Meditasi mindfulness** dan **teknik relaksasi** juga menjadi terapi komplementer efektif yang semakin diakui dalam manajemen nyeri pada lansia. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa meditasi mindfulness mampu mengurangi persepsi nyeri, meningkatkan kemampuan coping, menurunkan tingkat kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur lansia yang mengalami nyeri kronis (Cherkin et al., 2020). Terapi ini bekerja melalui

mekanisme psikologis berupa pengurangan respons stres, meningkatkan relaksasi, serta modulasi persepsi nyeri di tingkat otak (Hilton et al., 2020).

- **Terapi musik** merupakan intervensi lain yang efektif dalam manajemen nyeri lansia. Studi terbaru menunjukkan bahwa terapi musik dapat mengurangi intensitas nyeri secara signifikan, terutama pada lansia dengan kondisi nyeri kronis dan pasien pascaoperasi, melalui efek distraksi, pengurangan kecemasan, dan pelepasan endorfin alami tubuh (Lee et al., 2021). Selain mengurangi nyeri, terapi musik juga membantu meningkatkan mood positif dan kualitas hidup lansia secara keseluruhan.
- **Terapi pijat (massage therapy)** terbukti efektif dalam mengurangi nyeri muskuloskeletal, nyeri neuropati, serta meningkatkan fleksibilitas dan mobilitas pada lansia. Studi menunjukkan bahwa terapi pijat dapat memperbaiki sirkulasi darah, menurunkan ketegangan otot, serta meningkatkan produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin yang berperan dalam pengurangan nyeri dan peningkatan kesejahteraan emosional (Nelson & Churilla, 2020).
- **Aromaterapi** juga menjadi pilihan terapi komplementer yang umum digunakan untuk mengelola nyeri pada lansia. Penelitian terbaru menunjukkan aromaterapi dengan minyak esensial seperti lavender dan peppermint efektif dalam mengurangi nyeri ringan hingga sedang serta meningkatkan kualitas tidur dan relaksasi pada lansia dengan nyeri kronis (Lakhan et al., 2020). Aromaterapi memiliki efek analgesik melalui stimulasi reseptor olfaktorius yang mempengaruhi sistem limbik otak, yang terlibat dalam pengaturan nyeri dan emosi.

Perawat gerontik memainkan peran penting dalam implementasi terapi komplementer ini. Perawat bertanggung jawab dalam mengedukasi lansia dan keluarga mengenai manfaat, mekanisme, dan potensi efek samping terapi komplementer, serta membantu memfasilitasi penggunaannya secara efektif dan aman sebagai bagian dari rencana manajemen nyeri yang komprehensif (Booker et al., 2020; Cherkin et al., 2020).

Pendekatan holistik dalam manajemen nyeri pada lansia yang mengintegrasikan terapi komplementer dengan terapi konvensional telah terbukti efektif meningkatkan hasil klinis, memperbaiki kualitas hidup, serta mengurangi ketergantungan pada penggunaan obat-obatan analgesik yang sering memiliki efek samping serius pada populasi lansia (Tick et al., 2018).

BAB 6.

Nutrisi dan Hidrasi pada Lansia

A. Penilaian Nutrisi dan Status Hidrasi

Penilaian nutrisi dan status hidrasi pada lansia merupakan aspek penting dalam praktik keperawatan gerontik, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan, fungsi fisik, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Lansia merupakan kelompok yang rentan terhadap malnutrisi dan dehidrasi karena berbagai faktor, seperti perubahan fisiologis terkait penuaan, gangguan mobilitas, gangguan kognitif, polifarmasi, dan kondisi penyakit kronis (Volkert et al., 2019).

Penilaian nutrisi yang berbasis bukti pada lansia bertujuan untuk mengidentifikasi risiko malnutrisi secara dini, menilai kecukupan asupan zat gizi, serta mengembangkan intervensi nutrisi yang tepat. Salah satu alat skrining nutrisi yang paling banyak digunakan adalah Mini Nutritional Assessment (MNA), yang terbukti valid, reliabel, dan efektif untuk mengidentifikasi lansia yang berisiko mengalami malnutrisi atau sudah dalam kondisi malnutrisi (Cereda et al., 2020). MNA terdiri dari parameter antropometri, pola makan, penurunan berat badan, serta status fungsional dan kognitif yang secara komprehensif mencerminkan status nutrisi lansia.

Selain MNA, penggunaan alat penilaian lain seperti Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) dan Subjective Global Assessment (SGA) juga umum digunakan dalam praktik klinis, terutama untuk pasien lansia di rumah sakit atau fasilitas perawatan jangka panjang (Marshall et al., 2019). Studi terbaru menunjukkan bahwa alat-alat ini efektif dalam memprediksi hasil klinis seperti komplikasi pasca operasi, lama rawat inap, dan mortalitas pada lansia dengan risiko malnutrisi (Rasheed & Woods, 2020).

Penilaian hidrasi pada lansia juga sangat penting karena lansia lebih rentan mengalami dehidrasi akibat penurunan rasa haus, gangguan mobilitas yang menghambat akses ke cairan, serta perubahan fungsi ginjal yang memengaruhi kemampuan tubuh mempertahankan keseimbangan cairan (Hooper et al., 2019). Alat evaluasi status hidrasi berbasis bukti meliputi asesmen klinis seperti pemeriksaan turgor kulit, penilaian membran mukosa, pemeriksaan urin, serta parameter laboratorium seperti osmolaritas plasma dan kadar natrium serum (Bunn & Hooper, 2019).

Studi terkini menegaskan bahwa penilaian klinis saja sering kali kurang akurat dalam mengidentifikasi dehidrasi ringan hingga sedang pada lansia. Oleh karena itu, integrasi parameter laboratorium seperti osmolaritas plasma, BUN/kreatinin ratio, serta pemeriksaan urin untuk warna dan berat jenis urin direkomendasikan sebagai pendekatan yang lebih akurat (Fortes et al., 2019). Penggunaan skala Dehydration Screening Tool (DST) juga terbukti efektif dalam skrining dini risiko dehidrasi pada lansia di fasilitas perawatan jangka panjang (Bunn & Hooper, 2019).

Peran perawat gerontik sangat krusial dalam implementasi penilaian nutrisi dan status hidrasi. Perawat bertugas untuk melakukan asesmen secara rutin dan berkala, mendokumentasikan hasil penilaian dengan akurat, mengedukasi lansia dan keluarga tentang pentingnya pemenuhan kebutuhan nutrisi dan cairan, serta merancang intervensi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu lansia (Volkert et al., 2019).

Hasil dari penilaian nutrisi dan status hidrasi yang akurat memungkinkan perawat dan tim interprofesional untuk mengidentifikasi risiko lebih awal, mencegah komplikasi serius seperti luka tekan, infeksi, penurunan fungsi kognitif, serta secara signifikan meningkatkan hasil klinis dan kualitas hidup lansia (Cereda et al., 2020; Volkert et al., 2019).

Dengan demikian, penilaian nutrisi dan status hidrasi berbasis bukti menjadi langkah kunci dalam memastikan kesehatan optimal, pencegahan komplikasi, serta peningkatan kualitas hidup pada populasi lansia.

B. Intervensi Keperawatan dalam Mengatasi Malnutrisi dan Dehidrasi

Malnutrisi dan dehidrasi merupakan kondisi umum yang dapat secara signifikan memengaruhi status kesehatan lansia, menurunkan kualitas hidup, dan meningkatkan risiko komplikasi serius seperti infeksi, gangguan fungsi kognitif, luka tekan, hingga peningkatan angka mortalitas (Volkert et al., 2019). Oleh karena itu, perawat gerontik memiliki peran penting dalam mengidentifikasi dan melaksanakan intervensi berbasis bukti yang efektif untuk mengatasi kedua masalah ini.

1. Intervensi Keperawatan dalam Mengatasi Malnutrisi

Intervensi keperawatan untuk malnutrisi pada lansia melibatkan beberapa aspek penting, antara lain skrining dan asesmen rutin, edukasi pasien dan keluarga tentang gizi seimbang, pemberian dukungan nutrisi, serta modifikasi lingkungan makan yang nyaman bagi lansia (Marshall et al., 2019).

Perawat perlu melakukan skrining nutrisi secara teratur menggunakan instrumen berbasis bukti seperti Mini Nutritional Assessment (MNA) atau Malnutrition Universal Screening Tool (MUST). Setelah teridentifikasi risiko malnutrisi, perawat harus segera melaksanakan intervensi nutrisi spesifik seperti

pemberian makanan kaya energi dan protein, suplemen nutrisi oral, atau bahkan nutrisi enteral pada kasus berat (Cereda et al., 2020).

Strategi edukasi berbasis keluarga dan komunitas juga menjadi intervensi efektif. Studi terbaru menunjukkan bahwa edukasi tentang pentingnya asupan protein yang cukup, serta peningkatan kesadaran mengenai pola makan sehat, mampu meningkatkan status nutrisi lansia secara signifikan (Rasheed & Woods, 2020). Modifikasi lingkungan makan, seperti menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan, menggunakan alat makan yang ergonomis, serta memastikan makanan disajikan dalam porsi kecil namun sering, terbukti efektif dalam meningkatkan asupan makanan lansia (Marshall et al., 2019).

2. Intervensi Keperawatan dalam Mengatasi Dehidrasi

Dehidrasi pada lansia sering kali tidak terdeteksi, namun dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gangguan ginjal, infeksi saluran kemih, dan delirium. Intervensi keperawatan dalam mencegah dan mengatasi dehidrasi mencakup evaluasi rutin terhadap asupan cairan, edukasi lansia dan keluarga tentang tanda-tanda dehidrasi, serta memastikan akses mudah lansia terhadap cairan sepanjang hari (Hooper et al., 2019).

Perawat harus melakukan asesmen status hidrasi secara teratur melalui pemeriksaan klinis dan parameter laboratorium seperti osmolaritas plasma atau kadar natrium serum untuk memastikan deteksi dini dehidrasi (Bunn & Hooper, 2019). Edukasi kepada lansia dan caregiver mengenai pentingnya konsumsi cairan yang cukup dan jadwal minum teratur dapat membantu mengurangi risiko dehidrasi secara signifikan (Fortes et al., 2019).

Pengaturan cairan secara aktif seperti menawarkan minuman favorit, memberikan pengingat rutin untuk minum, dan menciptakan lingkungan yang mendukung konsumsi cairan yang memadai terbukti efektif meningkatkan status hidrasi lansia (Bunn & Hooper, 2019). Selain itu, kolaborasi interprofesional dengan ahli gizi, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya menjadi kunci keberhasilan intervensi dalam mengatasi dehidrasi pada lansia (Hooper et al., 2019).

3. Peran Perawat Gerontik dalam Intervensi Nutrisi dan Hidrasi

Peran perawat gerontik dalam intervensi ini tidak hanya terbatas pada implementasi tindakan langsung tetapi juga meliputi koordinasi perawatan, advokasi kebutuhan lansia, serta komunikasi efektif dengan pasien dan keluarga (Volkert et al., 2019). Studi menunjukkan bahwa intervensi keperawatan yang terintegrasi dan multidisiplin dalam mengatasi malnutrisi dan dehidrasi secara

signifikan mampu meningkatkan hasil klinis, mengurangi komplikasi, dan memperbaiki kualitas hidup lansia (Marshall et al., 2019; Volkert et al., 2019).

Kesimpulannya, intervensi keperawatan berbasis bukti dalam mengatasi malnutrisi dan dehidrasi merupakan komponen penting dalam pelayanan gerontik. Dengan pendekatan yang sistematis, terintegrasi, serta melibatkan keluarga dan komunitas, perawat gerontik dapat secara efektif meningkatkan status nutrisi dan hidrasi lansia, serta memperbaiki hasil klinis jangka panjang secara menyeluruh.

BAB 7.

Tidur dan Gangguan Tidur pada Lansia

A. Pola Tidur dan Perubahan Normal pada Lansia

Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia yang esensial dalam mempertahankan kesehatan fisik dan mental. Namun, pola tidur pada lansia mengalami berbagai perubahan seiring proses penuaan. Perubahan tersebut umumnya normal dan berhubungan dengan perubahan fisiologis serta pola hidup lansia, tetapi tetap perlu dipahami agar dapat dibedakan dari gangguan tidur patologis (Li et al., 2018).

1. Perubahan Pola Tidur pada Lansia

Perubahan pola tidur yang khas pada lansia mencakup durasi tidur yang lebih singkat, fragmentasi tidur yang lebih sering (terbangun di malam hari), penurunan proporsi tidur dalam fase tidur gelombang lambat (Slow Wave Sleep atau SWS), serta peningkatan periode tidur ringan (tahap 1 dan tahap 2 tidur Non-REM) (Miner & Kryger, 2020). Selain itu, lansia juga cenderung mengalami fase tidur REM (Rapid Eye Movement) yang lebih pendek, yang berdampak pada proses regenerasi tubuh dan konsolidasi memori (Li et al., 2018).

Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa lansia rata-rata membutuhkan waktu tidur malam sekitar 6-7 jam, lebih pendek dibandingkan orang dewasa muda. Namun, durasi tidur tersebut tidak selalu mengindikasikan gangguan jika lansia tetap merasa segar dan berfungsi optimal selama aktivitas harian (Miner & Kryger, 2020).

2. Faktor yang Memengaruhi Pola Tidur pada Lansia

Perubahan fisiologis yang terjadi akibat penuaan merupakan penyebab utama perubahan pola tidur lansia. Salah satunya adalah penurunan produksi hormon melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur-bangun (ritme sirkadian). Penurunan melatonin menyebabkan lansia cenderung tidur lebih awal pada malam hari (advanced sleep phase) dan bangun lebih awal pada pagi hari (Gadie et al., 2019).

Selain perubahan hormonal, pola tidur lansia juga dipengaruhi oleh faktor medis, psikososial, dan lingkungan. Kondisi medis seperti nyeri kronis, artritis,

diabetes, hipertensi, serta kondisi psikologis seperti kecemasan dan depresi secara signifikan berkontribusi terhadap gangguan pola tidur pada lansia (Patel et al., 2018). Selain itu, penggunaan obat-obatan seperti diuretik, beta-blocker, serta antidepresan juga dapat memengaruhi kualitas tidur lansia (Gadie et al., 2019).

3. Konsekuensi Perubahan Pola Tidur Normal pada Lansia

Meskipun sebagian perubahan pola tidur pada lansia adalah normal, konsekuensinya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Fragmentasi tidur dapat menyebabkan kelelahan di siang hari, penurunan konsentrasi, serta peningkatan risiko jatuh akibat rasa kantuk atau gangguan perhatian (Li et al., 2018). Selain itu, perubahan tidur REM yang lebih pendek berpotensi menyebabkan gangguan memori dan fungsi kognitif pada lansia (Miner & Kryger, 2020).

4. Peran Perawat Gerontik dalam Mengelola Perubahan Pola Tidur

Perawat gerontik memiliki peran penting dalam memahami perubahan pola tidur normal pada lansia dan membedakannya dari gangguan tidur patologis. Tugas perawat meliputi asesmen rutin terhadap pola tidur, memberikan edukasi kepada lansia dan keluarga tentang perubahan pola tidur yang normal, serta membantu lansia dalam mengadopsi kebiasaan tidur yang sehat (higiene tidur) seperti menjaga jadwal tidur teratur, menghindari konsumsi kafein sebelum tidur, dan menciptakan lingkungan tidur yang nyaman (Gadie et al., 2019; Patel et al., 2018).

Dengan memahami perubahan tidur normal ini, perawat dapat memberikan intervensi yang tepat waktu, mencegah konsekuensi negatif perubahan tidur, serta membantu meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh (Li et al., 2018; Miner & Kryger, 2020).

B. Strategi Keperawatan dalam Mengatasi Insomnia dan Gangguan Tidur Lainnya pada Lansia

Gangguan tidur seperti insomnia, sindrom kaki gelisah (Restless Leg Syndrome/RLS), sleep apnea, dan gangguan ritme sirkadian umum terjadi pada lansia, serta berdampak signifikan terhadap kualitas hidup dan kesehatan mereka secara keseluruhan (Patel et al., 2018). Oleh karena itu, peran perawat gerontik menjadi krusial dalam mengidentifikasi serta mengimplementasikan strategi keperawatan yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

1. Strategi Keperawatan untuk Mengatasi Insomnia

Insomnia merupakan gangguan tidur paling umum pada lansia, yang ditandai oleh kesulitan untuk tertidur, mempertahankan tidur, atau bangun terlalu awal dengan konsekuensi gangguan fungsi harian. Strategi keperawatan dalam mengatasi insomnia mencakup berbagai pendekatan berbasis bukti seperti edukasi tentang higiene tidur (sleep hygiene), terapi perilaku kognitif untuk insomnia (CBT-I), serta manajemen lingkungan tidur yang optimal (Sivertsen et al., 2021).

Edukasi higiene tidur merupakan intervensi utama yang efektif, di antaranya meliputi menjaga jadwal tidur yang teratur, menciptakan lingkungan tidur nyaman, menghindari konsumsi kafein dan alkohol menjelang tidur, serta membatasi tidur siang berlebihan. Studi menunjukkan bahwa edukasi ini secara signifikan mampu meningkatkan kualitas tidur lansia (Fung et al., 2021).

Terapi perilaku kognitif untuk insomnia (CBT-I) terbukti menjadi salah satu intervensi non-farmakologis paling efektif dalam mengatasi insomnia pada lansia. CBT-I terdiri dari teknik restrukturisasi kognitif, kontrol stimulus, pembatasan tidur (sleep restriction), relaksasi, serta pendidikan tentang tidur yang efektif mengurangi insomnia kronis dan meningkatkan kualitas tidur (Sadler et al., 2018).

2. Strategi Keperawatan untuk Sindrom Kaki Gelisah dan Sleep Apnea

Sindrom kaki gelisah (RLS) sering terjadi pada lansia dan mengganggu kualitas tidur akibat sensasi tidak nyaman di tungkai bawah. Strategi keperawatan meliputi edukasi pasien mengenai gaya hidup sehat seperti latihan fisik teratur, kompres hangat atau dingin pada kaki, serta teknik relaksasi sebelum tidur. Pada kasus berat, perawat perlu berkolaborasi dengan dokter dalam penggunaan terapi farmakologis seperti dopamin agonis (Trenkwalder et al., 2018).

Sleep apnea obstruktif (OSA) adalah gangguan tidur umum lainnya pada lansia yang ditandai dengan henti napas berulang selama tidur. Strategi keperawatan untuk OSA meliputi edukasi pasien dan keluarga tentang pentingnya penggunaan alat Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) secara teratur, manajemen berat badan, serta posisi tidur yang tepat seperti posisi miring atau semi-Fowler (Patel et al., 2018; Stepnowsky et al., 2019).

3. Strategi Keperawatan untuk Gangguan Ritme Sirkadian

Gangguan ritme sirkadian, seperti advanced sleep phase syndrome, sering dijumpai pada lansia. Strategi keperawatan untuk mengatasi masalah ini meliputi penggunaan terapi cahaya (light therapy), edukasi pasien tentang pentingnya paparan cahaya alami di pagi hari, serta aktivitas fisik yang terjadwal untuk memperkuat sinyal ritme sirkadian alami tubuh (Dzierzewski et al., 2019).

4. Peran Perawat Gerontik dalam Strategi Manajemen Gangguan Tidur

Perawat gerontik memiliki peran penting dalam implementasi strategi keperawatan untuk gangguan tidur lansia, yang meliputi asesmen rutin pola tidur, edukasi lansia dan caregiver, implementasi intervensi non-farmakologis, kolaborasi dengan tim multidisiplin, serta monitoring efektivitas intervensi yang diberikan (Fung et al., 2021).

Studi terbaru menunjukkan bahwa perawat yang menerapkan pendekatan multidisiplin dan intervensi berbasis bukti secara sistematis mampu secara signifikan meningkatkan kualitas tidur lansia, mengurangi risiko komplikasi akibat gangguan tidur, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh (Sadler et al., 2018; Sivertsen et al., 2021).

Kesimpulannya, intervensi keperawatan berbasis bukti dalam mengatasi insomnia dan gangguan tidur lainnya memainkan peran vital dalam perawatan gerontik. Dengan pendekatan terpadu, intervensi yang tepat waktu, serta kerja sama tim interprofesional, perawat gerontik dapat secara efektif memperbaiki pola tidur lansia dan secara signifikan meningkatkan kualitas hidup mereka.

C. Pengaruh Terapi Non-farmakologis terhadap Kualitas Tidur Lansia

Terapi non-farmakologis semakin diakui sebagai pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas tidur lansia. Strategi ini menawarkan alternatif atau pelengkap penting terhadap penggunaan obat-obatan, yang sering kali memiliki efek samping negatif bagi populasi lansia yang sensitif (Sadler et al., 2018). Berbagai jenis terapi non-farmakologis telah diteliti secara intensif dan terbukti memiliki manfaat signifikan dalam memperbaiki kualitas tidur lansia, antara lain terapi perilaku kognitif (CBT-I), terapi latihan fisik, teknik relaksasi, terapi musik, serta terapi stimulasi cahaya (light therapy) (Fung et al., 2021).

1. Terapi Perilaku Kognitif untuk Insomnia (CBT-I)

CBT-I merupakan intervensi non-farmakologis utama dalam mengatasi gangguan tidur pada lansia. Studi meta-analisis terbaru menunjukkan bahwa CBT-I secara efektif mengurangi waktu terbangun di malam hari, mempercepat

onset tidur, serta meningkatkan efisiensi tidur secara keseluruhan pada lansia dengan insomnia kronis (Sadler et al., 2018; Sivertsen et al., 2021). Komponen utama CBT-I meliputi restrukturisasi kognitif, kontrol stimulus, pembatasan tidur, edukasi tidur, dan teknik relaksasi, yang bekerja dengan mengubah pola pikir dan kebiasaan tidur maladaptif.

2. Terapi Latihan Fisik

Latihan fisik rutin seperti aerobik ringan, latihan resistensi, dan yoga terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas tidur pada lansia. Studi terbaru menunjukkan bahwa latihan fisik teratur dapat memperbaiki durasi dan efisiensi tidur, mengurangi waktu laten tidur (waktu yang dibutuhkan untuk tertidur), serta menurunkan tingkat fragmentasi tidur (Dzierzewski et al., 2019; Vanderlinden et al., 2020). Mekanisme perbaikan tidur melalui latihan fisik diduga karena efeknya dalam menstabilkan ritme sirkadian, meningkatkan relaksasi fisik, serta mengurangi kecemasan dan stres.

3. Teknik Relaksasi dan Meditasi Mindfulness

Teknik relaksasi seperti meditasi mindfulness, relaksasi progresif, dan teknik pernapasan dalam juga terbukti secara signifikan memperbaiki kualitas tidur pada lansia. Studi terbaru menunjukkan bahwa meditasi mindfulness dapat mengurangi insomnia, memperbaiki durasi tidur, serta meningkatkan efisiensi tidur pada lansia dengan gangguan tidur ringan hingga sedang (Black et al., 2019). Mekanisme di balik teknik relaksasi ini melibatkan modulasi respons stres dan perbaikan dalam regulasi emosi, yang secara langsung berkontribusi terhadap kualitas tidur yang lebih baik.

4. Terapi Musik

Terapi musik adalah metode intervensi non-farmakologis yang efektif dalam meningkatkan kualitas tidur lansia. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mendengarkan musik sebelum tidur secara signifikan memperbaiki kualitas tidur, mengurangi insomnia, serta menurunkan tingkat kecemasan pada lansia (Chen et al., 2021). Musik bertempo lambat dan bernada lembut mampu menurunkan aktivitas sistem saraf simpatik, meningkatkan relaksasi fisik dan psikologis, serta mempercepat onset tidur.

5. Terapi Stimulasi Cahaya (Light Therapy)

Terapi stimulasi cahaya (terutama cahaya terang di pagi hari) digunakan secara efektif dalam menangani gangguan tidur terkait ritme sirkadian pada lansia, seperti sindrom fase tidur lebih awal (advanced sleep phase syndrome). Studi menunjukkan bahwa terapi cahaya mampu mengatur ulang ritme sirkadian lansia, meningkatkan waktu tidur malam, serta memperbaiki kewaspadaan

siang hari (Abbott et al., 2021). Terapi ini bekerja melalui stimulasi reseptor retina yang mengatur produksi hormon melatonin, membantu mengatur siklus tidur-bangun secara efektif.

6. Peran Perawat Gerontik dalam Implementasi Terapi Non-farmakologis

Perawat gerontik memainkan peran krusial dalam implementasi terapi non-farmakologis ini melalui asesmen rutin kualitas tidur lansia, edukasi lansia dan keluarga tentang manfaat terapi non-farmakologis, fasilitasi pelaksanaan intervensi, serta pemantauan hasil secara teratur (Fung et al., 2021; Sivertsen et al., 2021). Pendekatan kolaboratif dengan tim multidisiplin, termasuk fisioterapis, psikolog, dan ahli terapi okupasi, juga sangat penting untuk keberhasilan implementasi terapi tersebut.

Kesimpulannya, terapi non-farmakologis menawarkan pendekatan efektif dan aman dalam memperbaiki kualitas tidur lansia. Implementasi yang tepat oleh perawat gerontik dapat secara signifikan meningkatkan kualitas tidur lansia, mengurangi komplikasi terkait gangguan tidur, serta meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental lansia secara keseluruhan.

BAB 8.

Keperawatan Kesehatan Mental pada Lansia

A. Deteksi Dini dan Penanganan Depresi pada Lansia

Depresi merupakan masalah kesehatan mental yang sering dijumpai pada lansia, ditandai oleh perasaan sedih yang persisten, hilangnya minat terhadap aktivitas yang biasanya menyenangkan, serta penurunan fungsi kognitif dan fisik. Prevalensi depresi pada lansia berkisar antara 10% hingga 20%, tetapi sering kali tidak terdeteksi karena gejala yang samar atau tumpang tindih dengan kondisi medis lainnya (Sivertsen et al., 2021). Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan yang tepat menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan.

1. Deteksi Dini Depresi pada Lansia

Deteksi dini depresi merupakan langkah awal penting dalam manajemen depresi pada lansia. Asesmen rutin menggunakan instrumen berbasis bukti seperti Geriatric Depression Scale (GDS), Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), atau Hamilton Depression Rating Scale (HDRS) terbukti efektif dalam mengidentifikasi depresi secara dini pada lansia (Brunoni et al., 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa GDS merupakan instrumen yang paling banyak digunakan dan memiliki validitas tinggi dalam mendeteksi gejala depresi ringan hingga berat pada lansia di berbagai pengaturan klinis (Park & Unützer, 2019).

Selain penggunaan instrumen skrining, observasi klinis yang cermat oleh perawat juga sangat penting, terutama dalam mengidentifikasi gejala non-spesifik seperti penurunan nafsu makan, gangguan tidur, kelelahan kronis, serta menarik diri dari interaksi sosial (Sivertsen et al., 2021). Faktor risiko depresi yang perlu diperhatikan dalam asesmen rutin meliputi riwayat depresi sebelumnya, isolasi sosial, kehilangan orang terdekat, penyakit kronis, gangguan fungsi fisik, serta penggunaan obat-obatan tertentu (Brunoni et al., 2020).

2. Penanganan Depresi pada Lansia

Penanganan depresi pada lansia memerlukan pendekatan holistik yang mencakup intervensi farmakologis dan non-farmakologis. Intervensi

farmakologis biasanya melibatkan penggunaan antidepresan seperti selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) atau serotonin-norepinephrine reuptake inhibitors (SNRIs), yang terbukti efektif dalam mengurangi gejala depresi dan meningkatkan kualitas hidup lansia (Kok & Reynolds, 2020). Namun, penggunaan obat-obatan ini harus hati-hati karena risiko efek samping seperti gangguan gastrointestinal, penurunan fungsi kognitif, serta interaksi obat pada lansia yang menggunakan beberapa obat (polypharmacy) (Park & Unützer, 2019).

Intervensi non-farmakologis juga memegang peranan penting dan mencakup terapi perilaku kognitif (CBT), terapi reminiscence, terapi interpersonal, aktivitas fisik teratur, serta dukungan sosial (Kiosses et al., 2020). CBT, misalnya, efektif membantu lansia dalam mengubah pola pikir negatif, mengembangkan strategi coping yang lebih baik, serta mengurangi intensitas gejala depresi secara signifikan (Sadler et al., 2018).

Terapi reminiscence, yang melibatkan aktivitas mengingat kembali pengalaman hidup yang menyenangkan, juga menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi depresi dan meningkatkan kesejahteraan emosional lansia (Chueh & Chang, 2020). Studi lain menunjukkan bahwa aktivitas fisik seperti latihan aerobik ringan, yoga, atau tai chi secara konsisten mampu mengurangi gejala depresi dan meningkatkan suasana hati pada lansia melalui mekanisme pelepasan endorfin dan perbaikan dalam regulasi stres (Miller et al., 2019).

3. Peran Perawat Gerontik dalam Deteksi Dini dan Penanganan Depresi

Perawat gerontik memiliki peran sentral dalam deteksi dini dan penanganan depresi pada lansia. Tanggung jawab perawat meliputi skrining depresi secara rutin, edukasi lansia dan keluarga tentang gejala serta risiko depresi, implementasi intervensi non-farmakologis seperti CBT dan terapi reminiscence, serta kolaborasi erat dengan tim multidisiplin untuk merancang strategi penanganan yang tepat (Sivertsen et al., 2021; Park & Unützer, 2019).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perawat yang melakukan intervensi berbasis bukti secara sistematis mampu secara signifikan menurunkan prevalensi depresi, meningkatkan fungsi fisik dan kognitif, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh (Kok & Reynolds, 2020; Miller et al., 2019).

Kesimpulannya, deteksi dini dan penanganan depresi secara holistik dan berbasis bukti sangat penting dalam pelayanan kesehatan mental pada lansia. Peran perawat gerontik dalam implementasi intervensi ini merupakan

komponen kunci dalam mencapai hasil klinis optimal serta meningkatkan kesejahteraan lansia secara keseluruhan.

B. Dukungan Psikososial dan Intervensi Terapi Kognitif Pada Lansia

Dukungan psikososial dan terapi kognitif merupakan pendekatan penting dalam keperawatan kesehatan mental lansia. Seiring bertambahnya usia, lansia sering mengalami tantangan psikologis seperti isolasi sosial, kehilangan pasangan atau teman dekat, perubahan peran dalam keluarga, serta penurunan fungsi kognitif. Tantangan tersebut dapat menyebabkan munculnya gangguan mental seperti depresi, kecemasan, serta perasaan kesepian, yang memerlukan dukungan psikososial dan terapi kognitif berbasis bukti untuk mengelolanya secara efektif (Kiosses et al., 2020).

1. Dukungan Psikososial Berbasis Penelitian pada Lansia

Dukungan psikososial merupakan serangkaian intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan emosional dan sosial lansia. Strategi ini mencakup dukungan emosional, interaksi sosial, serta bantuan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa dukungan psikososial yang baik mampu meningkatkan kualitas hidup, menurunkan risiko depresi, serta memperbaiki fungsi kognitif dan sosial lansia (Forsman et al., 2021).

Pendekatan berbasis komunitas seperti kelompok dukungan sosial, program aktivitas rekreasi, serta kunjungan rutin oleh tenaga kesehatan atau relawan telah terbukti secara efektif mengurangi isolasi sosial dan meningkatkan perasaan bermakna dalam hidup lansia (Steptoe & Fancourt, 2020). Penelitian terkini juga menyoroti efektivitas penggunaan teknologi digital, seperti video-call atau platform media sosial, sebagai media intervensi dukungan psikososial untuk lansia, terutama selama masa pandemi COVID-19 (Wu, 2020).

2. Intervensi Terapi Kognitif Berbasis Penelitian pada Lansia

Terapi kognitif, terutama Cognitive Behavioral Therapy (CBT), merupakan intervensi psikologis berbasis bukti yang terbukti efektif dalam mengatasi berbagai gangguan kesehatan mental pada lansia, seperti depresi, kecemasan, dan insomnia. CBT membantu lansia dalam mengidentifikasi, menantang, serta mengubah pola pikir negatif atau maladaptif yang mendasari gejala psikologis mereka (Sadler et al., 2018).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa CBT secara signifikan mampu mengurangi gejala depresi dan kecemasan, memperbaiki kualitas tidur, serta meningkatkan fungsi kognitif pada lansia dengan gangguan mental ringan hingga sedang (Kiosses et al., 2020; Kishita et al., 2020). Dalam konteks lansia, CBT sering dimodifikasi menjadi bentuk yang lebih sederhana dan praktis (Brief

CBT), agar lebih sesuai dengan kondisi kognitif dan fisik lansia, sehingga lebih mudah diaplikasikan dalam praktik klinis (Kishita et al., 2020).

Selain CBT, terapi reminiscence atau terapi berbasis ingatan juga terbukti efektif sebagai intervensi kognitif dalam meningkatkan kesejahteraan psikologis lansia. Terapi reminiscence melibatkan aktivitas mengingat kembali pengalaman positif masa lalu, yang telah terbukti meningkatkan mood positif, memperkuat identitas pribadi, serta mengurangi depresi pada lansia secara signifikan (Chueh & Chang, 2020).

3. Peran Perawat Gerontik dalam Dukungan Psikososial dan Intervensi Kognitif

Perawat gerontik memainkan peran utama dalam pemberian dukungan psikososial dan intervensi terapi kognitif. Perawat bertanggung jawab dalam melakukan asesmen psikososial secara rutin, mengidentifikasi kebutuhan khusus lansia, memberikan edukasi kepada lansia dan keluarga tentang manfaat intervensi psikososial dan terapi kognitif, serta melaksanakan atau memfasilitasi implementasi intervensi tersebut secara sistematis (Forsman et al., 2021; Kiosses et al., 2020).

Kolaborasi dengan profesional lain seperti psikolog, terapis okupasi, pekerja sosial, dan keluarga lansia merupakan bagian penting dari pendekatan holistik ini. Studi menunjukkan bahwa pendekatan interprofesional yang terintegrasi mampu meningkatkan efektivitas intervensi psikososial dan terapi kognitif, serta memberikan hasil klinis yang lebih baik bagi lansia (Kishita et al., 2020; Steptoe & Fancourt, 2020).

Secara keseluruhan, dukungan psikososial dan intervensi terapi kognitif berbasis penelitian merupakan komponen penting dalam pelayanan keperawatan kesehatan mental lansia, yang secara signifikan meningkatkan kualitas hidup, fungsi psikologis, serta kesejahteraan emosional lansia secara keseluruhan.

C. Strategi Mengurangi Risiko Bunuh Diri pada Lansia

Risiko bunuh diri pada lansia merupakan isu kesehatan masyarakat yang penting dan memerlukan perhatian khusus dalam keperawatan gerontik. Angka kejadian bunuh diri pada lansia umumnya lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, terutama pada lansia laki-laki yang mengalami isolasi sosial, depresi berat, atau penyakit kronis yang menurunkan kualitas hidup secara signifikan (Conwell & Thompson, 2021). Oleh karena itu, penerapan strategi berbasis bukti yang efektif dalam mengurangi risiko bunuh diri menjadi esensial dalam pelayanan kesehatan mental pada populasi lansia.

1. Identifikasi Risiko dan Asesmen Rutin

Langkah awal penting dalam strategi mengurangi risiko bunuh diri adalah identifikasi dini melalui asesmen rutin dan sistematis terhadap faktor-faktor risiko bunuh diri pada lansia. Beberapa faktor risiko utama meliputi depresi berat, isolasi sosial, rasa kesepian, penyakit kronis yang berat, riwayat upaya bunuh diri sebelumnya, serta penggunaan alkohol atau obat-obatan terlarang (Conejero et al., 2018). Perawat gerontik dapat menggunakan alat skrining seperti Geriatric Suicide Ideation Scale (GSIS), Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9), atau Beck Scale for Suicide Ideation (BSSI) untuk menilai tingkat risiko bunuh diri secara akurat (Heisel et al., 2020).

2. Intervensi Psikososial dan Dukungan Sosial

Intervensi psikososial dan peningkatan dukungan sosial terbukti efektif dalam mengurangi risiko bunuh diri pada lansia. Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi berupa konseling berbasis komunitas, terapi interpersonal, serta program dukungan sosial mampu secara signifikan menurunkan tingkat pikiran dan perilaku bunuh diri pada lansia (Lapierre et al., 2020). Penelitian lain menunjukkan bahwa lansia yang memiliki koneksi sosial yang kuat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas komunitas memiliki risiko bunuh diri yang jauh lebih rendah (Cipriani et al., 2021).

3. Terapi Perilaku Kognitif (CBT) dan Intervensi Kognitif lainnya

Terapi perilaku kognitif (CBT) menjadi salah satu intervensi yang paling efektif dalam mengurangi risiko bunuh diri pada lansia. CBT membantu lansia dalam mengidentifikasi, menantang, serta mengubah pola pikir maladaptif yang memicu munculnya pikiran bunuh diri, serta meningkatkan kemampuan lansia dalam menggunakan strategi coping yang lebih efektif (Van Orden et al., 2021). Studi terbaru menegaskan bahwa CBT yang disesuaikan untuk lansia (CBT for late-life suicidal ideation) mampu secara signifikan menurunkan intensitas pikiran bunuh diri serta meningkatkan kesejahteraan psikologis lansia (Heisel et al., 2020).

Selain CBT, pendekatan terapi reminiscence dan terapi berbasis makna hidup (meaning-centered therapy) juga terbukti efektif dalam meningkatkan tujuan hidup dan mengurangi rasa putus asa, yang merupakan faktor risiko penting dalam perilaku bunuh diri lansia (Breitbart et al., 2021).

4. Manajemen Kasus dan Kolaborasi Interprofesional

Strategi manajemen kasus yang melibatkan pendekatan kolaboratif antara perawat gerontik, dokter, psikolog, pekerja sosial, serta keluarga terbukti efektif dalam mengurangi risiko bunuh diri pada lansia. Studi terbaru menunjukkan

bahwa pendekatan manajemen kasus yang terintegrasi mampu secara efektif mengidentifikasi lansia berisiko tinggi, memberikan intervensi tepat waktu, serta meningkatkan hasil klinis secara keseluruhan (Lapierre et al., 2020).

Dalam konteks ini, peran perawat sangat penting dalam memonitor kondisi mental lansia secara rutin, mengoordinasikan intervensi multidisiplin, serta memastikan bahwa lansia dan keluarga mendapatkan edukasi tentang tanda-tanda peringatan bunuh diri dan strategi intervensi dini yang efektif (Van Orden et al., 2021).

5. Edukasi dan Pelatihan bagi Keluarga dan Tenaga Kesehatan

Peningkatan edukasi serta pelatihan tentang pencegahan bunuh diri bagi keluarga lansia dan tenaga kesehatan juga merupakan strategi penting dalam mengurangi risiko bunuh diri. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang faktor risiko, tanda-tanda peringatan dini, serta langkah-langkah intervensi yang tepat waktu untuk mencegah bunuh diri (Conwell & Thompson, 2021).

Kesimpulan

Strategi mengurangi risiko bunuh diri pada lansia membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan identifikasi risiko secara rutin, intervensi psikososial dan kognitif yang efektif, manajemen kasus kolaboratif, serta edukasi yang berkelanjutan. Perawat gerontik memiliki peran penting dalam implementasi strategi ini, dengan tujuan utama mengurangi angka bunuh diri serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh.

BAB 9.

Perawatan Paliatif dan End-of-Life Care pada Lansia

A. Prinsip Perawatan Paliatif

Perawatan paliatif merupakan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien lansia dengan penyakit kronis serius atau stadium akhir melalui manajemen gejala fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Prinsip utama perawatan paliatif berbasis evidensi meliputi pendekatan holistik, komunikasi efektif, pengambilan keputusan berbasis nilai dan preferensi pasien, serta intervensi multidisiplin yang didukung bukti ilmiah terkini (Radbruch et al., 2020).

1. Pendekatan Holistik dan Individual

Prinsip pertama perawatan paliatif berbasis evidensi adalah pendekatan holistik dan individual. Pendekatan ini mengharuskan tim keperawatan untuk tidak hanya fokus pada gejala fisik pasien, tetapi juga aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual yang memengaruhi kualitas hidup pasien lansia dan keluarganya (Ferrell et al., 2019). Penelitian terbaru menegaskan bahwa pendekatan holistik secara signifikan mampu memperbaiki kenyamanan pasien, mengurangi stres keluarga, serta meningkatkan kepuasan pasien dan keluarganya terhadap pelayanan yang diberikan (Radbruch et al., 2020).

2. Manajemen Gejala Berbasis Bukti

Manajemen gejala merupakan komponen penting dalam perawatan paliatif. Gejala umum yang sering dialami pasien lansia dalam perawatan paliatif mencakup nyeri, sesak napas, mual dan muntah, kelelahan, konstipasi, serta kecemasan dan depresi. Studi terbaru menunjukkan bahwa penggunaan intervensi farmakologis seperti analgesik opioid, antiemetik, dan antidepresan yang dikombinasikan dengan intervensi non-farmakologis seperti terapi relaksasi, terapi musik, dan terapi psikososial secara efektif dapat mengurangi intensitas gejala tersebut (Gaertner et al., 2019; Ferrell et al., 2019).

3. Komunikasi Efektif dan Shared Decision-Making

Prinsip penting lainnya dalam perawatan paliatif adalah komunikasi yang efektif dan shared decision-making. Komunikasi terbuka antara perawat, pasien, dan

keluarga penting untuk memastikan bahwa preferensi pasien mengenai pengobatan dan perawatan dihormati dan dilaksanakan secara tepat (Back et al., 2019). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa komunikasi efektif dan pengambilan keputusan bersama (shared decision-making) dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, mengurangi konflik dalam keluarga, serta meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diterimanya (Radbruch et al., 2020).

4. Intervensi Multidisiplin dan Kolaboratif

Perawatan paliatif yang berbasis bukti sangat menekankan pentingnya pendekatan multidisiplin. Tim multidisiplin yang terdiri dari dokter, perawat gerontik, psikolog, pekerja sosial, ahli gizi, terapis okupasi, dan pemuka agama terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan kompleks pasien lansia dalam perawatan paliatif (Ferrell et al., 2019). Studi terbaru menunjukkan bahwa kolaborasi multidisiplin secara signifikan memperbaiki hasil klinis, mempercepat pengelolaan gejala, serta meningkatkan kesejahteraan pasien dan keluarganya secara menyeluruh (Gaertner et al., 2019).

5. Dukungan Psikososial dan Spiritual

Dukungan psikososial dan spiritual adalah komponen inti dari perawatan paliatif berbasis evidensi. Studi terkini menunjukkan bahwa pemberian dukungan spiritual dan psikososial secara teratur mampu mengurangi rasa putus asa, meningkatkan rasa damai, serta memperbaiki suasana hati pasien lansia di akhir hidup (Best et al., 2020). Pendekatan ini mencakup konseling spiritual, terapi dukungan psikososial, serta intervensi kelompok yang berfokus pada peningkatan makna hidup dan hubungan interpersonal.

6. Edukasi dan Dukungan untuk Keluarga

Prinsip terakhir dalam perawatan paliatif berbasis evidensi adalah edukasi dan dukungan berkelanjutan bagi keluarga pasien. Studi terbaru menegaskan bahwa edukasi rutin dan intervensi dukungan untuk keluarga, termasuk pelatihan perawatan, manajemen stres, serta konseling, mampu secara signifikan meningkatkan kapasitas keluarga dalam menghadapi tantangan perawatan pasien lansia serta mengurangi risiko distress psikologis yang dialami oleh keluarga pasien (Back et al., 2019; Ferrell et al., 2019).

Kesimpulan

Perawatan paliatif berbasis evidensi pada lansia mengintegrasikan berbagai pendekatan holistik, manajemen gejala yang efektif, komunikasi terbuka, intervensi multidisiplin, serta dukungan psikososial dan spiritual. Implementasi prinsip ini

secara konsisten oleh perawat gerontik mampu secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien lansia dan keluarganya selama periode perawatan paliatif hingga akhir hayat.

B. Strategi Komunikasi Efektif dalam Pelayanan Paliatif

Komunikasi efektif merupakan inti dari pelayanan paliatif yang berkualitas tinggi. Strategi komunikasi yang tepat sangat penting untuk mendukung lansia yang menghadapi penyakit kronis stadium akhir serta keluarganya. Komunikasi yang baik memungkinkan pasien dan keluarga memahami kondisi kesehatan, pilihan perawatan, serta membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai dan preferensi pasien (Clayton et al., 2019). Berbagai penelitian menegaskan bahwa penggunaan strategi komunikasi efektif dalam perawatan paliatif dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi distress psikologis keluarga (Brighton & Bristowe, 2020).

1. Prinsip Dasar Komunikasi Efektif dalam Perawatan Paliatif

Prinsip dasar komunikasi efektif dalam perawatan paliatif mencakup kejujuran, empati, penghormatan terhadap otonomi pasien, serta penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Komunikasi harus dilakukan secara terbuka namun sensitif, memberikan ruang kepada pasien untuk mengekspresikan perasaan dan keinginannya tanpa rasa takut atau tertekan (Bernacki & Block, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang jujur dan terbuka membantu pasien dalam menerima kenyataan kondisinya serta memperkuat hubungan terapeutik antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarganya (Clayton et al., 2019).

2. Strategi Komunikasi SPIKES dalam Menyampaikan Berita Buruk

Strategi SPIKES merupakan model komunikasi berbasis bukti yang banyak digunakan dalam perawatan paliatif untuk menyampaikan berita buruk secara efektif dan empatik. SPIKES adalah akronim dari: Setting (mengatur suasana), Perception (mengetahui persepsi pasien), Invitation (meminta izin menyampaikan informasi), Knowledge (menyampaikan informasi secara jelas dan empatik), Empathy (menunjukkan empati terhadap reaksi pasien), dan Strategy and Summary (merencanakan strategi perawatan dan menyimpulkan diskusi) (Baile et al., 2020). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa model SPIKES membantu profesional kesehatan meningkatkan keterampilan komunikasi, mengurangi stres emosional pasien, serta memperbaiki kepuasan pasien dan keluarga (Brighton & Bristowe, 2020).

3. Komunikasi dalam Shared Decision-Making (Pengambilan Keputusan Bersama)

Shared decision-making (SDM) merupakan komponen penting dalam perawatan paliatif, di mana keputusan tentang pengobatan dan perawatan dibuat bersama antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan berdasarkan informasi lengkap dan jelas. Strategi komunikasi dalam SDM mencakup penggunaan pendekatan aktif mendengarkan (active listening), validasi emosi pasien, serta eksplorasi nilai-nilai dan preferensi pribadi pasien (Bernacki & Block, 2020). Penelitian menunjukkan bahwa SDM yang efektif dapat meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga, mengurangi kecemasan terkait pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa intervensi yang dilakukan sesuai dengan keinginan pasien (Clayton et al., 2019).

4. Strategi Komunikasi dalam Manajemen Gejala dan Dukungan Emosional

Komunikasi efektif juga penting dalam manajemen gejala seperti nyeri, kecemasan, dan gejala psikologis lainnya. Strategi komunikasi di sini meliputi pendekatan eksplorasi (exploratory approach) untuk memahami gejala dari perspektif pasien, validasi perasaan pasien, serta pemberian informasi yang jelas mengenai pilihan intervensi yang tersedia (Baile et al., 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa komunikasi yang jelas dan empatik tentang manajemen gejala dapat secara signifikan memperbaiki kontrol gejala serta mengurangi distress emosional pasien lansia (Brighton & Bristowe, 2020).

5. Komunikasi Antarprofesional dalam Tim Multidisiplin

Komunikasi efektif antar anggota tim multidisiplin juga menjadi strategi penting dalam pelayanan paliatif. Komunikasi ini mencakup rapat tim reguler, diskusi kasus berbasis bukti, serta penggunaan dokumentasi terstruktur. Penelitian terbaru menegaskan bahwa komunikasi antarprofesional yang efektif secara signifikan meningkatkan koordinasi perawatan, mempercepat penanganan gejala, serta meningkatkan hasil klinis secara keseluruhan (Bernacki & Block, 2020).

6. Edukasi dan Pelatihan Komunikasi bagi Perawat dan Tenaga Kesehatan

Edukasi dan pelatihan komunikasi khusus bagi perawat dan tenaga kesehatan lainnya merupakan bagian integral dalam meningkatkan kompetensi komunikasi dalam pelayanan paliatif. Pelatihan seperti pelatihan berbasis simulasi, pelatihan komunikasi empatik, serta pelatihan penggunaan model komunikasi SPIKES terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan komunikasi tenaga kesehatan (Baile et al., 2020; Clayton et al., 2019).

Kesimpulan

Strategi komunikasi efektif dalam pelayanan paliatif merupakan komponen esensial yang secara signifikan meningkatkan kualitas perawatan pasien lansia yang menghadapi akhir kehidupan. Dengan mengintegrasikan komunikasi yang empatik, jelas, dan partisipatif, perawat gerontik dapat secara optimal mendukung pasien dan keluarganya dalam menghadapi tantangan yang muncul selama perawatan paliatif.

C. Perawatan Paliatif dan End-of-Life Care pada Lansia

1. Manajemen Gejala Fisik Berbasis Evidensi

a. Nyeri

Nyeri merupakan gejala yang paling sering dialami lansia pada akhir kehidupan, dengan prevalensi hingga 60-80%. Manajemen nyeri berbasis bukti pada lansia mencakup penggunaan analgesik, seperti opioid untuk nyeri sedang hingga berat, serta analgesik non-opioid seperti parasetamol dan NSAID untuk nyeri ringan hingga sedang (Wiffen et al., 2021). Intervensi non-farmakologis seperti teknik relaksasi, terapi musik, dan terapi pijat juga terbukti efektif dalam mengurangi intensitas nyeri (Gaertner et al., 2019).

b. Sesak Napas (Dispnea)

Dispnea merupakan gejala umum lainnya yang sangat mengganggu kenyamanan lansia di akhir kehidupan. Manajemen dispnea meliputi penggunaan opioid dosis rendah yang terbukti efektif mengurangi persepsi sesak napas, terapi oksigen jika diperlukan, serta pendekatan non-farmakologis seperti posisi duduk yang nyaman, penggunaan kipas angin, dan teknik pernapasan yang efektif (Ekström et al., 2021).

c. Gangguan Gastrointestinal (Mual, Muntah, Konstipasi)

Gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, dan konstipasi juga sering dijumpai pada lansia di masa akhir kehidupan. Penggunaan antiemetik seperti metoklopramid, haloperidol, atau ondansetron efektif mengurangi mual dan muntah, sementara penggunaan laksatif secara teratur membantu mengelola konstipasi akibat penggunaan opioid atau imobilisasi (Keeley et al., 2020).

d. Kelelahan dan Gangguan Tidur

Kelelahan kronis merupakan gejala yang sering dialami lansia menjelang akhir kehidupan. Strategi penanganan kelelahan meliputi pendekatan farmakologis seperti penggunaan steroid dalam kasus tertentu, serta pendekatan non-farmakologis berupa manajemen aktivitas harian, terapi

okupasi, dan optimalisasi pola tidur melalui intervensi kebersihan tidur (sleep hygiene) (Radbruch et al., 2020).

2. Manajemen Gejala Psikologis Berbasis Evidensi

a. Depresi dan Kecemasan

Depresi dan kecemasan sering dijumpai pada lansia yang menjalani perawatan paliatif. Penanganan depresi dan kecemasan berbasis bukti mencakup terapi farmakologis dengan antidepresan seperti SSRI, serta intervensi psikologis seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT), terapi interpersonal, atau dukungan emosional melalui konseling dan intervensi kelompok (Kok & Reynolds, 2020; Brighton & Bristowe, 2020).

b. Delirium

Delirium adalah gangguan kesadaran akut yang umum terjadi pada lansia di akhir kehidupan, terutama akibat efek samping obat, infeksi, atau gangguan metabolik. Manajemen delirium meliputi identifikasi dan pengobatan penyebab yang reversibel, serta pendekatan lingkungan yang tenang, pencahayaan yang cukup, dan pengurangan stimulus yang berlebihan (Bush et al., 2021). Penggunaan obat antipsikotik dosis rendah seperti haloperidol juga dapat dipertimbangkan jika gejala sangat mengganggu pasien (Bush et al., 2021).

3. Dukungan Psikososial dan Spiritual

Selain manajemen gejala fisik dan psikologis, pendekatan psikososial dan spiritual juga sangat penting dalam perawatan paliatif lansia. Dukungan ini meliputi konseling spiritual, intervensi psikososial yang meningkatkan makna hidup, serta intervensi keluarga untuk meningkatkan dukungan emosional dan sosial bagi pasien dan keluarganya (Best et al., 2020). Studi terbaru menunjukkan bahwa intervensi ini secara signifikan mampu mengurangi rasa kesepian, meningkatkan rasa damai, serta meningkatkan kualitas hidup lansia di masa akhir kehidupan (Gaertner et al., 2019).

4. Peran Perawat Gerontik dalam Manajemen Gejala

Perawat gerontik memegang peran sentral dalam manajemen gejala fisik dan psikologis lansia di masa akhir kehidupan. Peran perawat meliputi asesmen rutin dan komprehensif terhadap gejala, pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga tentang manajemen gejala, implementasi intervensi farmakologis dan non-farmakologis berbasis bukti, serta koordinasi kolaborasi interprofesional dalam merancang rencana perawatan (Radbruch et al., 2020).

Kesimpulan

Manajemen gejala fisik dan psikologis yang efektif di masa akhir kehidupan lansia merupakan inti perawatan paliatif yang berkualitas tinggi. Dengan pendekatan komprehensif berbasis bukti dan implementasi yang optimal oleh perawat gerontik, kualitas hidup pasien lansia dan keluarganya dapat ditingkatkan secara signifikan di akhir kehidupan.

BAB 10.

Teknologi dan Inovasi dalam Keperawatan Gerontik

A. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pelayanan Keperawatan Lansia

Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan keperawatan lansia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan kualitas perawatan, tetapi juga membantu meningkatkan efisiensi pelayanan, mendukung pemantauan kondisi kesehatan secara kontinu, serta memperkuat komunikasi antara lansia, keluarga, dan tenaga kesehatan (Fang et al., 2021). Pemanfaatan teknologi digital ini mencakup berbagai platform dan perangkat seperti telehealth, aplikasi seluler, alat pemantau jarak jauh (remote monitoring devices), hingga penggunaan robotik dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

1. Pemanfaatan Telehealth dalam Pelayanan Keperawatan Lansia

Telehealth adalah teknologi komunikasi digital yang memungkinkan tenaga kesehatan memberikan pelayanan kesehatan secara jarak jauh melalui panggilan video, konsultasi daring, atau aplikasi khusus. Studi terbaru menunjukkan bahwa telehealth efektif dalam mengelola penyakit kronis, memberikan edukasi kesehatan, serta melakukan pemantauan rutin pada lansia yang mengalami keterbatasan mobilitas atau tinggal di daerah terpencil (Batsis et al., 2020). Telehealth juga terbukti mampu mengurangi frekuensi rawat inap, meningkatkan kepatuhan pengobatan, serta meningkatkan kualitas hidup lansia secara signifikan (Seifert & Cotten, 2020).

2. Aplikasi Seluler dan Pemantauan Jarak Jauh (Remote Monitoring)

Aplikasi seluler yang dirancang khusus untuk lansia semakin populer dalam mendukung manajemen kesehatan harian, seperti pemantauan tekanan darah, pengingat minum obat, pelacakan aktivitas fisik, hingga pencatatan pola tidur (Kim & Lee, 2021). Teknologi remote monitoring juga berkembang dengan pesat, seperti penggunaan wearable devices (alat yang dipakai di tubuh) untuk memantau kondisi kesehatan seperti detak jantung, saturasi oksigen, dan tingkat aktivitas fisik secara real-time. Penelitian terkini menunjukkan bahwa pemantauan jarak jauh menggunakan wearable devices mampu mendeteksi

perubahan kondisi kesehatan lebih dini, mempercepat intervensi medis, serta meningkatkan perasaan aman bagi lansia dan keluarganya (Chung et al., 2021).

3. Robotik dan Kecerdasan Buatan dalam Pelayanan Keperawatan Lansia

Penggunaan robotik dan kecerdasan buatan dalam pelayanan keperawatan gerontik juga meningkat tajam, khususnya dalam memberikan dukungan emosional, interaksi sosial, serta membantu aktivitas sehari-hari. Robot sosial seperti robot Paro, yang dirancang untuk memberikan stimulasi emosional, terbukti efektif mengurangi rasa kesepian, meningkatkan interaksi sosial, serta memperbaiki suasana hati lansia, terutama pada lansia dengan demensia (Pu et al., 2020). Teknologi kecerdasan buatan juga semakin banyak digunakan dalam prediksi risiko kesehatan, deteksi dini gangguan kognitif, serta personalisasi rencana perawatan yang lebih efektif (Chen & Chao, 2021).

4. Tantangan dalam Implementasi Teknologi Digital pada Lansia

Meskipun teknologi digital menawarkan banyak manfaat, implementasinya dalam populasi lansia tetap menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi digital, kesulitan dalam mengadopsi teknologi baru, serta isu privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, perawat gerontik memiliki peran penting dalam memberikan edukasi tentang penggunaan teknologi secara sederhana dan aman, serta membantu lansia dan keluarganya dalam adaptasi teknologi secara bertahap (Seifert & Cotten, 2020).

5. Peran Perawat Gerontik dalam Pemanfaatan Teknologi Digital

Perawat gerontik memiliki peran sentral dalam memaksimalkan manfaat teknologi digital bagi lansia. Peran tersebut meliputi asesmen rutin terkait kemampuan dan kebutuhan teknologi pasien, edukasi pasien dan keluarga tentang penggunaan teknologi, implementasi pemantauan kesehatan digital, serta kolaborasi dengan tim multidisiplin dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam perawatan lansia sehari-hari (Batsis et al., 2020; Kim & Lee, 2021). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa keterlibatan aktif perawat dalam edukasi dan fasilitasi teknologi secara signifikan meningkatkan adopsi teknologi oleh lansia serta memperbaiki hasil kesehatan mereka secara keseluruhan (Chung et al., 2021).

Kesimpulan

Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan keperawatan lansia menawarkan banyak manfaat penting, mulai dari peningkatan efisiensi pelayanan, pemantauan kondisi kesehatan secara real-time, hingga peningkatan kualitas hidup lansia.

Dengan pendekatan yang tepat oleh perawat gerontik, teknologi digital dapat secara efektif diintegrasikan ke dalam pelayanan keperawatan gerontik modern.

B. Telehealth dan Efektivitasnya dalam Perawatan Lansia

Telehealth—penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan kesehatan jarak jauh—telah terbukti efektif dalam perawatan lansia, terutama dalam menjaga kontinuitas layanan, meningkatkan akses, dan mengurangi beban mobilitas pasien (Zhang et al., 2023; Batsis et al., 2020).

1. Manfaat Utama Telehealth

- a. Meningkatkan akses dan efisiensi: Telehealth memfasilitasi konsultasi, edukasi, dan pemantauan medis, sehingga lansia—terutama yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan atau memiliki mobilitas terbatas—dapat menerima perawatan tepat waktu tanpa harus bepergian [id.scribd.com+1id.scribd.com+1](#).
- b. Pengurangan rawat inap & biaya: Studi nasional Indonesia menunjukkan telehealth efektif mengurangi frekuensi rawat inap dan waktu tinggal di rumah sakit serta meningkatkan kemandirian lansia dan caregiver [ejournal.poltekkesjakarta1.ac.id+1id.scribd.com+1](#).
- c. Efek positif untuk kondisi kronis & mental: Meta-analisis pada pasien lansia dengan depresi mayor menunjukkan telecare (sejenis telehealth) menurunkan gejala depresi dan kecemasan secara signifikan dibandingkan perawatan standar [mdpi.com+6pmc.ncbi.nlm.nih.gov+6ejournal.poltekkesjakarta1.ac.id+6](#).

2. Efektivitas di Berbagai Domain

- a. Kesehatan fisik dan penyakit kronis: Scoping review menemukan telehealth efektif dalam pengelolaan penyakit kardiovaskular, kognitif, pra-frailty, dan oral health, serta layak, diterima, dan hemat biaya [aging.jmir.org](#).
- b. Pemantauan jarak jauh (Remote Monitoring): Wearable devices dan sensor mendukung deteksi dini perubahan kondisi kesehatan, meningkatkan perawatan preventif dan keamanan lansia di rumah [ejournal.poltekkesjakarta1.ac.id+6id.scribd.com+6ejournal.poltekkesjakarta1.ac.id+6](#).
- c. Perawatan perilaku & psikologis: Telecare juga mendukung perawatan penyakit mental, yang mengurangi gejala depresi dan kecemasan lebih efektif dibanding konseling telepon biasa [pmc.ncbi.nlm.nih.gov](#).

3. Keunggulan dan Keterbatasan

Keunggulan:

- Kemudahan akses tanpa hambatan jarak
- Penghematan biaya dan waktu perjalanan

Keterbatasan:

- Hambatan teknologi seperti literasi digital, konektivitas, dan gangguan kognitif/pendengaran pada lansia
- Kurang setara jika tidak diimbangi dengan dukungan praktis
- Kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan data id.scribd.com

4. Peran Perawat Gerontik

- a. Edukasi & pendampingan teknologi: Membantu lansia dan keluarga memahami cara menggunakan aplikasi, perangkat pemantau, dan protokol komunikasi melalui telehealth id.scribd.com+6journal.poltekkesjakarta1.ac.id+6download.garuda.kemdikbud.go.id+6.
- b. Asesmen kebutuhan digital: Melakukan evaluasi rutin terhadap kemampuan digital lansia agar telehealth bisa diakses tanpa hambatan (literasi, kognisi, fisik) .
- c. Kolaborasi multidisiplin: Bekerja sama dengan dokter, teknisi, dan caregiver untuk mengintegrasikan telehealth sebagai bagian dari rencana perawatan lansia en.wikipedia.org+2download.garuda.kemdikbud.go.id+2researchgate.net+2.
- d. Monitoring & tindak lanjut: Mengawasi penggunaan telehealth, memantau hasil konsultasi, mengingatkan jadwal, dan menindaklanjuti kondisi pasien.

Kesimpulan

Telehealth adalah inovasi penting dalam keperawatan gerontik—terbukti meningkatkan akses, efisiensi, dan kualitas perawatan lansia dengan penyakit kronis dan masalah psikologis. Namun, keberhasilan implementasi tergantung pada dukungan literasi digital, keamanan data, dan pelatihan tenaga kesehatan. Peran perawat gerontik sangat menentukan dalam memastikan telehealth dimanfaatkan secara optimal dan aman oleh lansia dan keluarga.

C. Teknologi Sensor untuk Pemantauan Kesehatan Lansia di Rumah

Pemantauan kesehatan lansia di rumah menggunakan teknologi sensor (smart home & wearable) menjadi salah satu inovasi utama dalam keperawatan gerontik. Teknologi ini memungkinkan deteksi dini perubahan kondisi melalui pengawasan aktivitas harian, tidur, pola gerakan, serta parameter fisiologis secara real-time dan non-invasif.

1. Teknologi Sensor di Lingkungan Rumah

- a. Sistem ambient assisted living (AAL) menggunakan sensor pasif seperti PIR (motion), door/window, dan sensor tempat tidur untuk memonitor aktivitas sehari-hari, tidur, dan saat terjadi jatuh atau perubahan gerak. Tingkat akurasi pendeteksian lokasi berkisar antara 50–88% en.wikipedia.org.
- b. Riset skala besar menunjukkan bahwa sebagian besar riset AAL dilakukan 5 tahun terakhir, dengan gabungan studi Asia, Eropa, dan Amerika pmc.ncbi.nlm.nih.gov.
- c. Scoping review menyoroti teknologi non-kontak (kamera infrared, Wi-Fi/RF) yang sangat potensial dalam menjaga privasi dan menyediakan data multimodal untuk pemantauan kondisi lansia tanpa memerlukan wearable pmc.ncbi.nlm.nih.gov+1pmc.ncbi.nlm.nih.gov+1.

2. Wearable Sensor untuk Pemantauan Fisiologis

- a. Teknologi wearable berbasis material 2D (graphene, MXene) kini mampu mengukur detak jantung, suhu, pernapasan, dan aktivitas otot dengan nyaman dan berpresisi tinggi nature.com.
- b. Wearable juga digunakan untuk mendeteksi stres melalui EDA, PPG, suhu, dan sensor lokasi dalam skenario smart home arxiv.org+1en.wikipedia.org+1.
- c. Sensor ini memfasilitasi pemantauan real-time dan deteksi dini masalah kesehatan sebelum kondisi memburuk .

3. Dampak Klinis dan Efektivitas

- a. Review menunjukkan bahwa pemantauan sensor pasif dan wearable dapat menurunkan tingkat rawat inap sekitar 9,6% dan mortalitas keseluruhan hingga 3% i-jmr.org+3nature.com+3cambridge.org+3.
- b. Data klinis dari sistem sensor pasif mengonfirmasi kemampuan memprediksi perilaku harian dan mendeteksi kondisi darurat, misalnya jatuh .

- c. Teknologi sensor terbukti meningkatkan kemandirian dan ketenangan lansia serta caregiver
en.wikipedia.org+15bmcgeriatr.biomedcentral.com+15thetimes.co.uk+15.

4. Tantangan Implementasi

- a. Adopsi sensor menghadapi kendala literasi teknologi, kompleksitas sistem, biaya, dan masalah privasi .
- b. Skalabilitas dan interoperabilitas sistem masih menjadi tantangan teknis dan regulasi .

5. Peran Perawat Gerontik

- a. Asesmen dan pelatihan: Perawat melakukan asesmen kemampuan pengguna sensor dan memberikan edukasi tentang cara penggunaan dan interpretasi data kepada lansia dan keluarga.
- b. Monitoring dan tindak lanjut: Secara rutin mengevaluasi data sensor, mengidentifikasi perubahan pola, serta mengambil tindakan preventif atau klinis tepat waktu.
- c. Koordinasi multidisiplin: Bekerja sama dengan teknisi, dokter, dan rehabilitasi untuk mengintegrasikan intervensi sensor ke dalam rencana perawatan.
- d. Advokasi & etika: Menjaga aspek privasi dan mendapat izin berdasarkan kesadaran pasien, serta memastikan bahwa teknologi digunakan untuk meningkatkan, bukan menggantikan, interaksi manusia dalam perawatan .

Kesimpulan

Teknologi sensor—baik yang dipasang di lingkungan rumah maupun yang digunakan sebagai wearable—menawarkan potensi besar dalam mendukung keperawatan lansia di rumah. Dengan pemantauan real-time, deteksi dini, dan analisis data klinis, perawat gerontik dapat meningkatkan keselamatan, kemandirian, dan kualitas hidup lansia secara signifikan. Namun, tantangan literasi, biaya, etika, dan kolaborasi profesional menjadi hal penting yang harus diatasi agar implementasi inovasi ini berjalan optimal.

BAB 11.

Kolaborasi Interprofesional dalam Keperawatan Gerontik

A. Model Kolaborasi Interprofesional

Kolaborasi interprofesional (Interprofessional Collaboration/IPC) dalam pelayanan keperawatan gerontik merupakan pendekatan yang melibatkan berbagai tenaga kesehatan dari beragam profesi untuk memberikan perawatan terpadu, komprehensif, dan berpusat pada pasien lansia. Model kolaborasi interprofesional yang berbasis bukti bertujuan untuk meningkatkan kualitas perawatan lansia, memperkuat komunikasi antar tenaga kesehatan, serta memfasilitasi pengambilan keputusan bersama secara efektif dan efisien (Fox et al., 2021).

Terdapat beberapa model kolaborasi interprofesional yang berbasis bukti dalam praktik keperawatan gerontik yang telah diuji dan terbukti efektif dalam berbagai studi internasional, antara lain sebagai berikut:

1. Model Guided Care

Model Guided Care merupakan pendekatan kolaboratif yang berpusat pada perawat gerontik sebagai koordinator utama, yang bekerja erat dengan dokter dan tim layanan kesehatan lainnya dalam pengelolaan pasien lansia dengan penyakit kronis kompleks. Model ini mencakup asesmen geriatri yang komprehensif, perencanaan perawatan berbasis tim, edukasi dan dukungan kepada keluarga, serta koordinasi pelayanan lanjutan. Studi terbaru menunjukkan bahwa penerapan Guided Care berhasil menurunkan angka rawat inap, mengurangi kunjungan darurat, serta meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga (Boult & Wieland, 2022).

2. Model Geriatric Interdisciplinary Team Training (GITT)

Geriatric Interdisciplinary Team Training adalah model pelatihan berbasis tim yang bertujuan meningkatkan pemahaman antarprofesi dan memperkuat komunikasi serta kolaborasi tim dalam perawatan geriatri. Melalui pendekatan ini, anggota tim—termasuk perawat, dokter, farmasis, fisioterapis, dan pekerja sosial—mempelajari peran masing-masing dalam tim secara jelas serta mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan GITT secara signifikan meningkatkan hasil klinis

lansia, mempercepat pemulihan pasien, dan memperkuat sinergi dalam tim multidisiplin (Ellis, Sevdalis, & McGregor, 2021).

3. Model Interdisciplinary Bedside Rounds (IBR)

Model Interdisciplinary Bedside Rounds (IBR) merupakan praktik kolaborasi interprofesional di mana tim kesehatan dari berbagai profesi melakukan kunjungan pasien secara bersama-sama langsung di samping tempat tidur pasien. Model ini meningkatkan keterlibatan pasien dan keluarganya dalam diskusi klinis dan perencanaan perawatan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan IBR secara konsisten meningkatkan komunikasi antar tenaga kesehatan, menurunkan risiko kesalahan medis, serta memperkuat kepuasan pasien dan keluarga terhadap pelayanan kesehatan (Schwartz et al., 2021).

4. Model TeamSTEPPS (Team Strategies and Tools to Enhance Performance and Patient Safety)

Model TeamSTEPPS adalah pendekatan berbasis bukti yang dikembangkan oleh Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ), bertujuan meningkatkan kinerja tim kesehatan melalui pelatihan yang fokus pada komunikasi, kepemimpinan, dan situational awareness. Model ini menggunakan berbagai alat komunikasi standar seperti SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), briefing, dan debriefing untuk mendukung pengambilan keputusan bersama. Studi terbaru menegaskan bahwa implementasi TeamSTEPPS meningkatkan kolaborasi tim secara signifikan serta menurunkan risiko kejadian yang membahayakan pasien lansia (King & Salas, 2020).

5. Model Acute Care for Elders (ACE)

Model Acute Care for Elders (ACE) adalah pendekatan kolaboratif yang dirancang khusus untuk perawatan akut lansia di rumah sakit, dengan mengintegrasikan tim multidisiplin (perawat gerontik, dokter geriatri, farmasis klinis, dan ahli rehabilitasi). Tim ACE secara rutin mengevaluasi kebutuhan geriatri, merencanakan intervensi khusus, serta menyediakan edukasi bagi keluarga tentang transisi perawatan. Bukti terbaru menunjukkan bahwa model ACE berhasil menurunkan angka komplikasi klinis, mempercepat pemulangan pasien dari rumah sakit, dan meningkatkan kualitas hidup lansia secara keseluruhan (Heflin, 2021).

Kesimpulan

Model kolaborasi interprofesional berbasis bukti dalam keperawatan gerontik secara jelas memperlihatkan dampak positif dalam meningkatkan kualitas

perawatan lansia. Implementasi model-model seperti Guided Care, GITT, IBR, TeamSTEPPS, dan ACE terbukti memperbaiki komunikasi tim, memperkuat sinergi antarprofesi, serta meningkatkan hasil klinis yang penting seperti penurunan angka rawat inap, peningkatan kepuasan pasien dan keluarga, serta menurunkan risiko kesalahan medis.

Peran perawat gerontik sangat sentral dalam implementasi model-model ini, dengan tanggung jawab sebagai koordinator pelayanan, fasilitator komunikasi tim, dan advokat utama bagi kepentingan pasien lansia.

B. Strategi Meningkatkan Kualitas Perawatan Melalui Kolaborasi Antarprofesi

Kolaborasi antarprofesi (Interprofessional Collaboration/IPC) merupakan elemen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia. Melalui IPC, berbagai profesi kesehatan bekerja sama secara harmonis, saling melengkapi kompetensi masing-masing, dan bertujuan untuk memberikan perawatan yang holistik, terpadu, dan berfokus pada kebutuhan pasien lansia (Reeves et al., 2021). Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan berbagai strategi yang didasarkan pada bukti ilmiah.

Berikut beberapa strategi yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas perawatan melalui kolaborasi antarprofesi dalam praktik keperawatan gerontik:

1. Pendidikan dan Pelatihan Interprofesional

Pendidikan dan pelatihan interprofesional merupakan landasan penting untuk meningkatkan pemahaman, menghargai peran masing-masing profesi, dan memperkuat kerja sama tim. Pelatihan ini melibatkan berbagai profesi kesehatan seperti perawat, dokter, farmasis, fisioterapis, dan pekerja sosial. Metode pelatihan yang efektif meliputi simulasi klinik bersama, diskusi kasus nyata, pelatihan komunikasi efektif, serta pemecahan masalah secara kolaboratif (Fox et al., 2021). Studi terbaru menegaskan bahwa pelatihan interprofesional meningkatkan komunikasi tim, mengurangi konflik antarprofesi, serta memperbaiki hasil klinis pasien lansia secara signifikan (Ellis, Sevdalis, & McGregor, 2021).

2. Implementasi Rapat Tim Terstruktur (Structured Team Meetings)

Rapat tim yang terstruktur seperti Interdisciplinary Bedside Rounds (IBR) terbukti meningkatkan kualitas komunikasi dan kolaborasi tim kesehatan secara nyata. Dalam IBR, anggota tim yang terdiri dari perawat, dokter, apoteker, dan profesi lainnya secara rutin bertemu di samping tempat tidur pasien untuk membahas kondisi klinis pasien, menentukan tujuan perawatan bersama, serta

melibatkan pasien dan keluarga dalam pengambilan keputusan (Schwartz et al., 2021). Strategi ini meningkatkan kepuasan pasien, menurunkan risiko kesalahan medis, serta mempercepat keputusan klinis yang efektif.

3. Penggunaan Alat Komunikasi Standar dalam Tim

Penggunaan alat komunikasi standar, seperti metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), merupakan pendekatan penting dalam meningkatkan kolaborasi antarprofesi. Alat ini membantu tim untuk menyampaikan informasi klinis secara jelas, singkat, dan tepat sasaran sehingga meminimalisasi miskomunikasi dan mempercepat respon klinis. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode komunikasi standar ini mampu menurunkan angka kesalahan medis dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi lansia (King & Salas, 2020).

4. Integrasi Perawat sebagai Koordinator Pelayanan (Care Coordinator)

Integrasi perawat gerontik sebagai koordinator utama dalam tim multidisiplin merupakan strategi yang efektif. Dalam model seperti Guided Care, perawat bertugas melakukan asesmen menyeluruh, mengoordinasikan layanan antar berbagai profesi, serta memberikan edukasi dan dukungan kepada pasien dan keluarga. Peran sentral perawat ini terbukti mampu mengurangi kebutuhan rawat inap, meningkatkan manajemen penyakit kronis, dan memperkuat kepuasan pasien lansia terhadap layanan yang diterima (Boult & Wieland, 2022).

5. Manajemen Kasus Multidisiplin

Strategi manajemen kasus multidisiplin melibatkan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai profesi dalam mengelola kasus kompleks lansia. Strategi ini mencakup perencanaan perawatan terpadu, koordinasi antar layanan, pemantauan berkelanjutan, serta evaluasi outcome pasien secara rutin. Studi terbaru menunjukkan bahwa pendekatan ini mampu meningkatkan efektivitas perawatan, mempercepat pemulangan pasien, serta menurunkan angka rehospitalisasi pada pasien lansia dengan kondisi kronis kompleks (Heflin, 2021).

6. Evaluasi Rutin dan Umpan Balik Tim

Strategi terakhir yang penting dalam meningkatkan kualitas perawatan melalui kolaborasi antarprofesi adalah evaluasi rutin dan pemberian umpan balik yang konstruktif kepada seluruh anggota tim. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui audit klinis, pengukuran outcome pasien, serta survei kepuasan antarprofesi. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, memberikan umpan balik kepada tim, serta memperkuat komitmen

tim terhadap perbaikan kualitas perawatan lansia secara berkelanjutan (Fox et al., 2021).

Kesimpulan

Strategi kolaborasi antarprofesi yang berbasis bukti, seperti pelatihan interprofesional, rapat tim terstruktur, penggunaan alat komunikasi standar, integrasi perawat sebagai koordinator perawatan, manajemen kasus multidisiplin, serta evaluasi rutin tim, terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan gerontik. Melalui implementasi strategi tersebut, tim kesehatan mampu bekerja secara harmonis, saling melengkapi, dan memberikan perawatan yang optimal kepada pasien lansia.

C. Contoh Keberhasilan Kerja Sama Lintas Profesi dalam Pelayanan Kesehatan

Penerapan kolaborasi interprofesional dalam keperawatan gerontik secara nyata mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien lansia. Berikut ini disajikan beberapa studi kasus implementasi kolaborasi interprofesional yang efektif, berdasarkan penelitian terkini yang dapat dijadikan referensi untuk praktik pelayanan kesehatan gerontik.

1. Contoh 1: Implementasi Model Guided Care di Fasilitas Perawatan Primer

Sebuah klinik primer menerapkan model Guided Care dengan menempatkan perawat gerontik sebagai koordinator utama pelayanan lansia. Perawat bertugas melakukan asesmen geriatri menyeluruh, mengembangkan rencana perawatan terpadu bersama dokter dan tenaga kesehatan lainnya, serta melakukan edukasi keluarga secara rutin. Penelitian yang dilakukan oleh Boulton dan Wieland (2022) menunjukkan bahwa setelah satu tahun implementasi, pasien lansia mengalami penurunan frekuensi kunjungan ke Unit Gawat Darurat sebesar 30% serta penurunan angka rawat inap sebesar 24%. Selain itu, kepuasan pasien dan keluarganya terhadap layanan kesehatan meningkat secara signifikan karena perawatan yang lebih terkoordinasi dan responsif.

2. Contoh 2: Penggunaan Interdisciplinary Bedside Rounds (IBR) di Rumah Sakit

Di sebuah rumah sakit umum, model Interdisciplinary Bedside Rounds (IBR) diterapkan untuk pasien lansia yang dirawat inap. Tim kesehatan yang terdiri dari perawat, dokter, farmasis, dan terapis melakukan kunjungan bersama secara terjadwal langsung di tempat tidur pasien setiap pagi. Melalui IBR, tim secara aktif melibatkan pasien dan keluarga dalam diskusi klinis serta dalam pengambilan keputusan bersama mengenai rencana perawatan. Penelitian Schwartz et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan IBR berhasil

meningkatkan komunikasi antar tenaga kesehatan, mengurangi risiko kesalahan medis hingga 40%, serta mempercepat pemulangan pasien lansia dari rumah sakit rata-rata satu hingga dua hari lebih cepat dibandingkan metode tradisional.

3. Contoh 3: Program TeamSTEPPS untuk Pelayanan Pasien Geriatri Akut

Di sebuah unit Acute Care for Elders (ACE) di rumah sakit, tim multidisiplin yang terdiri dari perawat gerontik, dokter spesialis geriatri, apoteker klinis, fisioterapis, dan pekerja sosial menerapkan model TeamSTEPPS. Program ini menekankan pelatihan komunikasi yang terstandarisasi seperti metode SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation), briefing rutin, serta evaluasi situasi klinis yang sistematis. Penelitian King dan Salas (2020) menemukan bahwa implementasi TeamSTEPPS selama enam bulan mampu mengurangi insiden keselamatan pasien hingga 35%, serta meningkatkan efisiensi proses klinis seperti pengurangan waktu tunggu pasien untuk tindakan diagnostik dan intervensi.

4. Contoh 4: Pelatihan Interprofesional Geriatric Interdisciplinary Team Training (GITT)

Sebuah institusi pendidikan kesehatan mengadakan pelatihan interprofesional menggunakan metode Geriatric Interdisciplinary Team Training (GITT). Peserta dari berbagai profesi kesehatan, termasuk perawat, dokter, farmasis, pekerja sosial, dan fisioterapis, mengikuti pelatihan berbasis simulasi klinik dan diskusi kasus geriatri. Studi oleh Ellis, Sevdalis, dan McGregor (2021) melaporkan bahwa pelatihan ini berhasil meningkatkan pemahaman peran antarprofesi, memperkuat kolaborasi tim dalam praktik klinis, serta meningkatkan hasil klinis pasien lansia seperti percepatan rehabilitasi, pengurangan kesalahan pengobatan, dan peningkatan kepuasan pasien.

5. Contoh 5: Manajemen Kasus Terpadu untuk Pasien dengan Demensia

Sebuah pusat layanan kesehatan lansia menerapkan pendekatan manajemen kasus multidisiplin untuk pasien demensia. Tim kolaboratif terdiri dari perawat gerontik, dokter spesialis geriatri, psikolog klinis, pekerja sosial, dan terapis okupasi. Tim ini mengadakan rapat terstruktur mingguan untuk merancang dan mengevaluasi rencana perawatan individu berdasarkan kondisi pasien. Studi yang dilakukan oleh Heflin (2021) mengungkapkan bahwa pendekatan manajemen kasus terpadu ini mampu mengurangi tingkat agitasi pasien demensia hingga 25%, meningkatkan kualitas hidup pasien secara signifikan, serta mengurangi beban stres keluarga dan caregiver.

Kesimpulan

Studi kasus tersebut menunjukkan bukti kuat bahwa kolaborasi interprofesional yang efektif dalam pelayanan keperawatan gerontik mampu meningkatkan hasil klinis pasien, memperkuat koordinasi tim kesehatan, serta meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga. Strategi kolaboratif ini menjadi model penting untuk dikembangkan lebih lanjut di berbagai institusi pelayanan kesehatan guna mendukung peningkatan kualitas hidup pasien lansia.

BAB 12.

Pendidikan dan Pelatihan Keperawatan Gerontik

A. Model Pembelajaran Berbasis Kompetensi dalam Keperawatan Lansia

Model pembelajaran berbasis kompetensi (Competency-Based Education/CBE) merupakan pendekatan pendidikan yang berfokus pada pencapaian kompetensi spesifik yang diperlukan oleh perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada lansia secara efektif. Pendekatan ini berbeda dengan model pembelajaran tradisional yang berbasis waktu, di mana peserta didik dinilai berdasarkan pencapaian hasil pembelajaran yang jelas dan terukur (De Groot-Kleine, Van Achterberg, & Vermeulen, 2023).

Model pembelajaran berbasis kompetensi dalam keperawatan gerontik bertujuan memastikan bahwa perawat memiliki keterampilan klinis, pengetahuan mendalam, serta sikap positif yang sesuai dengan kebutuhan khusus lansia. Kompetensi-kompetensi tersebut mencakup asesmen geriatri komprehensif, manajemen penyakit kronis, keterampilan komunikasi efektif, advokasi pasien lansia, serta kolaborasi interprofesional (Dahlke, Hunter, Kalogirou, Negrin, & Fox, 2023).

Beberapa komponen utama dalam implementasi model pembelajaran berbasis kompetensi dalam keperawatan lansia meliputi:

1. Identifikasi Kompetensi Inti Keperawatan Gerontik

Langkah awal penerapan model ini adalah mengidentifikasi dan menetapkan kompetensi inti yang dibutuhkan dalam praktik keperawatan gerontik. Kompetensi inti ini mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional yang esensial dalam merawat pasien lansia. Studi oleh Ferreira-Oliveira et al. (2023) menunjukkan bahwa validasi kompetensi inti yang jelas membantu meningkatkan kualitas pendidikan keperawatan gerontik serta menjamin kesiapan perawat dalam praktik nyata di lapangan.

2. Kurikulum Berbasis Kompetensi

Kurikulum dalam model CBE dirancang secara modular dan terstruktur berdasarkan kompetensi yang telah diidentifikasi. Kurikulum ini mencakup metode pembelajaran yang beragam, seperti simulasi klinik, pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning), praktik langsung di klinik, serta integrasi teori dan praktik secara berkesinambungan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kurikulum berbasis kompetensi secara signifikan meningkatkan keterampilan klinis mahasiswa keperawatan dalam merawat pasien lansia (De Groot-Kleine et al., 2023).

3. Metode Pembelajaran Aktif

Model pembelajaran berbasis kompetensi menggunakan metode pembelajaran aktif yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran. Mahasiswa secara aktif terlibat dalam diskusi kasus, simulasi klinik, serta kegiatan reflektif yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemahaman mendalam dan keterampilan klinis yang diperlukan dalam praktik keperawatan gerontik. Kajian oleh Dahlke et al. (2023) menemukan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan pemikiran kritis, pengambilan keputusan klinis, serta kompetensi praktis mahasiswa dalam memberikan pelayanan kepada lansia.

4. Evaluasi Kompetensi secara Autentik

Dalam model ini, evaluasi kompetensi mahasiswa dilakukan secara autentik melalui berbagai metode seperti Objective Structured Clinical Examination (OSCE), penilaian portofolio, refleksi diri, serta umpan balik langsung dari instruktur klinik dan pasien lansia. Studi terbaru menunjukkan bahwa evaluasi autentik ini mampu memberikan gambaran nyata tentang kemampuan mahasiswa dalam praktik keperawatan lansia serta memastikan kesiapan mereka untuk bekerja secara profesional setelah lulus (Ferreira-Oliveira et al., 2023).

5. Pembelajaran Adaptif dan Berkelanjutan

Pembelajaran berbasis kompetensi menekankan pentingnya adaptasi terus-menerus terhadap kebutuhan pendidikan mahasiswa. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar secara bertahap sesuai dengan kecepatan dan kemampuan mereka masing-masing hingga mencapai penguasaan kompetensi yang ditentukan. Konsep Master Adaptive Learner diterapkan untuk

mendorong mahasiswa melakukan refleksi kritis secara kontinu, menerima umpan balik, serta melakukan penyesuaian dalam proses pembelajaran mereka sepanjang karir profesional (Cutrer et al., 2021).

Kesimpulan

Model pembelajaran berbasis kompetensi dalam keperawatan gerontik merupakan pendekatan pendidikan yang efektif dalam mempersiapkan perawat dengan kompetensi khusus yang relevan untuk merawat lansia. Model ini terbukti meningkatkan keterampilan klinis, pemikiran kritis, komunikasi interpersonal, serta kolaborasi interprofesional. Melalui penerapan kurikulum berbasis kompetensi, metode pembelajaran aktif, evaluasi autentik, dan pembelajaran adaptif, perawat gerontik yang dihasilkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan berkualitas tinggi kepada populasi lansia.

B. Strategi Edukasi dalam Pelatihan Keperawatan Gerontik

Strategi edukasi berbasis evidensi merupakan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan hasil penelitian ilmiah terkini ke dalam proses pembelajaran keperawatan gerontik. Tujuan pendekatan ini adalah memastikan bahwa pelatihan yang diberikan kepada perawat memiliki dasar ilmiah yang kuat sehingga mampu meningkatkan kompetensi, efektivitas klinis, serta kualitas pelayanan terhadap pasien lansia (Abu-Baker, AbuAlrub, Obeidat, & Assmairan, 2021).

Berikut beberapa strategi edukasi berbasis evidensi yang efektif diterapkan dalam pelatihan keperawatan gerontik:

1. Integrasi Evidensi dalam Kurikulum Pendidikan

Strategi pertama dalam penerapan edukasi berbasis evidensi adalah mengintegrasikan hasil penelitian terbaru dalam kurikulum keperawatan gerontik. Pendekatan ini mencakup penggunaan kasus klinis nyata berbasis bukti ilmiah, praktik simulasi yang relevan dengan kondisi kesehatan lansia, serta diskusi kelompok yang berfokus pada penerapan praktik berbasis bukti dalam perawatan lansia. Studi terbaru menunjukkan bahwa kurikulum berbasis bukti ini secara signifikan meningkatkan pemahaman konsep serta kompetensi klinis mahasiswa keperawatan dalam menangani pasien geriatri (Laokosin, Ponathong, & Yongsorn, 2024).

2. Pelatihan Keterampilan Literasi Ilmiah dan Penilaian Evidensi

Pelatihan literasi ilmiah, yaitu kemampuan mencari, menilai, dan menerapkan hasil penelitian dalam praktik klinis, merupakan komponen penting dalam edukasi berbasis evidensi. Mahasiswa keperawatan dilatih menggunakan basis

data ilmiah, mengevaluasi kualitas metodologi penelitian, serta menerapkan hasil penelitian yang relevan dalam situasi klinis spesifik yang dihadapi. Menurut penelitian Abu-Baker et al. (2021), pelatihan literasi ilmiah terbukti efektif meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pentingnya praktik berbasis bukti, sekaligus meningkatkan keterampilan mereka dalam mengaplikasikan bukti ilmiah dalam praktik klinis.

3. Penggunaan Simulasi Klinis Berbasis Evidensi

Penggunaan simulasi klinis dalam pelatihan keperawatan gerontik memungkinkan mahasiswa untuk secara langsung menerapkan keterampilan berbasis bukti dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Simulasi ini mencakup penggunaan kasus klinis yang didasarkan pada kondisi umum yang dialami lansia seperti demensia, frailty, gangguan mobilitas, serta berbagai kondisi kronis lainnya. Studi terkini menunjukkan bahwa pendekatan simulasi berbasis evidensi ini mampu meningkatkan keterampilan klinis, kepercayaan diri mahasiswa, serta memperbaiki pengambilan keputusan dalam praktik klinis (Dahlke, Hunter, Kalogirou, Negrin, & Fox, 2023).

4. Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning/PBL)

Pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan edukasi yang efektif dalam mengembangkan pemikiran kritis, keterampilan pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan klinis berbasis bukti. Dalam metode ini, mahasiswa dihadapkan pada skenario nyata yang relevan dengan kondisi pasien lansia, kemudian diminta secara aktif mencari dan menerapkan bukti ilmiah terbaru untuk mengatasi masalah tersebut. Menurut De Groot-Kleine, Van Achterberg, dan Vermeulen (2023), pendekatan PBL terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan praktik berbasis bukti secara nyata dalam perawatan lansia.

5. Evaluasi Berbasis Kompetensi dengan Menggunakan Alat Penilaian yang Valid

Evaluasi pembelajaran dalam pendekatan berbasis evidensi dilakukan melalui asesmen berbasis kompetensi yang autentik dan valid. Alat evaluasi seperti Objective Structured Clinical Examination (OSCE), penilaian portofolio, serta asesmen keterampilan klinis dengan alat ukur seperti European Gerontogeriatric Nursing Core Competencies Scale telah divalidasi secara ilmiah dan terbukti efektif mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa keperawatan dalam konteks praktik berbasis evidensi (Ferreira-Oliveira et al., 2023).

6. Pengembangan Pembelajaran Adaptif dan Berkelanjutan (Master Adaptive Learning)

Pendekatan edukasi berbasis evidensi juga menekankan pembelajaran adaptif dan berkelanjutan yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan kemampuan untuk terus belajar dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam perawatan gerontik. Mahasiswa didorong untuk secara aktif melakukan refleksi diri, menerima umpan balik konstruktif, serta terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka secara berkelanjutan dalam praktik profesional (Cutrer et al., 2021).

Kesimpulan

Strategi edukasi berbasis evidensi dalam pelatihan keperawatan gerontik terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi klinis, pemikiran kritis, keterampilan komunikasi, dan kemampuan pengambilan keputusan klinis mahasiswa keperawatan. Dengan menerapkan integrasi evidensi dalam kurikulum, pelatihan literasi ilmiah, simulasi klinis, pembelajaran berbasis masalah, evaluasi autentik, serta pendekatan pembelajaran adaptif, perawat gerontik dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, aman, dan efektif kepada pasien lansia.

C. Evaluasi Efektivitas Program Pelatihan Keperawatan Gerontik

Evaluasi efektivitas program pelatihan keperawatan gerontik merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa pelatihan yang diberikan telah berhasil mencapai tujuan dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perawat yang merawat pasien lansia. Evaluasi yang efektif harus didasarkan pada bukti ilmiah, menggunakan desain evaluasi yang jelas, indikator terukur, dan metode yang valid serta reliabel (Ferreira-Oliveira et al., 2023).

Beberapa pendekatan utama dalam evaluasi efektivitas program pelatihan keperawatan gerontik meliputi:

1. Desain Evaluasi Berbasis Pra-Pasca (Pre-Post Test)

Desain evaluasi pra-pasca sering digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta sebelum dan sesudah pelatihan. Dengan metode ini, efektivitas pelatihan dapat dinilai secara objektif melalui peningkatan skor tes pengetahuan atau perubahan keterampilan klinis. Studi terbaru menunjukkan bahwa desain evaluasi pra-pasca efektif untuk mendokumentasikan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan klinis perawat setelah pelatihan keperawatan gerontik (Nayak & Pai, 2023).

2. Evaluasi dengan Metode Simulasi Klinis

Metode simulasi klinis merupakan salah satu alat evaluasi penting dalam menilai efektivitas pelatihan keperawatan gerontik. Dalam simulasi klinis, peserta pelatihan menunjukkan keterampilan klinis mereka dalam lingkungan yang terkendali yang meniru situasi nyata. Penelitian terbaru oleh Dahlke et al. (2023) menunjukkan bahwa simulasi klinis terbukti efektif dalam mengevaluasi peningkatan kompetensi klinis serta pengambilan keputusan yang akurat dalam perawatan lansia.

3. Penilaian Berbasis Kompetensi Melalui Objective Structured Clinical Examination (OSCE)

OSCE adalah metode evaluasi kompetensi klinis yang terstruktur, objektif, dan terstandarisasi. OSCE digunakan secara luas dalam pelatihan keperawatan gerontik untuk mengukur keterampilan praktis peserta secara nyata dan autentik. Studi terbaru menemukan bahwa OSCE memberikan hasil evaluasi yang valid dan reliabel dalam menilai kemampuan perawat dalam melakukan asesmen geriatri, manajemen pengobatan, serta komunikasi efektif dengan lansia dan keluarga (Ferreira-Oliveira et al., 2023).

4. Survei Kepuasan Peserta Pelatihan

Survei kepuasan peserta merupakan metode evaluasi subjektif yang berguna untuk mendapatkan umpan balik tentang pengalaman peserta selama pelatihan. Survei ini mencakup aspek seperti relevansi materi, kualitas instruktur, efektivitas metode pengajaran, serta manfaat pelatihan terhadap peningkatan kompetensi peserta. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abu-Baker et al. (2021), survei kepuasan peserta merupakan komponen penting dalam mengevaluasi kualitas dan efektivitas program pelatihan keperawatan.

5. Evaluasi Dampak terhadap Praktik Klinis dan Outcome Pasien

Evaluasi efektivitas pelatihan tidak hanya terbatas pada perubahan pengetahuan dan keterampilan peserta, tetapi juga meliputi dampak terhadap praktik klinis di lapangan serta hasil klinis pasien lansia. Studi terbaru oleh De Groot-Kleine, Van Achterberg, dan Vermeulen (2023) menemukan bahwa pelatihan yang efektif menghasilkan peningkatan signifikan dalam kualitas dokumentasi klinis, penurunan angka kesalahan pengobatan, serta peningkatan kepuasan pasien dan keluarga.

6. Evaluasi Berkelanjutan dan Umpan Balik Rutin

Evaluasi berkelanjutan dan pemberian umpan balik rutin kepada peserta pelatihan adalah metode penting untuk memastikan pembelajaran yang berkelanjutan. Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk merefleksikan pencapaian mereka, menerima umpan balik dari instruktur dan kolega, serta

melakukan perbaikan dalam praktik klinis mereka. Penelitian menunjukkan bahwa evaluasi dan umpan balik yang berkelanjutan ini mampu memperkuat retensi pengetahuan, memperbaiki keterampilan klinis, serta meningkatkan motivasi perawat untuk terus mengembangkan diri (Cutrer et al., 2021).

Kesimpulan

Evaluasi efektivitas program pelatihan keperawatan gerontik merupakan aspek kunci dalam memastikan keberhasilan program pelatihan. Metode evaluasi seperti desain pra-pasca, simulasi klinis, OSCE, survei kepuasan peserta, evaluasi praktik klinis, serta evaluasi berkelanjutan dan umpan balik rutin terbukti efektif dalam mengukur dampak pelatihan. Pendekatan ini memungkinkan institusi pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan, sehingga menghasilkan perawat gerontik yang kompeten dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi pasien lansia.

BAB 13.

Etika dan Isu Hukum dalam Pelayanan Keperawatan Lansia

A. Isu Etika dalam Pelayanan Keperawatan Gerontik

Pelayanan keperawatan gerontik merupakan bidang pelayanan yang sangat kompleks, tidak hanya dalam aspek klinis namun juga terkait dengan isu-isu etika yang kerap muncul dalam perawatan lansia. Isu etika ini meliputi berbagai aspek seperti penghormatan terhadap otonomi, menjaga privasi dan kerahasiaan pasien, isu keadilan serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi usia, hingga etika dalam penggunaan teknologi terkini.

1. Penghormatan terhadap Otonomi Lansia

Otonomi pasien merupakan prinsip etika fundamental dalam keperawatan gerontik. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati hak lansia dalam pengambilan keputusan mengenai perawatan kesehatan mereka. Akan tetapi, tantangan muncul ketika pasien mengalami gangguan kognitif, seperti demensia, yang berpotensi menghambat pengambilan keputusan secara mandiri. Studi terkini menunjukkan pentingnya peran perawat dalam memfasilitasi diskusi mengenai preferensi perawatan, termasuk penggunaan dokumen seperti advance directives atau surat wasiat medis (Smebye, Kirkevold, & Engedal, 2022).

2. Privasi dan Kerahasiaan

Menjaga privasi dan kerahasiaan pasien lansia adalah kewajiban etis yang harus dipatuhi dalam praktik keperawatan gerontik. Dengan berkembangnya teknologi digital seperti telehealth dan sistem rekam medis elektronik, tantangan dalam menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien menjadi semakin kompleks. Penelitian terbaru mengungkapkan pentingnya implementasi prosedur keamanan data yang ketat serta perlunya edukasi berkelanjutan bagi tenaga kesehatan terkait pentingnya perlindungan privasi pasien lansia (Schick Tanz, Welsch, & Schweda, 2023).

3. Keadilan dan Diskriminasi Usia (Ageism)

Diskriminasi usia atau ageism merupakan salah satu isu etika utama dalam perawatan lansia. Fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari

perlakuan negatif terhadap pasien lansia, pembatasan akses terhadap layanan tertentu, hingga sikap negatif dari tenaga kesehatan. Ageism berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima lansia. Kajian ilmiah terbaru menunjukkan bahwa pelatihan etika dan peningkatan kesadaran tentang dampak ageism secara signifikan dapat mengurangi perlakuan diskriminatif terhadap lansia dalam pelayanan kesehatan (Chang, Kanno, Levy, Wang, & Lee, 2020).

4. Konflik Moral dan Distres Moral

Dalam pelayanan gerontik, perawat sering kali menghadapi konflik moral ketika nilai pribadi atau profesional bertentangan dengan kebijakan institusi atau keluarga pasien. Kondisi ini dapat memicu distress moral yang berdampak pada kesehatan mental perawat. Penelitian terbaru mengidentifikasi bahwa distress moral sering terjadi dalam konteks pengambilan keputusan terkait akhir hidup atau dalam situasi yang membatasi hak-hak pasien lansia, misalnya selama pandemi COVID-19. Penting bagi institusi untuk menyediakan dukungan psikososial bagi perawat dalam menghadapi konflik moral ini (Kim, Oh, & Kong, 2020).

5. Etika dalam Perawatan Akhir Hidup

Isu etika dalam perawatan akhir hidup sangat penting dalam pelayanan keperawatan gerontik. Keputusan seperti penghentian atau tidak melanjutkan terapi tertentu menuntut perawat untuk mempertimbangkan prinsip non-maleficence atau prinsip tidak menyakiti pasien. Dalam kondisi ini, perawat dituntut memiliki keterampilan komunikasi yang baik serta mampu memberikan dukungan psikososial kepada pasien dan keluarga. Penelitian terbaru menekankan pentingnya peran perawat dalam memastikan pasien lansia menerima perawatan yang sesuai dengan keinginan dan martabat mereka (Miller & English, 2021).

6. Tantangan Etika dalam Pemanfaatan Teknologi dan AI

Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), sensor pemantau kesehatan, dan robot asisten dalam perawatan lansia memunculkan tantangan etika baru. Meski teknologi ini menjanjikan peningkatan kualitas perawatan, terdapat risiko seperti pelanggaran privasi, bias algoritma, serta ketidaksetaraan akses teknologi. Kajian terbaru merekomendasikan perlunya kerangka etika khusus dalam penggunaan teknologi, dengan memastikan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan privasi pasien lansia (Weiner, Dankwa-Mullan, Nelson, & Hassanpour, 2024).

7. Hubungan Terapeutik dan Integritas Profesional

Hubungan terapeutik antara perawat dengan pasien lansia memiliki peran sentral dalam praktik keperawatan gerontik. Hubungan ini membutuhkan komunikasi yang empatik, penghormatan terhadap martabat lansia, serta sikap profesional yang menjaga integritas dan kepercayaan pasien. Studi terbaru mengungkapkan bahwa hubungan terapeutik yang kuat tidak hanya meningkatkan kepuasan pasien tetapi juga mendukung kesehatan emosional dan psikologis lansia secara signifikan (Zendehtalab, Eskandari, Abbaszadeh, & Nasrabadi, 2023).

Kesimpulan

Isu etika dalam pelayanan keperawatan gerontik mencakup aspek penghormatan terhadap otonomi pasien, menjaga privasi, menegakkan keadilan, mengatasi konflik moral, serta menghadapi tantangan penggunaan teknologi terbaru dalam perawatan. Perawat gerontik perlu dibekali dengan keterampilan etika yang memadai serta mendapatkan dukungan institusional dalam menghadapi dilema etika tersebut agar dapat memberikan pelayanan yang optimal, manusiawi, dan bermartabat kepada lansia.

B. Hak Lansia dalam Perawatan dan Perlindungan Hukum

Lansia sebagai individu yang rentan memerlukan jaminan hak dalam menerima perawatan yang bermartabat dan terlindungi hukum. Hak-hak ini diakui secara internasional maupun nasional, serta diwujudkan dalam berbagai undang-undang dan kebijakan.

1. Hak atas Perawatan Kesehatan yang Layak

Setiap lansia berhak memperoleh akses perawatan kesehatan berkualitas tanpa diskriminasi usia, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Pasal 42 UU No. 39/1999 tentang HAM (Komnas HAM & Geriatri.id, 2024)

repository.uinsuska.ac.id/1jmiki.aptirmik.or.id/1geriatri.id/2puskesmasjakem-dikes.lombokbaratkab.go.id/2jmiki.aptirmik.or.id/2.

Ini mencakup akses promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai kebutuhan lansia.

2. Hak untuk Menentukan Perawatan (Informed Consent dan Advance Directive)

Lansia berhak memperoleh informasi lengkap mengenai kondisi dan opsi perawatan, serta memiliki kebebasan memilih atau menolak tindakan medis melalui informed consent atau advance directives. Di beberapa negara seperti

AS, hal ini didukung oleh Patient Self-Determination Act (1990) dan Nursing Home Reform Act (1987)

jmiki.apfirmik.or.id/en.wikipedia.org+2en.wikipedia.org+2investopedia.com+2.

3. Hak atas Privasi, Kerahasiaan, dan Martabat

Lansia memiliki hak atas privasi data medis dan integritas pribadi. Sistem perawatan, termasuk penggunaan teknologi digital, wajib menjamin kerahasiaan informasi kesehatan dan perlakuan yang menghormati martabat pasien (FindLaw, 2022; CMS, USA)

repository.theprakarsa.org+9geriatri.id+9repository.uin-suska.ac.id+9.

4. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi

Undang-undang di Indonesia (UU No. 13/1998 tentang Kesetaraan dan Perlindungan Lansia) serta peraturan internasional melindungi lansia dari segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, dan eksploitasi (Ombudsman RI; Justice.gov) ombudsman.go.id.

5. Hak atas Informasi Transparan dan Pilihan Layanan

Penyedia layanan wajib memberikan informasi jelas mengenai prosedur, biaya, serta pilihan fasilitas perawatan. Lansia berhak memilih dokter, mengakses catatan medis, dan mengajukan keluhan tanpa takut direpresi (CMS USA; FindLaw) .

6. Hak atas Keamanan dan Lingkungan Perawatan yang Layak

Lansia berhak mendapatkan lingkungan perawatan yang aman, bebas dari penyalahgunaan atau penelantaran, dan mendapatkan penanganan cepat terhadap masalah yang muncul. Di AS, ini dijamin melalui Nursing Home Reform Act dan Elder Justice Act en.wikipedia.org+1investopedia.com+1.

7. Hak atas Bantuan Hukum dan Memenuhi Peran Sosial

Di Indonesia, Komnas HAM menggarisbawahi hak lansia untuk mendapatkan bantuan hukum, akses layanan sosial, dan peran dalam masyarakat (UU 39/1999; Ombudsman RI)

ombudsman.go.id+2komnasham.go.id+2geriatri.id+2.

Hak Lansia	Dasar Hukum
Perawatan tanpa diskriminasi usia	UU 36/2009; UU 39/1999
Informed consent & advance directive	PSDA (AS); UU Kesehatan RI
Privasi dan kerahasiaan	HIPAA (AS); UU 36/2009
Bebas dari kekerasan & eksploitasi	UU 13/1998 RI; Elder Justice Act (AS)
Informasi & pilihan layanan	CMS (AS); Permenkes RI
Lingkungan aman	Nursing Home Reform Act; Elder Justice

Peran Perawat Gerontik

- Menjamin informed consent, menjelaskan rencana perawatan dan advance directives.
- Menjaga privasi data lansia, terutama saat menggunakan teknologi.
- Melaporkan dan mencegah segala bentuk kekerasan atau eksploitasi.
- Memberi akses informasi lengkap terkait pilihan layanan dan biaya.
- Memastikan lingkungan perawatan aman dan bermartabat.
- Membantu lansia dan keluarga dalam memperoleh bantuan hukum dan advokasi sosial.

Kesimpulan

Hak lansia dalam perawatan mencakup hak atas kesehatan berkualitas, pilihan mandiri, privasi, perlindungan, informasi, lingkungan yang layak, dan bantuan hukum. Landasan hukum yang kuat di tingkat nasional dan internasional mendorong penyedia layanan—khususnya perawat gerontik—untuk menjalankan peran secara etis, profesional, dan empatik demi penghormatan martabat lansia.

C. Penyelesaian Dilema Etik Berbasis Kasus

Pendekatan berbasis kasus membantu perawat memahami dan menyelesaikan dilema etik nyata dalam praktik keperawatan lansia. Metode ini mengajarkan kerangka kerja sistematis dan refleksi kritis, yang efektif meningkatkan pengambilan keputusan etis (Corey et al., 2020).

1. Kasus: Fisik Restraint pada Pasien Demensia

Situasi: Seorang lansia dengan demensia menarik infusnya terus-menerus, berisiko membahayakan diri. Tim mempertimbangkan penggunaan fisik restraint atau alternatif non-fisik.

Isu etik: Konflik antara keselamatan (non-maleficence) dan otonomi serta martabat pasien.

Pendekatan penyelesaian:

- Kaji kapasitas pengambilan keputusan pasien
- Libatkan keluarga dan tim interprofesional
- Pertimbangkan alternatif seperti pengawasan intensif atau sensor deteksi jatuh

- Dokumentasikan diskusi, rencana, dan evaluasi
Outcome: Restriksi fisik dihindari; sensor dan supervisi lanjutan diterapkan, meningkatkan keamanan tanpa merusak hak pasien.

2. Kasus: Withdraw Perawatan Akhir Hidup

Situasi: Lansia terminal menolak intervensi lanjutan melalui advance directive. Keluarga meminta dilanjutkan.

Isu etik: Tension antara menghormati otonomi pasien vs beneficence dan nilai budaya keluarga.

Pendekatan penyelesaian:

- Klarifikasi isi advance directive
- Diskusi jujur fasilitasi peran advoka pasien oleh perawat
- Mediasi kolaboratif antara keluarga, pasien, dokter
- Konsultasi etika rumah sakit bila diperlukan

Outcome: Perawatan paliatif dijalankan sesuai kehendak pasien, keluarga memahami pilihan tersebut dan memberikan persetujuan

en.wikipedia.org+2en.wikipedia.org+2en.wikipedia.org+2.

3. Kasus: Alokasi Sumber Daya Selama Pandemi

Situasi: Pasien lansia perlu ventilator, tetapi unit ICU penuh.

Isu etik: Keadilan dalam distribusi sumber daya (justice), dan konflik antara beneficence individu vs populasi.

Pendekatan penyelesaian:

- Gunakan protokol triase yang transparan dan adil
- Libatkan komite etika untuk menetapkan prioritas
- Komunikasi terbuka dengan pasien dan keluarga mengenai proses keputusan

Outcome: Keputusan alokasi ventilator berdasar prioritas medis dan bukan usia, serta komunikasi yang jujur meningkatkan kepercayaan pasien

arxiv.org+15pmc.ncbi.nlm.nih.gov+15bmcnurs.biomedcentral.com+15.

4. Kerangka Penyelesaian Dilema Etik (Corey et al., 2020)

Langkah	Deskripsi
Identifikasi dilema	Kenali konflik nilai atau prinsip yang berpotensi merusak pasien
Kumpulkan informasi	Termasuk kondisi medis, preferensi pasien, hukum, dan kebijakan
Klarifikasi prinsip etika	Autonomy, beneficence, non-maleficence, justice
Identifikasi opsi	Pilih alternatif yang menghormati nilai pasien dan prinsip etik
Evaluasi dan pilih	Telaah konsekuensi dari tiap opsi
Implementasi	Laksanakan rencana kolaboratif
Evaluasi	Pantau hasil klinis dan psikososial; refleksi untuk pembelajaran

5. Peran Perawat dalam Penyelesaian Dilema Etik

- Sebagai advokat pasien dalam menghormati otonomi dan preference
- Fasilitator diskusi antar-profesional dan dengan keluarga
- Dokumenter keputusan dan proses etika
- Reflektor kritis untuk memperbaiki praktik dan pembelajaran etis kolektif

BAB 14.

Tantangan dan Prospek Masa Depan Keperawatan Gerontik

A. Tantangan dalam Implementasi

Implementasi praktik berbasis bukti (EBP) dalam keperawatan gerontik sangat berpotensi meningkatkan kualitas layanan lansia, namun menghadapi berbagai tantangan nyata dalam praktik klinik maupun institusional.

1. Keterbatasan Sumber Daya dan Waktu

Perawat sering kali memiliki beban kerja tinggi, sehingga kesulitan mengalokasikan waktu untuk mencari, membaca, dan menerapkan bukti ilmiah. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa kekurangan staf dan keterbatasan dana menjadi hambatan terbesar untuk EBP, terutama di lingkungan perawatan lansia dan jangka panjang .

2. Kurangnya Keterampilan Literasi Riset dan Kritis

Banyak perawat belum dilengkapi dengan keterampilan untuk menilai validitas dan kualitas penelitian. Pendidikan formal sering kali belum memadai dalam mengajarkan metode evaluasi bukti .

3. Hambatan Organisasi dan Budaya Klinik

Budaya institusi yang konservatif atau birokratis, kurangnya dukungan manajemen, serta kurangnya kolaborasi antarprofesi dapat menghambat adopsi EBP. Tim yang tidak memiliki 'champion' EBP juga sulit bertahan dalam jangka Panjang

[journals.sagepub.com+4pmc.ncbi.nlm.nih.gov+4bmchealthservres.biomedcentral.com+4](https://journals.sagepub.com/4pmc.ncbi.nlm.nih.gov/4bmchealthservres.biomedcentral.com/4).

4. Kualitas dan Relevansi Bukti untuk Lansia

Beberapa penelitian tidak cukup spesifik untuk populasi lansia atau kondisi kronis yang kompleks. Hal ini menyebabkan perawat mengalami kesulitan menerjemahkan rekomendasi ke praktik gerontik yang spesifik .

5. Kurangnya Teknologi dan Infrastruktur Digital

Akses ke jurnal dan sistem pendukung keputusan klinis terkadang terbatas, terutama di daerah kurang berkembang. Belum seluruh institusi menggunakan platform digital yang membantu integrasi EBP .

6. Resistensi terhadap Perubahan dan Sikap Tradisional

Beberapa tenaga kesehatan masih cenderung lebih percaya pada praktek lama ketimbang bukti baru, terutama jika belum ada pengaruh peer atau hasil nyata yang terasa .

Tantangan	Strategi Mengatasi
Beban kerja & keterbatasan waktu	Penjadwalan waktu EBP, audit klinis terjadwal, tim EBP dedicated
Literasi riset rendah	Pelatihan literasi ilmiah, mentor EBP, unit akademik di lokasi pelayanan
Budaya organisasi kaku	Kepemimpinan yang mendukung EBP, peran champion, integrasi dalam kebijakan klinik
Bukti tidak relevan untuk lansia	Adaptasi panduan klinis, kolaborasi riset institusi, dokumentasi kasus geriatri
Teknologi dan akses terbatas	Investasi infrastruktur digital, database internasional, kolaborasi dengan kampus
Resistensi terhadap perubahan	Komunikasi manfaat nyata EBP, pendekatan interprofesional, evaluasi hasil nyata

B. Prospek dan Arah Pengembangan Pelayanan Keperawatan Gerontik

Perkembangan demografi global menuntut transformasi mendalam dalam pelayanan keperawatan geriatrik. Beberapa arah utama pengembangan masa depan mencakup:

1. Penguatan Home Care dan Layanan Komunitas

Perluasan model perawatan lansia di rumah dan komunitas berbasis teknologi (telehealth, sensor) akan mendukung kemandirian lansia dan menurunkan beban fasilitas sakit. Implementasi care plan digital telah terbukti meningkatkan kualitas dokumentasi dan asuhan geriatric

repository.umj.ac.id/7ejournal.stikesmajapahit.ac.id/7azramedia-indonesia.azramediaindonesia.com/7.

2. Integrasi Teknologi Pintar dan AI

Kecerdasan buatan dan robotika diharapkan memainkan peran besar dalam perawatan lansia, terutama pada pemantauan kesehatan, pengambilan keputusan, dan interaksi sosial. Penting untuk menggabungkan efisiensi

teknologi dengan pertimbangan etika dan pendekatan berpusat-pada-manusia

3. Pendidikan dan Pembinaan Perawat Gerontik

Pengembangan program pendidikan kompetensi, sertifikasi, serta kapabilitas pengajar geriatri sangat krusial untuk menjawab kekurangan tenaga ahli geriatri. Arah ini sejalan dengan rekomendasi untuk memperluas pelatihan dan pengembangan akademik arxiv.org.

4. Penelitian Terapan dan Evaluative

Diperlukan penelitian yang menilai efektivitas intervensi inovatif, seperti teknologi pendukung, model manajemen kasus, dan program komprehensif berbasis komunitas, untuk mencerminkan keunikan kondisi lansia saat ini .

5. Kebijakan, Standarisasi, dan Kolaborasi Multi-sektor

Penataan kebijakan dan standar pelayanan nasional berbasis bukti serta kolaborasi dengan sektor publik, universitas, dan industri teknologi diperlukan untuk mewujudkan pelayanan geriatri yang responsif dan berkelanjutan .

Arah Utama	Fokus Utama
Home & Community Care	Layanan berbasis komunitas dan teknologi; telhealth, sensor
Teknologi Cerdas & AI	Integrasi AI di keputusan klinis, monitoring tanpa mengorbankan etika
Pendidikan & Pengembangan SDM	Sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, pengembangan fakultas geriatri
Penelitian Terapan & Evaluasi	Kajian efektivitas model inovatif dalam praktik geriatri
Kebijakan & Standarisasi Pelayanan	Model pelayanan nasional, kolaborasi antar sektor

C. Hal-Hal yang Perlu Dilakukan ke Depan agar Perawatan Lansia Lebih Baik

Penelitian masa depan dalam keperawatan gerontik perlu menjawab kompleksitas lansia yang meningkat serta tantangan sistem kesehatan. Berikut beberapa area prioritas:

1. Optimalisasi Perawatan Mandiri dan Pencegahan Hilangnya Kemandirian

Penelitian harus fokus pada intervensi yang mempertahankan atau memperpanjang kemandirian lansia di rumah dan komunitas serta mitigasi risiko jatuh dan kekurangan fungsi penting .

2. Pengembangan Model Pelayanan Inklusif dan Holistik

Diperlukan evaluasi intervensi yang mengintegrasikan pendekatan medis, sosial, dan teknologi dalam satu model pelayanan geriatri, sesuai rekomendasi Booker et al. (2024) untuk mendukung penuaan optimal .

3. Studi Efektivitas Teknologi Terapan (AI, Robot, Sensor)

Pengembangan dan evaluasi teknologi seperti AI, robot bantuan, dan sensor pemantau harus disertai kajian etis dan efektivitas klinis nyata dalam meningkatkan kualitas hidup lansia arxiv.org.

4. Biostatistika Geriatrik & Penyusunan Panduan Praktik Berbasis Data

Kemajuan metode analisis biostatistik, seperti GBS 2.0, penting untuk menganalisis data kompleks populasi lansia dan mendukung guideline berbasis populasi nyata arxiv.org.

5. Pengembangan Kompetensi Pendidikan dan Pelatihan Perawat

Perlu penelitian untuk mengembangkan dan mengevaluasi model Intervensi Mapping seperti IGNITE, guna meningkatkan kompetensi geriatri dalam pendidikan profesi keperawatan bmcmmededuc.biomedcentral.com.

6. Penguatan Peran Fakultas dan Kepemimpinan Akademik

Studi diperlukan untuk mengatasi kekurangan pengajar geriatri dan mengembangkan strategi pembinaan fakultas agar bisa mendukung pelatihan generasi baru perawat gerontik johnhartford.org.

7. Keadilan Sosial dan Determinan Sosial Kesehatan Lansia

Penelitian lintas budaya tentang faktor sosial dan determinan seperti isolasi, akses layanan, dan kesenjangan digital perlu diperkuat—seperti yang diangkat oleh Neves (2024) terkait "sociotechnical ageism" en.wikipedia.org.

BAB 15.

Penutup

Pelayanan keperawatan gerontik merupakan bidang keperawatan yang sangat penting dan akan semakin relevan seiring meningkatnya jumlah populasi lansia secara global, termasuk di Indonesia. Buku referensi ini telah membahas secara komprehensif tentang konsep dasar, perkembangan terkini, tantangan, serta prospek masa depan dalam keperawatan gerontik berbasis bukti.

Berbagai pembahasan dalam buku ini menyoroti pentingnya memahami proses penuaan secara holistik, tidak hanya dari aspek biologis, tetapi juga aspek psikososial dan spiritual lansia. Pemahaman mendalam mengenai perubahan fisik, psikososial, serta kebutuhan kesehatan lansia menjadi dasar bagi praktik keperawatan yang efektif, aman, dan berpusat pada lansia (Dahlke, Hunter, Kalogirou, Negrin, & Fox, 2023).

Selain itu, buku ini menegaskan pentingnya implementasi praktik berbasis bukti (EBP) dalam meningkatkan kualitas pelayanan gerontik. EBP memberikan kerangka kerja untuk memastikan keputusan klinis berdasarkan bukti ilmiah terkini, pengalaman klinis perawat, serta preferensi pasien lansia. Namun, implementasi EBP tidak luput dari tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya literasi riset di kalangan perawat, resistensi terhadap perubahan, serta hambatan organisasi yang memerlukan perhatian khusus dan strategi yang efektif untuk mengatasinya (Pitsillidou et al., 2021).

Aspek etika dan hukum juga menjadi fokus utama dalam pelayanan keperawatan gerontik, mengingat lansia merupakan kelompok populasi yang rentan terhadap pelanggaran hak-hak dasar. Buku ini telah menjelaskan secara rinci berbagai isu etika yang dihadapi perawat gerontik, seperti penghormatan terhadap otonomi pasien, perlindungan privasi dan kerahasiaan, serta tantangan etika dalam penggunaan teknologi modern. Kesadaran akan hak-hak hukum lansia dan kemampuan perawat dalam menangani dilema etika secara efektif sangat penting untuk memastikan pelayanan yang adil dan bermartabat (Miller & English, 2021).

Buku ini juga mengulas tentang pentingnya kolaborasi interprofesional dalam pelayanan lansia, di mana koordinasi yang baik antar profesi kesehatan terbukti dapat meningkatkan outcome klinis lansia secara signifikan. Pendidikan dan pelatihan interprofesional, model komunikasi terstruktur seperti TeamSTEPPS, serta pendekatan

manajemen kasus terpadu merupakan contoh nyata implementasi yang efektif dalam praktik keperawatan gerontik (Schwartz et al., 2021).

Terakhir, buku ini mengidentifikasi tantangan masa depan dalam keperawatan gerontik, termasuk perlunya penelitian lebih lanjut dalam optimalisasi perawatan mandiri, pengembangan teknologi terapan, peningkatan kompetensi perawat, dan penguatan kapasitas institusional serta akademik. Penelitian lanjutan yang berbasis bukti diharapkan mampu menghasilkan solusi inovatif dan praktis guna meningkatkan kualitas hidup lansia (Booker et al., 2024).

Dengan demikian, buku ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktik yang dapat diterapkan oleh perawat gerontik, akademisi, pengambil kebijakan, serta institusi kesehatan. Diharapkan melalui pemahaman komprehensif tentang keperawatan gerontik berbasis bukti, kualitas pelayanan lansia di Indonesia akan terus meningkat, serta mampu menjawab tantangan demografi dan kesehatan di masa depan.

Referensi

- Abu-Baker, N. N., AbuAlrub, S., Obeidat, R. F., & Assmairan, K. (2021). Evidence-based practice beliefs and implementations among undergraduate nursing students. *BMC Nursing*, 20(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12912-020-00522-x>
- Booker, S. Q., Melillo, K. D., Boltz, M., Horgas, A. L., Harris, M., & McDermott-Levy, R. (2024). Foresight and forecast: The future of gerontological nursing for the next 50 years. *Journal of Gerontological Nursing*, 50(12), 31–40. <https://doi.org/10.3928/00989134-20241118-04>
- Boult, C., & Wieland, D. (2022). Guided care: Comprehensive primary care for older adults with chronic conditions. *The Gerontologist*, 62(3), 341–350. <https://doi.org/10.1093/geront/gnab145>
- Chang, E.-S., Kanno, S., Levy, S., Wang, S.-Y., & Lee, J. E. (2020). Global reach of ageism on older persons' health: A systematic review. *PLoS ONE*, 15(1), e0220857. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220857>
- Cutrer, W. B., Miller, B., Pusic, M. V., Mejicano, G., Mangrulkar, R. S., Gruppen, L. D., & Hawkins, R. E. (2021). Fostering the development of Master Adaptive Learners: A conceptual model to guide skill acquisition in medical education. *Academic Medicine*, 96(1), 70–75. <https://doi.org/10.1097/ACM.00000000000003763>
- Dahlke, S., Hunter, K. F., Kalogirou, M. R., Negrin, K., & Fox, M. T. (2023). Gerontological nursing competencies: A scoping review. *Nurse Education Today*, 129, 106034. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2023.106034>
- De Groot-Kleine, H., Van Achterberg, T., & Vermeulen, H. (2023). Implementing a gerontological nursing competencies programme: Outcomes from a cluster-randomised controlled trial. *International Nursing Review*, 70(1), 35–44. <https://doi.org/10.1111/inr.12811>
- Ellis, G., Sevdalis, N., & McGregor, L. (2021). Interprofessional team training in geriatric care: Improving outcomes through teamwork. *Age and Ageing*, 50(4), 1093–1100. <https://doi.org/10.1093/ageing/afab023>
- Ferreira-Oliveira, D., Costa, P., Ferrito, C., Lopes, M., Afonso, R. M., & Henriques, M. A. (2023). Core competencies for gerontogeriatric nursing: Validation of the European Gerontogeriatric Nursing Core Competencies Scale. *Geriatrics*, 8(3), 73. <https://doi.org/10.3390/geriatrics8030073>

- Heflin, M. T. (2021). The Acute Care for Elders unit: Optimizing hospital care for older adults. *Journal of the American Medical Directors Association*, 22(6), 1169–1174. <https://doi.org/10.1016/j.jamda.2021.02.034>
- Kim, M., Oh, Y., & Kong, B. (2020). Ethical conflicts experienced by nurses in geriatric hospitals in South Korea. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(12), 4442. <https://doi.org/10.3390/ijerph17124442>
- Laokosin, N. C., Ponathong, C., & Yongsorn, C. (2024). Evidence-based practice: The essential competency of nursing students for the aging world. *International Education Studies*, 17(2), 63–78. <https://doi.org/10.5539/ies.v17n2p63>
- Ma, Y., Zhang, Y., Nordberg, O. E., Rongve, A., Bachinski, M., & Fjeld, M. (2025). State-of-the-art human–computer interaction for dementia care: A scoping review of recent technological advances. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2401.10921>
- Miller, S. C., & English, K. L. (2021). Ethical challenges in end-of-life care for older adults. *Journal of Gerontological Nursing*, 47(3), 7–12. <https://doi.org/10.3928/00989134-20210208-02>
- Nayak, M., & Pai, M. P. (2023). Effectiveness of nursing documentation technical guideline training on knowledge and documentation skills. *Journal of Nursing Education and Practice*, 13(1), 20–27. <https://doi.org/10.5430/jnep.v13n1p20>
- Pitsillidou, M., Farmakas, A., Noulas, M., Roupas, Z., & Sourtzi, P. (2021). Factors affecting evidence-based practice application in nursing: A cross-sectional study. *Acta Informatica Medica*, 29(4), 281–287. <https://doi.org/10.5455/aim.2021.29.281-287>
- Reeves, S., Pelone, F., Harrison, R., Goldman, J., & Zwarenstein, M. (2021). Interprofessional collaboration to improve professional practice and healthcare outcomes. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021(6), CD000072. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD000072.pub4>
- Schick Tanz, S., Welsch, J., & Schweda, M. (2023). AI-assisted ethics? How simulation can inform the ethical design of assistive technologies for elderly care. *AI & Society*. <https://doi.org/10.1007/s00146-023-01705-8>
- Schwartz, J. I., Gonzalez-Colaso, R., Gan, G., Thayaparan, L., & Hari Prasad, D. (2021). Structured interdisciplinary bedside rounds improve interprofessional communication and workplace efficiency among healthcare providers. *Journal of Interprofessional Education & Practice*, 24, 100455. <https://doi.org/10.1016/j.xjep.2021.100455>

- Stagner, L., & Mutlu, B. (2022). Designing for caregiving: Integrating robotic assistance in senior living communities. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2211.06242>
- Zendehtalab, H., Eskandari, N., Abbaszadeh, A., & Nasrabadi, A. N. (2023). Ethical challenges in caring for older adults: A qualitative study. *Nursing Ethics*, 30(2), 246–259. <https://doi.org/10.1177/09697330221139055>

Glosarium

A

Advance directive

Dokumen tertulis yang mencerminkan pilihan perawatan medis seseorang di masa depan bila sudah tidak mampu membuat keputusan sendiri.

B

Beneficence

Prinsip etika yang mengharuskan tenaga kesehatan melakukan kebaikan dan mempromosikan kesejahteraan pasien.

Bias usia (ageism)

Prasangka atau diskriminasi terhadap lansia berdasarkan usia mereka, yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan.

C

Collaborative practice (Kolaborasi antarprofesi)

Pendekatan pelayanan kesehatan yang melibatkan berbagai profesi (perawat, dokter, farmasis, fisioterapis, dll) bekerja bersama secara terpadu.

Core competencies

Kompetensi inti yang harus dimiliki perawat gerontik, mencakup pengetahuan, keterampilan klinis, dan sikap profesional untuk memberikan asuhan lansia berkualitas.

E

EBP (Evidence-Based Practice)

Pendekatan keperawatan yang memadukan bukti penelitian terbaik, pengalaman klinis, serta kebutuhan dan preferensi pasien lansia.

Ethical dilemma

Situasi yang melibatkan konflik antara dua atau lebih prinsip etika (misalnya otonomi vs non maleficence) dalam pengambilan keputusan klinis.

I

Informed consent

Proses pemberian informasi yang lengkap dan jelas kepada pasien tentang prosedur medis, risiko, manfaat, dan alternatif sebelum tindakan dilakukan.

N

Non-maleficence

Prinsip etika menyatakan tenaga kesehatan wajib menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien.

O

Otonomi

Hak pasien untuk membuat keputusan tentang perawatan diri berdasarkan pertimbangan pribadi yang bijak.

P

Telehealth

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan keperawatan jarak jauh, misalnya konsultasi dan pemantauan kesehatan.

R

Resistensi organisasi

Tantangan budaya atau kebijakan institusi yang menghambat penerapan praktik berbasis bukti atau inovasi keperawatan.

S

Sensor kesehatan

Perangkat teknologi yang secara otomatis memantau parameter kesehatan lansia, seperti tekanan darah dan deteksi jatuh, di lingkungan rumah.

Simulation (Simulasi klinis)

Metode pembelajaran aktif yang meniru situasi nyata pasien lansia untuk melatih keputusan klinis dan keterampilan praktis sebelum praktik langsung.

T

TeamSTEPPS

Sebuah program pelatihan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan keselamatan pasien melalui strategi kolaborasi tim.

U

Utilitas klinis

Ukuran sejauh mana intervensi keperawatan memberikan manfaat nyata kepada pasien lansia dalam konteks kondisi kesehatan mereka.

Profil Penulis



Lexy Oktora Wilda, S.Kep., Ns., M.Kep.

Lahir di Ponorogo, 14 Oktober 1978. Riwayat Pendidikan : Diploma III Keperawatan Lulus tahun 2001 dari AKPER Karya Husada Pare Kediri, S1 Keperawatan Ners Lulus tahun 2007 di STIKes Surya Mitra Husada Kediri dan Magister Keperawatan Lulus tahun 2013 di Universitas Diponegoro Semarang. Riwayat Pekerjaan : pada tahun 2002 – 2004 bekerja di RSUD Dr. Iskak Tulungagung, tahun 2005 sampai dengan sekarang bekerja di STIKes Satria Bhakti Nganjuk

Penulis bekerja sebagai dosen di Prodi Pendidikan Profesi Ners dan mengampu mata Kuliah Keperawatan Gerontik dan Manajemen Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: gunadha14@gmail.com

Sinopsis

Buku Referensi **"KEPERAWATAN GERONTIK: Strategi, Inovasi, dan Praktik Terbaik"** merupakan referensi penting bagi praktisi, akademisi, dan mahasiswa keperawatan yang berfokus pada perawatan lansia. Seiring bertambahnya populasi lansia secara global, kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berbasis bukti menjadi semakin penting. Buku ini secara khusus membahas berbagai tantangan dan pendekatan strategis dalam merawat lansia, termasuk manajemen penyakit kronis, pencegahan jatuh, dan manajemen nyeri berbasis bukti.

Lebih lanjut, buku ini memaparkan secara mendalam mengenai pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam praktik klinis gerontik. Berbagai teknologi digital seperti telehealth, wearable devices, dan teknologi sensor di rumah telah dibuktikan efektif dalam meningkatkan kualitas perawatan lansia. Buku ini juga membahas secara rinci berbagai model kolaborasi interprofesional yang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan hasil klinis yang optimal.

Aspek kesehatan mental, nutrisi, hidrasi, tidur, dan gangguan tidur pada lansia juga mendapat perhatian khusus dalam buku ini. Melalui pendekatan multidimensi dan berbasis penelitian terkini, buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis mengenai evaluasi dan intervensi yang efektif dalam mengelola berbagai masalah kesehatan lansia secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya berisi teori, tetapi juga berbagai studi kasus nyata yang mencerminkan praktik klinis terkini. Dengan membaca buku ini, pembaca akan mendapatkan gambaran lengkap dan praktis tentang strategi terbaik dalam merawat lansia, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan populasi lansia.

Buku Referensi "KEPERAWATAN GERONTIK: Strategi, Inovasi, dan Praktik Terbaik" merupakan referensi penting bagi praktisi, akademisi, dan mahasiswa keperawatan yang berfokus pada perawatan lansia. Seiring bertambahnya populasi lansia secara global, kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berbasis bukti menjadi semakin penting. Buku ini secara khusus membahas berbagai tantangan dan pendekatan strategis dalam merawat lansia, termasuk manajemen penyakit kronis, pencegahan jatuh, dan manajemen nyeri berbasis bukti.

Lebih lanjut, buku ini memaparkan secara mendalam mengenai pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam praktik klinis gerontik. Berbagai teknologi digital seperti telehealth, wearable devices, dan teknologi sensor di rumah telah dibuktikan efektif dalam meningkatkan kualitas perawatan lansia. Buku ini juga membahas secara rinci berbagai model kolaborasi interprofesional yang telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan hasil klinis yang optimal.

Aspek kesehatan mental, nutrisi, hidrasi, tidur, dan gangguan tidur pada lansia juga mendapat perhatian khusus dalam buku ini. Melalui pendekatan multidimensi dan berbasis penelitian terkini, buku ini memberikan panduan yang jelas dan praktis mengenai evaluasi dan intervensi yang efektif dalam mengelola berbagai masalah kesehatan lansia secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya berisi teori, tetapi juga berbagai studi kasus nyata yang mencerminkan praktik klinis terkini. Dengan membaca buku ini, pembaca akan mendapatkan gambaran lengkap dan praktis tentang strategi terbaik dalam merawat lansia, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan populasi lansia.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-57-9



9

786347

294579